Optimal Untuk Negeri

optimal

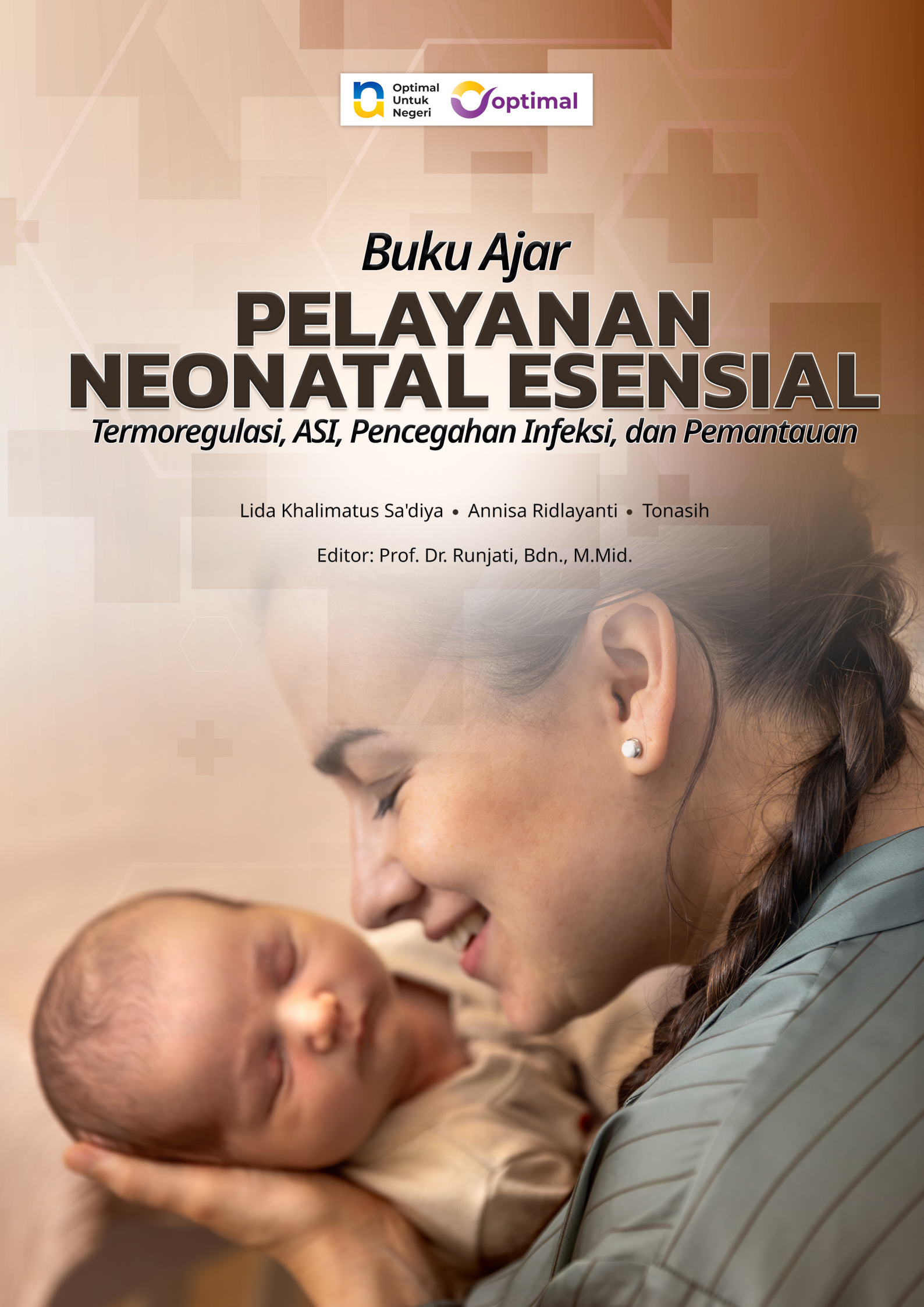
Buku Ajar

PELAYANAN NEONATAL ESENSIAL

Termoregulasi, ASI, Pencegahan Infeksi, dan Pemantauan

Lida Khalimatus Sa'diya • Annisa Ridlayanti • Tonasih

Editor: Prof. Dr. Runjati, Bdn., M.Mid.



Buku Ajar :

Pelayanan Neonatal Esensial: Termoregulasi, ASI, Pencegahan Infeksi, dan Pemantauan

Penulis:
Lida Khalimatus Sa'diya, SSiT., Bd., M.Kes.
Annisa Ridlayanti, S.Keb., Bd., M.Keb.
Tonasih, SST., M.Kes.

Editor: Prof. Dr. Runjati, Bdn., M.Mid.

Optimal
Untuk
Negeri

Buku Ajar:

Pelayanan Neonatal Esensial: Termoregulasi, ASI, Pencegahan Infeksi, dan Pemantauan

Penulis:
Lida Khalimatus Sa'diya, SSiT., Bd., M.Kes.
Annisa Ridlayanti, S.Keb., Bd., M.Keb.
Tonasih, SST., M.Kes.

Editor: Prof. Dr. Runjati, Bdn., M.Mid.

Desain Sampul: Ivan Zumarano
Penata Letak: Khoirul Anam

ISBN: 978-634-7927-02-6

Cetakan Pertama: September, 2026
Hak Cipta 2026
Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
Copyright © 2026
by Penerbit PT Optimal Untuk Negeri
All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.
Website : optimaluntuknegeri.com
Instagram : @bimbel.optimal
Tiktok : @maskokooo

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI
Kencana Tower Lt. Mezzanine
Jl. Raya Meruya Ilir No. 88
RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta
Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025

Kata Pengantar

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku ajar berjudul *Pelayanan Neonatal Esensial: Termoregulasi, ASI, Pencegahan Infeksi, dan Pemantauan* dapat disusun dengan baik. Buku ajar ini disusun sebagai salah satu sumber pembelajaran bagi mahasiswa, dosen, dan tenaga kesehatan dalam memahami konsep dasar serta praktik pelayanan neonatal esensial, khususnya pada aspek pemantauan kondisi neonatus, edukasi orang tua, serta deteksi dini tanda bahaya pada bayi baru lahir.

Masa neonatal merupakan periode yang sangat penting dalam kehidupan bayi karena pada masa ini bayi sedang beradaptasi dengan lingkungan di luar rahim. Oleh karena itu, pelayanan neonatal yang tepat, terarah, dan berkesinambungan sangat diperlukan untuk mendukung kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan bayi secara optimal. Tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan yang komprehensif, mulai dari menjaga suhu tubuh bayi, mendukung keberhasilan pemberian Air Susu Ibu (ASI), mencegah infeksi, hingga melakukan pemantauan tanda-tanda klinis yang dapat mengarah pada kondisi kegawatdaruratan.

Buku ajar ini disusun secara sistematis ke dalam beberapa bab. Bab 1 membahas tentang kunjungan neonatus terjadwal, parameter pemantauan, serta deteksi dini tanda bahaya pada neonatus. Bab ini diharapkan dapat membantu pembaca memahami pentingnya kunjungan neonatal sebagai upaya pemantauan kesehatan bayi secara berkala. Bab 2 menguraikan pemantauan pertumbuhan neonatus, meliputi berat badan, pola eliminasi, dan status hidrasi. Pembahasan ini penting untuk mengenali kondisi bayi secara menyeluruh dan mendeteksi kemungkinan gangguan sejak dini. Bab 3 membahas edukasi orang tua mengenai perawatan bayi di rumah, tanda bahaya yang perlu diwaspadai, serta waktu yang tepat untuk kembali ke fasilitas pelayanan kesehatan. Melalui bab ini, pembaca diharapkan mampu memahami pentingnya pemberdayaan keluarga dalam mendukung kesehatan neonatus.

Penyusunan buku ajar ini diharapkan dapat membantu proses pembelajaran menjadi lebih terarah, aplikatif, dan sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan. Selain itu, buku ini juga diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan neonatal yang aman, bermutu, dan berpusat pada kebutuhan bayi serta keluarga.

Penulis menyadari bahwa buku ajar ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi isi, penyajian, maupun kedalaman pembahasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan buku ini pada edisi berikutnya.

Semoga buku ajar ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa, dosen, tenaga kesehatan, serta semua pihak yang berperan dalam pelayanan kesehatan neonatal.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan kontribusi dalam proses penyusunan buku ajar ini. Semoga buku ini dapat menjadi salah satu kontribusi positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan peningkatan kualitas pelayanan neonatal di Indonesia.

Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar ..... **iii**
Daftar Isi ..... **v**

BAB 1 KUNJUNGAN NEONATUS TERJADWAL, PARAMETER PEMANTAUAN DAN DETEKSI DINI TANDA BAHAYA **1**
A. KUNJUNGAN NEONATUS 5
B. Pemeriksaan Fisik pada Neonatus 8
C. Tanda Bahaya Neonatus 8
D. Parameter Pemantauan Pada Neonatus 8
E. Deteksi Dini Tanda Bahaya Pada Neonatus 12
F. Ringkasan 32
Referensi **36**

BAB 2 PEMANTAUAN PERTUMBUHAN NEONATUS: BERAT BADAN, POLA ELIMINASI, DAN STATUS HIDRASI **38**
A. Pemantauan Pertumbuhan Neonatus: Berat Badan, Pola Eliminasi, dan Status Hidrasi 42
B. Ringkasan 68
Referensi **72**

BAB 3 EDUKASI ORANG TUA: PERAWATAN BAYI DI RUMAH, TANDA BAHAYA, DAN KAPAN KEMBALI KE FASYANKES **73**
A. Komunikasi, Infromasi, dan Edukasi (KIE) 79
B. Perawatan Bayi di Rumah 79
C. Tanda Bahaya Bayi 103
D. Ringkasan 121
Referensi **126**

Profil Penulis **128**

BAB 1

KUNJUNGAN NEONATUS TERJADWAL, PARAMETER PEMANTAUAN DAN DETEKSI DINI TANDA BAHAYA

A. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menunjukkan profesionalisme, etika, dan tanggung jawab legal dalam pelayanan neonatal esensial.	CPMK-1; CPMK-3; CPMK-7
CPL-2	Menerapkan komunikasi terapeutik dan edukasi yang memberdayakan orang tua/keluarga dalam perawatan neonatus.	CPMK-1; CPMK-5; CPMK-6; CPMK-7
CPL-3	Menerapkan keselamatan pasien, pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI), serta K3 pada setiap tindakan neonatal.	CPMK-1; CPMK-3; CPMK-4; CPMK-7
CPL-4	Melakukan pengkajian dan clinical reasoning pada adaptasi fisiologis neonatus untuk mengenali kondisi normal, risiko, dan tanda bahaya.	CPMK-2; CPMK-4; CPMK-7
CPL-5	Melaksanakan keterampilan pelayanan neonatal esensial (termoregulasi, ASI, pencegahan infeksi, pemantauan) secara aman dan bermutu.	CPMK-3; CPMK-4; CPMK-5; CPMK-6; CPMK-7
CPL-6	Melaksanakan dokumentasi, kolaborasi, rujukan/balik rujuk, dan kontinuitas asuhan neonatus berbasis bukti.	CPMK-1; CPMK-7

B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan standar, etika, keselamatan, PPI, dan alur pelayanan neonatal esensial serta peran tenaga kesehatan dalam koordinasi layanan dan edukasi keluarga.
CPMK-2	Menganalisis adaptasi fisiologis neonatus (pernapasan, sirkulasi, termoregulasi) dan menginterpretasi parameter klinis dasar untuk pengambilan keputusan awal.
CPMK-3	Melaksanakan asuhan segera setelah lahir yang aman (pengeringan, kontak kulit, IMD) serta pencegahan hipotermia dan infeksi dasar sesuai SOP.
CPMK-4	Melakukan penilaian risiko termal dan melaksanakan pencegahan serta tata laksana awal hipotermia pada neonatus sesuai pedoman.
CPMK-5	Menilai proses menyusu dan menerapkan praktik pemberian ASI pada neonatus (perlekatan, frekuensi, tanda cukup ASI) disertai edukasi keluarga.
CPMK-6	Memberikan dukungan menyusui dan melakukan pemecahan masalah awal laktasi secara sistematis serta menentukan kebutuhan tindak lanjut/rujukan.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-7	Melaksanakan pemantauan neonatus terjadwal (pertumbuhan, eliminasi, hidrasi, respirasi, sirkulasi), deteksi dini tanda bahaya, skrining risiko, dokumentasi, serta rujukan/balik rujuk untuk kontinuitas asuhan.

C. Pemetaan

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 1. Kunjungan Neonatus Terjadwal: Parameter Pemantauan dan Deteksi Dini Tanda Bahaya	1.1 Menyusun rencana kunjungan neonatus terjadwal dan memilih parameter pemantauan sesuai usia.	1.2 Melakukan deteksi dini tanda bahaya pada kunjungan dan menentukan tindak lanjut (edukasi, observasi, rujukan).	CPMK-7	CPMK-1; CPMK-2

D. Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-1	Ujian tulis (MCQ/SAQ); Observasi komunikasi & profesional (rubrik)	Skor ujian standar/etik/PPI ≥70%; skor komunikasi terstruktur & profesional ≥3 (skala 1–4)	15	Lembar jawaban; rubrik observasi
CPMK-2	Ujian kasus tertulis; interpretasi parameter klinis (lembar kerja)	Ketepatan interpretasi parameter (RR/HR/suhu/CRT/warna) ≥75%; analisis hubungan temuan–mekanisme–tindakan awal ≥3 (skala 1–4)	15	Jawaban studi kasus; lembar interpretasi
CPMK-7	OSCE/mini-CEX kunjungan neonatus; Portofolio pemantauan (checklist)	Kelengkapan pengkajian & pencatatan parameter ≥85%; keputusan tindak lanjut/rujukan tepat ≥3 (skala 1–4); kelengkapan dokumentasi/format rujukan ≥80%	20	Portofolio kunjungan; lembar pemantauan; dokumentasi SOAP/rujukan

Rubrik CPMK-1

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1 Kepatuhan etika, keselamatan pasien, dan PPI	Banyak pelanggaran; langkah keselamatan/PPI	Sebagian diterapkan; ada kesalahan minor	Hampir seluruhnya patuh; kesalahan sangat minimal	Konsisten patuh; proaktif mengidentifikasi risiko

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
pada skenario pelayanan	sering terlewat; perlu arahan penuh	berisiko; perlu koreksi	dan segera diperbaiki	dan mencegah tanpa diingatkan
1.2 Kejelasan komunikasi edukatif & koordinasi terstruktur	Informasi tidak lengkap/tidak terstruktur; tidak memastikan pemahaman	Informasi cukup namun kurang terstruktur; konfirmasi pemahaman terbatas	Terstruktur dan jelas; bahasa sesuai; melakukan cek balik pemahaman	Sangat jelas, empatik, terarah; melibatkan keluarga; kesepakatan tindak lanjut dinyatakan tegas

Rubrik CPMK-2

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Interpretasi parameter respirasi/sirkulasi/suhu (normal vs abnormal)	Interpretasi banyak salah; tidak membedakan normal–abnormal	Benar sebagian; masih salah pada beberapa parameter kunci; perlu bantuan	Mayoritas benar; kesalahan minor tidak mengubah kesimpulan utama	Akurat dan cepat; mengintegrasikan beberapa parameter untuk kesimpulan tepat
2.2 Penalaran hubungan mekanisme adaptasi–temuan–tindakan awal	Penalaran tidak logis; tidak terhubung dengan mekanisme	Hubungan sebab-akibat kurang lengkap; tindakan awal kurang tepat	Logis dan relevan; tindakan awal sesuai berdasarkan temuan	Mendalam; mempertimbangkan alternatif/risiko; justifikasi tindakan awal sangat kuat

Rubrik CPMK-3

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Urutan dan ketepatan tindakan asuhan segera setelah lahir	Urutan salah/ada langkah kritis terlewat; teknik tidak aman	Urutan cukup namun ada langkah kritis kurang tepat; perlu arahan	Urutan tepat; teknik aman; hanya kesalahan minor	Sangat tepat dan efisien; mengantisipasi masalah sejak awal; teknik aman konsisten
3.2 Implementasi kontak kulit/IMD serta pencegahan hipotermia & infeksi dasar	Kontak kulit/IMD tidak dilakukan/keliru; pencegahan tidak adekuat	Dilakukan sebagian; durasi/teknik kurang; kontrol suhu/aseptik belum konsisten	Sesuai SOP; menjaga kehangatan dan aseptik; monitoring dasar dilakukan	Optimal; menjaga kehangatan proaktif; IMD terfasilitasi baik; pencegahan infeksi sangat konsisten

Rubrik CPMK-4

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Identifikasi faktor risiko dan strategi pencegahan hipotermia	Risiko tidak teridentifikasi; strategi tidak sesuai	Mengidentifikasi sebagian; strategi masih umum/kurang kontekstual	Mengidentifikasi mayoritas risiko; strategi sesuai konteks	Komprehensif; prioritas tepat; strategi spesifik mempertimbangkan sumber daya
4.2 Tata laksana awal hipotermia, monitoring respons, dan keputusan rujukan	Pemanasan tidak tepat/berbahaya; monitoring tidak ada; keputusan keliru	Pemanasan cukup namun tidak sistematis; monitoring kurang lengkap; keputusan kurang tepat	Sistematis sesuai pedoman; monitoring memadai; keputusan rujukan tepat	Sangat tepat dan aman; monitoring lengkap dengan evaluasi respons; komunikasi rujukan jelas

Rubrik CPMK-5

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Penilaian perlekatan/posisi menyusu dan koreksi	Tidak mampu menilai; koreksi tidak diberikan	Menilai sebagian; koreksi kurang spesifik; masalah masih menetap	Menilai tepat; koreksi spesifik; perlekatan/posisi membaik	Sangat akurat; mengajarkan keterampilan pada ibu/keluarga; hasil optimal dan berkelanjutan
5.2 Penilaian frekuensi menyusu & tanda cukup ASI disertai edukasi	Penilaian keliru; edukasi tidak relevan	Penilaian umum; sebagian benar namun kurang individual	Sesuai kondisi bayi; indikator klinis dinilai benar; edukasi jelas	Sangat tepat berbasis data; edukasi terpersonalisasi dengan rencana tindak lanjut

Rubrik CPMK-6

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Identifikasi penyebab masalah menyusui berbasis data pengkajian	Tidak teridentifikasi; data tidak digunakan	Sebagian teridentifikasi; penyebab utama masih salah; perlu bantuan	Tepat berdasarkan data; membedakan beberapa penyebab yang mungkin	Komprehensif; memprioritaskan penyebab utama dan faktor pendukung secara tepat
6.2 Rencana intervensi,	Intervensi tidak sesuai/berisiko;	Intervensi cukup namun kurang sistematis; tindak	Intervensi sesuai; tindak lanjut jelas;	Sangat efektif dan memberdayakan; tindak lanjut terjadwal;

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
dukungan, tindak lanjut/rujukan	tidak ada tindak lanjut	lanjut/rujukan belum jelas	rujukan sesuai indikasi	rujukan disertai komunikasi lengkap

Rubrik CPMK-7

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Kelengkapan pemantauan kunjungan neonatus dan pencatatan parameter	Banyak parameter tidak diukur/dicatat	Parameter dasar ada, namun kekurangan penting; catatan kurang rapi	Lengkap sesuai usia; catatan rapi dan dapat ditelusuri	Sangat lengkap dan konsisten; menginterpretasi tren/perubahan; catatan sangat akurat
7.2 Deteksi dini tanda bahaya/risiko, keputusan tindakan, dan dokumentasi	Tidak mengenali risiko; keputusan tidak tepat; dokumentasi tidak ada	Mengenali sebagian; keputusan kurang tepat; dokumentasi/rujukan belum lengkap	Mengenali dan bertindak tepat (edukasi/observasi/rujukan); dokumentasi lengkap	Deteksi sangat dini dan tepat; keputusan cepat-aman; komunikasi rujukan/balik rujuk sangat jelas dan terdokumentasi

A. KUNJUNGAN NEONATUS

1. Pengertian Neonatus

   Neonatus adalah bayi baru lahir yang berusia 0–28 hari. Masa neonatus merupakan periode paling rentan karena terjadi proses adaptasi kehidupan dari intrauterin ke ekstrauterin, sehingga membutuhkan pemantauan secara berkala.

2. Pengertian Kunjungan Neonatus Terjadwal

   Kunjungan neonatus terjadwal adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan pada bayi baru lahir secara sistematis sesuai jadwal untuk memantau pertumbuhan, perkembangan, mendeteksi dini komplikasi, serta memberikan edukasi kepada keluarga.

3. Tujuan Kunjungan Neonatus
   a. Menilai kondisi kesehatan bayi secara umum.
   b. Mendeteksi dini tanda bahaya pada neonatus.
   c. Memantau pertumbuhan dan perkembangan bayi.
   d. Memberikan imunisasi sesuai jadwal.

e. Memberikan edukasi kepada ibu dan keluarga tentang perawatan bayi baru lahir.
f. Menurunkan angka kesakitan dan kematian neonatal.

4. Kunjungan Neonatus Terjadwal

Neonatus adalah bayi yang berusia 0–28 hari setelah lahir. Masa ini merupakan periode paling kritis karena sebagian besar kematian bayi terjadi pada minggu pertama kehidupan. Oleh karena itu diperlukan pemantauan kesehatan bayi secara rutin melalui kunjungan neonatus oleh tenaga kesehatan. Kunjungan neonatus merupakan bagian dari pelayanan kesehatan ibu dan anak yang bertujuan untuk memastikan adaptasi bayi terhadap kehidupan di luar rahim berjalan normal serta mendeteksi secara dini adanya kelainan atau komplikasi.

Kunjungan neonatus adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan kepada bayi baru lahir melalui pemeriksaan langsung di fasilitas kesehatan maupun melalui kunjungan rumah. Kegiatan ini meliputi pemeriksaan kondisi fisik bayi, pemantauan pertumbuhan, pemberian konseling kepada ibu mengenai perawatan bayi serta identifikasi tanda bahaya pada neonatus.

Menurut pedoman pelayanan kesehatan ibu dan anak, kunjungan neonatus minimal dilakukan tiga kali selama periode 0–28 hari, yaitu:

a. Kunjungan Neonatus 1 (KN 1)

Dilakukan pada usia 6–48 jam setelah lahir.

Tujuan:

- Menilai adaptasi bayi setelah lahir.
- Memastikan bayi dapat bernapas dengan baik.
- Menilai suhu tubuh.

Pemeriksaan:

- Tanda vital (RR, nadi, suhu)
- Warna kulit
- Berat badan lahir
- Refleks dasar
- Pemeriksaan tali pusat
- Inisiasi menyusu dini (IMD)

Intervensi:

- Vitamin K
- Salep mata antibiotik
- Imunisasi Hepatitis B vaccine (HB-0)
- Edukasi ASI eksklusif

b. Kunjungan Neonatus 2 (KN 2)
   Dilakukan pada usia 3–7 hari.
   Tujuan:
   - Menilai pertumbuhan awal bayi
   - Menilai keberhasilan menyusui
   - Deteksi ikterus dan infeksi

   Pemeriksaan:
   - Berat badan
   - Pola menyusu
   - Frekuensi BAK dan BAB
   - Tanda ikterus
   - Kondisi tali pusat

   Intervensi:
   - Konseling perawatan tali pusat
   - Edukasi menjaga kehangatan bayi
   - Edukasi tanda bahaya neonatus

c. Kunjungan Neonatus 3 (KN 3)
   Dilakukan pada usia 8–28 hari.
   Tujuan:
   - Memantau tumbuh kembang bayi
   - Evaluasi pemberian ASI
   - Deteksi dini masalah kesehatan

   Pemeriksaan:
   - Berat badan dan panjang badan
   - Lingkar kepala
   - Pemeriksaan fisik lengkap
   - Refleks neonatus
   - Pola tidur dan aktivitas

   Intervensi:
   - Konseling ASI eksklusif
   - Edukasi stimulasi dini
   - Persiapan imunisasi berikutnya

B. Pemeriksaan Fisik pada Neonatus

1. Keadaan umum: aktif, menangis kuat.
2. Tanda vital:
   a. Suhu: 36,5–37,5°C
   b. Nadi: 120–160 x/menit
   c. RR: 30–60 x/menit
3. Kepala: ubun-ubun, moulding, caput.
4. Mata: konjungtiva, refleks cahaya.
5. Mulut: refleks hisap.
6. Dada: pola napas.
7. Abdomen: tali pusat.
8. Genitalia: normal/tidak.
9. Ekstremitas: kelainan bawaan.
10. Refleks: Moro, rooting, sucking, grasping.

C. Tanda Bahaya Neonatus

Segera dirujuk bila ditemukan:

1. Tidak mau menyusu
2. Kejang
3. Napas cepat (>60x/menit)
4. Tarikan dinding dada
5. Demam/hipotermia
6. Kulit kuning sampai telapak tangan/kaki
7. Tali pusat bernanah
8. Letargi
9. Diare atau muntah berulang

D. Parameter Pemantauan Pada Neonatus

1. Pengertian Pemantauan Neonatus

   Pemantauan neonatus adalah kegiatan observasi dan penilaian kondisi bayi baru lahir usia 0–28 hari secara berkala untuk mengetahui status kesehatan, mendeteksi dini adanya kelainan atau komplikasi, serta memastikan proses adaptasi bayi berjalan normal.
2. Tujuan Pemantauan Neonatus
   a. Menilai keberhasilan adaptasi bayi dari kehidupan intrauterin ke ekstrauterin.
   b. Mendeteksi dini masalah kesehatan atau tanda bahaya neonatus.
   c. Memantau pertumbuhan dan perkembangan bayi.

d. Menilai kecukupan nutrisi dan keberhasilan menyusui.
e. Mencegah morbiditas dan mortalitas neonatal.

3. Parameter Pemantauan pada Neonatus
   a. Keadaan Umum
      Menilai kondisi umum bayi:
      - Aktif atau lemah
      - Menangis kuat
      - Respons terhadap rangsangan baik
      - Warna kulit normal (merah muda)

      Interpretasi:
      - Normal: bayi aktif, menangis kuat, tonus otot baik
      - Tidak normal: letargi, hipotonia, tidak responsif

   b. Tanda Vital
      1) Suhu Tubuh
         Normal: 36,5°C–37,5°C
         Pemantauan:
         - Hipotermia: <36,5°C
         - Hipertermia: >37,5°C

         Tujuan: Menilai kemampuan bayi mempertahankan suhu tubuh.

   c. Frekuensi Napas
      Normal: **30–60 kali/menit**
      Observasi:
      - Pola napas teratur
      - Tidak ada retraksi dinding dada
      - Tidak ada napas cuping hidung

      Abnormal:
      - Takipnea >60x/menit
      - Apnea >20 detik

   d. Frekuensi Nadi
      Normal: **120–160 kali/menit**
      Abnormal:
      - Bradikardia <100 x/menit
      - Takikardia >160 x/menit

   e. Berat Badan
      Normal:
      - Berat lahir: **2500–4000 gram**

      Pemantauan:
      - Penurunan maksimal 10% pada minggu pertama

- Kembali ke berat lahir pada usia 10–14 hari

Tujuan: Menilai kecukupan nutrisi.

f. Panjang Badan

Normal:

- **48–52 cm**

Digunakan untuk memantau pertumbuhan linear bayi.

g. Lingkar Kepala

Normal:

- **33–35 cm**

Tujuan: Menilai pertumbuhan otak dan mendeteksi:

- Microcephaly
- Hydrocephalus

h. Warna Kulit

Normal:

- Merah muda

Abnormal:

- Sianosis → kebiruan
- Ikterus → kuning
- Pucat → anemia/syok

i. Nutrisi dan Pola Menyusu

Parameter:

- Frekuensi menyusu 8–12 kali/hari
- Refleks hisap baik
- Tidak muntah berlebihan

Tujuan: Menilai keberhasilan Breast milk eksklusif.

j. Eliminasi (BAK dan BAB)

BAK

Normal:

- Minimal 6 kali/hari setelah hari ke-4

BAB

Normal:

- Mekonium keluar dalam 24 jam pertama
- Warna berubah dari hitam → hijau → kuning

Tujuan: Menilai fungsi ginjal dan pencernaan.

k. Tali Pusat

Pemantauan:

- Bersih
- Kering

- Tidak berbau
- Tidak ada kemerahan

Normal:

- Lepas usia 5–14 hari

Tanda infeksi:

- Bernanah
- Perdarahan
- Kemerahan sekitar pusat

l. Refleks Neonatus

Refleks yang dinilai:

- Rooting reflex
- Sucking reflex
- Moro reflex
- Grasp reflex
- Babinski reflex

Tujuan: Menilai fungsi neurologis bayi.

m. Aktivitas dan Tonus Otot

Normal:

- Gerakan aktif
- Fleksi ekstremitas baik
- Tonus otot baik

Abnormal:

- Hipotonia
- Kejang
- Gerakan asimetris

n. Ikterus Neonatorum

Pemantauan:

- Waktu muncul
- Derajat kekuningan

Normal:

- Muncul setelah 24 jam (ikterus fisiologis)

Bahaya:

- Muncul <24 jam
- Menyebar sampai telapak tangan/kaki

4. Tanda Bahaya Saat Pemantauan Neonatus

Segera rujuk bila ditemukan:

- Tidak mau menyusu
- Sesak napas

- Kejang
- Demam/hipotermia
- Ikterus berat
- Letargi
- Tali pusat infeksi
- Berat badan turun terus

E. Deteksi Dini Tanda Bahaya Pada Neonatus

1. Pengertian

   Deteksi dini tanda bahaya pada neonatus adalah upaya mengenali secara cepat tanda atau gejala abnormal pada bayi usia 0–28 hari yang menunjukkan adanya masalah kesehatan serius sehingga dapat segera dilakukan penanganan atau rujukan.

   Masa neonatus merupakan periode kritis karena sebagian besar kematian bayi terjadi pada 28 hari pertama kehidupan, terutama pada minggu pertama.
2. Tujuan Deteksi Dini Tanda Bahaya Neonatus
   a. Menemukan kelainan atau komplikasi sedini mungkin.
   b. Mencegah perburukan kondisi bayi.
   c. Menurunkan angka kesakitan dan kematian neonatal.
   d. Menentukan kebutuhan tindakan segera atau rujukan.
   e. Memberikan edukasi kepada orang tua agar mampu mengenali tanda bahaya di rumah.
3. Tanda Bahaya pada Neonatus
   a. Tidak Mau Menyusu / Sulit Menyusu

      Tanda:
      - Bayi tidak mau mengisap
      - Refleks hisap lemah
      - Menyusu sangat sedikit

      Kemungkinan penyebab:
      - Infeksi
      - Hipoglikemia
      - Kelainan neurologis

      Tindakan:
      - Evaluasi segera
      - Rujuk bila menetap

b. Demam atau Hipotermia

Normal suhu: **36,5–37,5°C**

Tanda bahaya:

- Demam >37,5°C
- Hipotermia <36,5°C

Kemungkinan:

- Neonatal sepsis
- Paparan suhu lingkungan

Tindakan:

- Hangatkan bayi bila hipotermia
- Segera evaluasi penyebab

c. Gangguan Pernapasan

Normal: **30–60 kali/menit**

Tanda bahaya:

- Napas cepat >60x/menit
- Napas lambat <30x/menit
- Tarikan dinding dada
- Napas cuping hidung
- Merintih (grunting)
- Apnea (>20 detik)

Kemungkinan:

- Respiratory distress syndrome
- Pneumonia
- Asfiksia

d. Kejang

Tanda:

- Gerakan berulang tidak terkendali
- Mata mendelik
- Kaku mendadak

Kemungkinan:

- Hipoglikemia
- Infeksi
- Gangguan neurologis

Tindakan:

- Stabilkan jalan napas
- Rujuk segera

e. Ikterus (Kuning)

Tanda:

- Kulit dan mata kuning

Bahaya bila:

- Muncul <24 jam
- Menjalar sampai telapak tangan dan kaki
- Bayi tampak lemah

Kemungkinan:

- Neonatal jaundice patologis

Komplikasi:

- Kernicterus

f. Letargi / Bayi Sangat Lemah

Tanda:

- Tidur terus
- Sulit dibangunkan
- Tidak aktif

Kemungkinan:

- Infeksi
- Hipoksia
- Hipoglikemia

g. Sianosis

Tanda:

- Bibir/kulit kebiruan

Menunjukkan:

- Kekurangan oksigen

Penyebab:

- Kelainan jantung bawaan
- Gangguan paru

h. Muntah Berulang / Muntah Hijau

Tanda:

- Muntah terus-menerus
- Warna hijau

Kemungkinan:

- Obstruksi usus
- Infeksi

Tindakan:

- Segera rujuk

i. Diare atau Dehidrasi

Tanda:

- BAB cair sering
- Mulut kering
- Mata cekung
- BAK menurun

Bahaya:

- Dehidrasi berat

j. Infeksi Tali Pusat

Tanda:

- Kemerahan sekitar pusat
- Bengkak
- Bernanah
- Berbau

Kemungkinan:

- Omphalitis

Komplikasi:

- Sepsis

k. Perdarahan

Lokasi:

- Tali pusat
- Mulut
- Kulit

Penyebab:

- Defisiensi vitamin K
- Trauma lahir

Pencegahan:

- Pemberian Vitamin K saat lahir

4. Faktor Risiko Neonatus dengan Tanda Bahaya
   a. Bayi prematur
   b. Berat badan lahir rendah (BBLR)
   c. Asfiksia lahir
   d. Persalinan lama
   e. Ketuban pecah dini
   f. Infeksi maternal
   g. Kelainan kongenital

Deteksi dini melalui kunjungan neonatus sangat penting karena sebagian besar kematian bayi terjadi pada periode neonatal, sehingga pemeriksaan rutin

dan edukasi kepada orang tua mengenai tanda bahaya dapat meningkatkan keselamatan bayi.

Aktivitas 1 — *Knows How*

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Seorang bidan melakukan kunjungan neonatus kedua (KN2) pada bayi laki-laki usia 5 hari di rumah pasien. Bayi lahir cukup bulan dengan berat lahir 3200 gram melalui persalinan normal. Saat lahir bayi langsung menangis kuat dan tidak ada komplikasi.
Pada kunjungan tersebut ibu mengatakan bayinya menyusu sering tetapi terkadang terlihat rewel pada malam hari. Ibu juga mengatakan popok bayi sering basah dan bayi BAB 2–3 kali sehari dengan warna kekuningan.
Hasil pemeriksaan bidan menunjukkan keadaan umum bayi baik, suhu tubuh 36,8°C, frekuensi napas 44 kali/menit, dan denyut jantung 136 kali/menit. Berat badan bayi saat ini 3050 gram. Tali pusat masih menempel, tampak kering dan tidak berbau. Kulit bayi tampak sedikit kuning pada wajah hingga dada bagian atas. Refleks menghisap baik dan bayi aktif menyusu.
Bidan kemudian melakukan edukasi kepada ibu mengenai cara menyusui yang benar, perawatan tali pusat, serta tanda bahaya pada bayi baru lahir.

Pertanyaan Diskusi

1. Berdasarkan kasus di atas, apakah kondisi bayi pada kunjungan neonatus kedua masih dalam batas normal? Jelaskan alasannya.
2. Parameter apa saja yang harus dipantau oleh bidan pada kunjungan neonatus kedua pada bayi baru lahir?
3. Bagaimana interpretasi penurunan berat badan bayi pada kasus tersebut? Apakah masih dalam batas fisiologis?
4. Apakah ikterus yang dialami bayi kemungkinan merupakan ikterus fisiologis atau patologis? Jelaskan dasar penilaiannya.
5. Edukasi apa saja yang perlu diberikan bidan kepada ibu pada kunjungan neonatus kedua untuk menjaga kesehatan bayi baru lahir?
6. Sebutkan minimal 5 tanda bahaya pada neonatus yang harus dijelaskan kepada ibu agar segera membawa bayi ke fasilitas kesehatan.

TEMPLE SOAL OSCE KEBIDANAN

No.	Komponen	Isi
1	No. Stasiun	1
2	Judul	Pelayanan Neonatal Esensial
3	Kasus	Kunjungan Neonatus kedua
4	Tujuan	Untuk mengetahui bahwa peserta dapat menunjukkan kriteria sebagai calon bidan yang kompeten dalam:
5	Kompetensi	1. Anamnesis 2. **Pemeriksaan fisik dan/atau laboratorium sederhana** 3. **Perumusan diagnosis dan/atau masalah** 4. **Prosedur tindakan klinis** 5. KIE/konseling 6. Kolaborasi/rujukan 7. **Perilaku profesional**
6	Soal: Skenario dan tugas peserta ujian	SKENARIO KLINIK Seorang bidan melakukan kunjungan neonatus kedua (KN2) pada bayi laki-laki usia 5 hari di rumah pasien. Bayi lahir cukup bulan dengan berat lahir 3200 gram melalui persalinan normal. Saat lahir bayi langsung menangis kuat dan tidak ada komplikasi. Pada kunjungan tersebut ibu mengatakan bayinya menyusu sering tetapi terkadang terlihat rewel pada malam hari. Ibu juga mengatakan popok bayi sering basah dan bayi BAB 2–3 kali sehari dengan warna kekuningan. Hasil pemeriksaan bidan menunjukkan keadaan umum bayi baik, suhu tubuh 36,8°C, frekuensi napas 44 kali/menit, dan denyut jantung 136 kali/menit. Berat badan bayi saat ini 3050 gram. Tali pusat masih menempel, tampak kering dan tidak berbau. Kulit bayi tampak sedikit kuning pada wajah hingga dada bagian atas. Refleks menghisap baik dan bayi aktif menyusu. TUGAS 1. Lakukan anamnesis terarah sesuai kasus. 2. Lakukan pemeriksaan fisik sesuai kasus.

No.	Komponen	Isi
		3. Sampaikan diagnosis/masalah kebidanan berdasarkan data yang diperoleh. 4. Lakukan tindakan awal yang tepat pada kasus tersebut. 5. Berikan KIE singkat kepada ibu/keluarga
7	Instruksi penguji	INSTRUKSI UMUM 1. Pastikan identitas peserta ujian sesuai dengan kartu ujian. 2. Tulislah nomor peserta berdasarkan jumlah peserta yang ikut: a. Ujian institusi- 2 digit jika peserta berjumlah 01–99-3 digit jika peserta berjumlah 100–999-4 digit terakhir jika menggunakan NIM peserta b. Ujian nasional- 4 digit jika peserta berjumlah ribuan- atau 4 digit terakhir bila nomor mengikutkan kode area dan lebih dari 4 angka 3. Amati peserta dan beri penilaian pada lembar penilaian yang disesuaikan dengan format penilaian: - Actual mark (0/1/2/3) - Global rating (1/2/3/4) 4. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interaksi apa pun kepada peserta selain yang ditentukan. 5. Taatilah peraturan dan laksanakan tugas sebagai penguji OSCE. INSTRUKSI KHUSUS 1. Jika peserta melakukan anamnesis dengan benar, PS menjawab sesuai dialog PS. 2. Jika peserta menyatakan akan melakukan pemeriksaan fisik, PS menjawab sesuai data skenario 3. Tindakan awal yang diharapkan dari peserta meliputi: – Memeriksa tanda vital (suhu, napas, nadi) – Penilaian berat badan – Pemeriksaan ikterus (derajat kuning) – Pemeriksaan tali pusat – Refleks menghisap – Aktivitas bayi – Memberikan dukungan emosional dan KIE singkat

No.	Komponen	Isi
		4. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang ditentukan. 5. Penguji memberikan data tambahan hanya jika diminta atau jika peserta melakukan langkah pemeriksaan yang sesuai. INSTRUKSI TAMBAHAN 1. Rapikan alat yang telah digunakan oleh peserta ujian seperti keadaan semula agar siap digunakan oleh peserta berikutnya. 2. Siapkan lembar baru untuk lembar habis pakai dan pastikan lembar yang sudah diisi peserta sebelumnya telah diambil dan diberi identitas peserta.
8	Kebutuhan dan instruksi PS	Instruksi PS: 1. PS berperan sebagai ibu dari bayi. 2. PS menyampaikan keadaan bayi selama selama 5 hari. 3. Bila peserta memberikan penjelasan atau dukungan, PS merespons kooperatif.
9	Dialog PS	Peserta: Selamat pagi/siang, Bu. PS: Pagi/siang, Bu. Peserta: Saya bidan yang akan memeriksa bayi ibu. Apakah ibu bersedia? PS: Iya, Bu, saya bersedia. Peserta: Terima kasih Ibu. Sebelumnya saya ingin menanyakan beberapa hal tentang kondisi bayi. Peserta: Bagaimana pola menyusu bayinya, Bu? PS: Sering menyusu Bu, hampir setiap saat Peserta: Baik. Kalau BAB dan BAK bagaimana, Bu? PS: Popoknya sering basah, dan BAB sekitar 2–3 kali sehari, warnanya kuning. Peserta: Apakah bayi pernah demam, kejang, atau tidak mau menyusu? PS: Tidak Bu, cuma kadang rewel terutama malam hari. Peserta: Baik Ibu, terima kasih informasinya. Peserta: Sekarang saya akan memeriksa bayinya ya Bu. Peserta: Bayi tampak aktif, menyusunya juga baik. Suhu normal, napas dan denyut jantung juga dalam batas normal.

No.	Komponen	Isi
		Peserta: Dari hasil pemeriksaan, kondisi bayi Ibu secara umum baik ya, Bu. PS: Alhamdulillah. Peserta: Berat badan bayi memang sedikit turun dari lahir, tapi masih dalam batas normal untuk bayi usia 5 hari. Peserta: Saya juga melihat kulit bayi agak kuning di wajah sampai dada atas. Ini masih termasuk kuning fisiologis atau normal pada bayi baru lahir. PS: Oh begitu ya Bu, tidak berbahaya? Peserta: Selama bayi masih aktif menyusu, BAB dan BAK lancar seperti sekarang, itu masih normal Bu. Peserta: Ibu tetap lanjutkan menyusui sesering mungkin ya, termasuk malam hari. PS: Iya Bu. Peserta: Untuk tali pusatnya sudah bagus, kering dan tidak berbau. Tetap dijaga bersih dan kering, tidak perlu diberi apa-apa. Peserta: Kalau bayi rewel di malam hari, itu juga masih normal, Bu. Biasanya bayi sedang beradaptasi. Peserta : Tapi Ibu perlu segera ke fasilitas kesehatan jika ada tanda-tanda seperti: • Bayi tidak mau menyusu • Demam atau tubuh terasa dingin • Kuning sampai kaki • Bayi tampak lemas atau kejang PS: Iya Bu, saya mengerti. Peserta: Nanti kita tetap lakukan pemantauan ya Bu. Jika ada keluhan, jangan ragu untuk periksa. PS: Baik Bu, terima kasih. Peserta: Sama-sama Ibu. Assalamu'alaikum. PS: Wa'alaikumussalam. Catatan: Jika ada pertanyaan lain diluar sekenario, PS memberi jawaban normative (Tidak ada data) dan tidak mengarah ke diagnosis lain.

No.	Komponen	Isi
10	Kebutuhan manikin	-Phantom bayi - Buku KIA
11	Kebutuhan laboran	Peran laboran: - Menyiapkan dan merapikan kembali alat serta manikin - Mengganti nuku KIA bila diperlukan - Memastikan set station siap digunakan peserta berikutnya
12	Kebutuhan alat	1. Tempat tidur/periksa — 1 2. Phantom bayi— 1 3. Pakaian bayi — 1 set 4. Buku KIA— 1 5. Stetoskop — 1 6. Jam tangan/stopwatch — 1 7. Termometer — 1 8. Sarung tangan bersih — 1 pasang 9. Handrub — 1 botol 10. Kain penutup/selimut — 1 11. Lembar jawaban peserta — 1 lembar 12. Pena — 1
13	Penulis	Lida Khalimatus S, SSiT.,Bd.,M.Kes
14	Referensi	1. Afrida, B. R., & Aryani, N. P. (2022). Buku Ajar Asuhan Kebidanan pada Neonatus, Bayi, Balita dan Anak Prasekolah. NEM Publisher. 2. Andriana, I. S., Yunita, D., & Kirana, N. (2022**).** Kesehatan Ibu dan Anak: Konsep Dasar Teori Perspektif Akademisi dan Praktisi. Indie Press. 3. Solehah, S., et al. (2024). Asuhan Kebidanan pada Bayi Baru Lahir dengan Kunjungan Neonatus**.** Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat**,** 8(9). 4. Raskita, R. Y., & Ristica, O. D. (2023). Asuhan Kebidanan pada Bayi Baru Lahir dengan Kunjungan Neonatus III di Klinik Pratama Arrabih Pekanbaru. Jurnal Kebidanan Terkini**,** 2(2), 280-287. 5. Pratama, U., Purwita, E., & Yuniwati, C. (2025). Program Pelaksanaan Kunjungan Bayi Baru Lahir Usia 0–28 Hari. Majalah Kesehatan Masyarakat Aceh (MAKMA)**.**

No.	Komponen	Isi
		6. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Pedoman Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial.

Contoh Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada Bayi Baru Lahir, KN2, dan Tindakan Klinis

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Bayi Baru Lahir, KN2, dan Tindakan Klinis
Metode penilaian	DOPS merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap keterampilan prosedural. Penilai mengamati tindakan yang dilakukan peserta, lalu memberikan umpan balik segera setelah prosedur selesai. Domain yang lazim dinilai mencakup informed consent, persiapan pra-tindakan, kemampuan teknis, komunikasi, profesionalisme, dan keselamatan pasien.	Pembimbing mengamati secara langsung bagaimana mahasiswa melakukan penilaian awal bayi baru lahir pada kunjungan Neonatus kedua , lalu menilai keterampilan mahasiswa saat melakukan pemeriksaan fisik, perumusan diagnosa, tindakan klinis dan perilaku profesional
Tujuan penilaian	Tujuan DOPS pada topik ini adalah menilai kemampuan mahasiswa melakukan penilaian awal bayi baru lahir pada kunjungan Neonatus kedua, dengan tetap berpusat pada keselamatan bayi serta penghormatan pada asuhan yang bermartabat. Sehingga mahasiswa mampu memberikan asuhan kebidanan yang komprehensif, aman, dan berkualitas.	Menilai kemampuan klinis mahasiswa dalam melakukan pemeriksaan neonatus secara sistematis, menginterpretasikan data, dan merumuskan diagnosa yang tepat sesuai kondisi bayi, termasuk mengenali ikterus fisiologis.
Kasus klinik	Kasus dipilih dari situasi nyata di lahan praktik yang sesuai dengan capaian pembelajaran profesi bidan, khususnya kunjungan neonatus kedua, identifikasi tanda bahaya, dan pengambilan keputusan awal. Sehingga mahasiswa mampu memberikan asuhan kebidanan yang	Seorang bidan melakukan kunjungan neonatus kedua (KN2) pada bayi laki-laki usia 5 hari di rumah pasien. Bayi lahir cukup bulan dengan berat lahir 3200 gram melalui persalinan normal. Saat lahir bayi langsung menangis kuat dan tidak ada komplikasi.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Bayi Baru Lahir, KN2, dan Tindakan Klinis
	komprehensif, aman, dan berkualitas.	
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Pada DOPS, mahasiswa diamati saat melakukan komunikasi terapeutik dan anamnesis untuk menggali kondisi bayi, dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik neonatus secara sistematis, kemudian menginterpretasikan hasil, merumuskan diagnosa yang tepat, serta menyusun rencana asuhan dan memberikan edukasi kepada ibu terkait perawatan bayi, pemberian ASI, pemantauan ikterus, dan tanda bahaya. Juga dinilai dalam penerapan prinsip keselamatan pasien, menjaga kenyamanan bayi, serta menunjukkan sikap profesional dan empati hingga penutupan interaksi.	Mahasiswa memperkenalkan diri, meminta persetujuan, menilai kondisi bayi, pemeriksaan fisik, menginterpretasikan hasil, merumuskan diagnosa yang tepat, serta menyusun rencana asuhan dan memberikan edukasi kepada ibu terkait perawatan bayi, pemberian ASI, pemantauan ikterus, dan tanda bahaya.
Aspek yang dinilai	Aspek yang dinilai meliputi kemampuan mahasiswa dalam melakukan prosedur pemeriksaan fisik neonatus secara sistematis dan benar, menginterpretasikan data klinis serta merumuskan diagnosa yang tepat, melakukan komunikasi terapeutik dan edukasi kepada ibu, serta menunjukkan sikap profesional yang mencakup empati, etika, dan penerapan prinsip keselamatan pasien, sehingga mencerminkan kompetensi klinis yang	Pembimbing menilai kemampuan mahasiswa dalam melakukan pemeriksaan neonatus secara sistematis seperti mengukur tanda vital, menilai berat badan, mengamati warna kulit untuk mengidentifikasi ikterus, serta memeriksa tali pusat dan refleks hisap; merumuskan diagnosa yang tepat; serta memberikan edukasi kepada ibu terkait menyusui, perawatan tali pusat, pemantauan ikterus, dan tanda bahaya.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Bayi Baru Lahir, KN2, dan Tindakan Klinis
	komprehensif dan berorientasi pada kualitas asuhan.	
Fokus observasi pembimbing	Fokus observasi pembimbing adalah menilai secara langsung keterampilan mahasiswa dalam melakukan prosedur pemeriksaan neonatus secara sistematis, ketepatan dalam menginterpretasikan data klinis dan merumuskan diagnosa, kemampuan komunikasi terapeutik dalam berinteraksi dengan ibu, serta sikap profesional yang mencakup empati, etika, dan keselamatan pasien selama tindakan berlangsung.	Pembimbing mengamati bagaimana mahasiswa mengukur tanda vital bayi dengan benar, menilai penurunan berat badan masih dalam batas normal, mengidentifikasi adanya ikterus fisiologis pada wajah hingga dada atas, kemudian merumuskan diagnosa yang tepat, serta memberikan edukasi kepada ibu mengenai menyusui, perawatan tali pusat, pemantauan kuning pada bayi, dan tanda bahaya neonatus dengan komunikasi yang jelas dan empatik.
Umpan balik	Umpan balik dalam DOPS diberikan segera setelah observasi dan berisi apa yang sudah efektif serta apa yang perlu diperbaiki. Form DOPS juga menekankan komentar assessor mengenai kekuatan, area yang perlu ditingkatkan, dan rencana perbaikan untuk mencapai kompetensi optimal.	pembimbing menyampaikan bahwa mahasiswa sudah baik dalam melakukan pemeriksaan tanda vital dan komunikasi dengan ibu, namun perlu meningkatkan ketelitian dalam menilai derajat ikterus dan menyampaikan edukasi secara lebih sistematis, misalnya dengan menambahkan penjelasan batas normal kuning pada bayi dan kapan harus segera ke fasilitas kesehatan.
Keputusan penilaian	Merupakan hasil akhir evaluasi pembimbing terhadap kinerja mahasiswa berdasarkan observasi langsung, yang mencakup aspek keterampilan prosedural,	Mahasiswa dinilai kompeten karena mampu melakukan pemeriksaan neonatus secara sistematis, mengidentifikasi kondisi bayi dalam batas normal

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Bayi Baru Lahir, KN2, dan Tindakan Klinis
	ketepatan klinis, komunikasi, dan profesionalisme, dalam menentukan apakah mahasiswa telah mampu melakukan tindakan secara mandiri atau masih memerlukan bimbingan dan perbaikan.	dengan ikterus fisiologis, merumuskan diagnosa dengan tepat, serta memberikan edukasi kepada ibu secara cukup jelas, meskipun masih perlu peningkatan dalam ketelitian penilaian derajat ikterus dan penyampaian edukasi yang lebih terstruktur.
Makna dalam OBE	DOPS memberikan bukti autentik bahwa mahasiswa mampu menunjukkan capaian pembelajaran pada level does karena performanya diamati langsung saat melakukan tindakan klinik. Observasi langsung pada pasien nyata dan umpan balik segera menjadikan DOPS sangat sesuai untuk pembelajaran berbasis kompetensi.	Pada kasus Kunjungan Neonatus kedua, mahasiswa dinilai telah mencapai outcome pembelajaran karena mampu melakukan pemeriksaan neonatus secara sistematis, menginterpretasikan kondisi bayi sebagai normal dengan ikterus fisiologis, merumuskan diagnosa yang tepat, serta memberikan edukasi kepada ibu secara jelas.

Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

- OSCE + DOPS
- Catatan kasus singkat
- Refleksi patient safety
- Feedback CI/dosen

Catatan untuk penulis:

- Bukan sekali ujian
- Bukti konsistensi kompetensi

Tabel 1. 1 Portofolio pada Bayi Fisiologis: Bayi Baru Lahir, KN2, dan Tindakan Klinis

Komponen	**Deskripsi**	**Contoh pada Kasus Bayi Baru Lahir, KN2, dan Tindakan Klinis**
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu, bukan hanya dari satu kali ujian.	Pada topik Kunjungan Neonatus kedua, portofolio memuat bukti bahwa mahasiswa mampu mengidentifikasi kondisi normal maupun penyimpangan, seperti pada kasus ini adanya ikterus fisiologis ringan pada bayi usia 5 hari yang menunjukkan integrasi antara teori dan praktik klinik serta perkembangan kompetensi secara nyata.
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik.	Mahasiswa mampu mengidentifikasi bahwa kondisi bayi masih dalam batas normal, termasuk penurunan berat badan yang masih fisiologis serta ikterus ringan yang tidak disertai tanda bahaya.
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS dapat menjadi bagian penting dalam portofolio karena memberikan bukti keterampilan terstruktur di laboratorium dan bukti performa nyata di lahan praktik.	Peserta OSCE melakukan pemeriksaan bayi usia 5 hari, Menjelaskan hasil pemeriksaan kepada ibu., Memberikan edukasi bahwa warna kuning ringan masih normal (ikterus fisiologis), Memberikan saran menyusui lebih sering dan pemantauan lanjutan. Pembimbing mengamati secara langsung.
Catatan kasus singkat	Catatan kasus singkat berisi ringkasan kasus pasien yang pernah ditangani mahasiswa, data penting, masalah kebidanan, tindakan utama, dan hasil yang dicapai.	Mahasiswa menuliskan ringkasan kasus Bayi dalam kondisi normal dengan ikterus fisiologis. Penatalaksanaan Edukasi, observasi, dan tindak lanjut
Refleksi patient safety	Refleksi patient safety menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi	Mahasiswa merefleksikan dengan memastikan bahwa warna kuning hanya sampai dada atas, bayi aktif menyusu, dan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Bayi Baru Lahir, KN2, dan Tindakan Klinis
	kesalahan, dan menyusun langkah pencegahan dalam asuhan kebidanan.	tidak ada tanda bahaya lain. Mahasiswa juga mengedukasi ibu untuk segera ke fasilitas kesehatan jika kuning meluas hingga kaki atau bayi tampak lemas.
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari Clinical Instructor (CI) atau dosen menjadi bukti pembinaan yang menunjukkan area kekuatan dan area yang masih perlu ditingkatkan.	CI menuliskan bahwa Mahasiswa sudah mampu melakukan pemeriksaan fisik dengan baik dan sistematis. Interpretasi data sudah tepat dengan menyimpulkan ikterus fisiologis. Namun, perlu ditingkatkan dalam memberikan edukasi yang lebih terstruktur, terutama dalam menjelaskan tanda bahaya kepada ibu secara lebih rinci dan memastikan pemahaman ibu.
Karakteristik penilaian	Portofolio bukan penilaian sekali selesai, tetapi kumpulan bukti yang dibangun secara berulang dan berkesinambungan. Penekanan utamanya adalah konsistensi performa mahasiswa.	Mahasiswa dinilai berdasarkan kemampuan mengukur tanda vital, mengidentifikasi ikterus, serta komunikasi dengan ibu menggunakan checklist DOPS yang telah distandarkan
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio memperlihatkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan mutu performa pada berbagai kesempatan praktik dan pada waktu yang berbeda.	Dari hasil OSCE, DOPS, catatan kasus, refleksi, dan umpan balik, terlihat Mahasiswa menunjukkan hasil penilaian yang stabil pada beberapa kesempatan praktik KN2, dengan selalu mampu mengidentifikasi kondisi normal neonatus dan memberikan edukasi yang tepat tanpa kesalahan signifikan.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, portofolio memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tidak hanya dimiliki secara teoritis, tetapi benar-benar tampak dalam performa yang berulang, berkembang, dan terdokumentasi.	Pada topik partus lama dan distosia, portofolio menunjukkan bahwa Mahasiswa mampu menunjukkan outcome berupa kompetensi dalam melakukan KN2 secara komprehensif: mulai dari pengkajian, analisis (ikterus fisiologis), hingga edukasi ibu. Hal ini menunjukkan bahwa capaian pembelajaran telah terpenuhi sesuai standar kompetensi kebidanan.

Tabel 1. 2 Case Report pada pada Bayi Fisiologis: Bayi Baru Lahir, KN2, dan Tindakan Klinis

Komponen	**Deskripsi**	**Contoh pada Kasus Partus Lama, Distosia, dan Tindakan Awal**
Hakikat case report	Case report merupakan laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien yang ditangani mahasiswa selama praktik klinik. Dalam OBE, case report berfungsi sebagai bukti kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan mendokumentasikan kasus secara ilmiah dan klinis.	Mahasiswa menyusun laporan kasus bayi usia 5 hari dengan ikterus ringan, disertai analisis bahwa kondisi tersebut masih fisiologis berdasarkan data klinis yang ditemukan.
Tujuan	Case report bertujuan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data pengkajian, masalah kebidanan, rencana tindakan, implementasi, dan evaluasi hasil asuhan.	Mahasiswa mampu menjelaskan secara tertulis alasan mengapa bayi dikategorikan mengalami ikterus fisiologis serta rencana tindak lanjut yang tepat.
Isi laporan	Isi case report biasanya mencakup identitas singkat pasien, keluhan utama, data subjektif dan objektif, analisis masalah, diagnosis/masalah kebidanan, tindakan, implementasi, evaluasi, dan pembelajaran dari kasus.	Pada kasus ini mahasiswa menuliskan bahwa penurunan berat badan masih dalam batas normal dan tidak mengindikasikan masalah nutrisi.
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan pengkajian, relevansi analisis masalah, logika penalaran klinik, ketepatan tindakan awal, dan kemampuan mengevaluasi hasil asuhan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu mengaitkan data ikterus dengan usia bayi dan kondisi umum yang baik sehingga menyimpulkan sebagai kondisi fisiologis.
Nilai edukatif	Case report membantu mahasiswa mengembangkan clinical reasoning, keterampilan dokumentasi, dan kebiasaan merefleksikan praktik klinik secara ilmiah.	Dari kasus bayi baru lahir Mahasiswa memahami bahwa tidak semua bayi kuning merupakan kondisi berbahaya, sehingga dapat menghindari tindakan yang tidak perlu sekaligus tetap waspada terhadap tanda bahaya.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, case report menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori ke dalam analisis kasus nyata secara sistematis dan bertanggung jawab.	Mahasiswa mampu menyusun case report yang menunjukkan alur berpikir klinis yang benar: dari pengkajian → analisis (ikterus fisiologis) → penatalaksanaan → edukasi → evaluasi. Hal ini menunjukkan bahwa capaian pembelajaran telah terpenuhi sesuai standar kompetensi kebidanan..

Tabel 1. 3 Refleksi Patient Safety pada pada kasus Fisiologis: Bayi Baru Lahir, KN2, dan Tindakan Klinis

Komponen	**Deskripsi**	**Contoh pada Kasus Partus Lama, Distosia, dan Tindakan Awal**
Hakikat refleksi patient safety	Refleksi patient safety merupakan tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi masalah, dan merencanakan tindakan pencegahan.	Pada kasus bayi baru lahir, Mahasiswa merefleksikan bahwa meskipun kondisi bayi tampak normal, tetap diperlukan kewaspadaan terhadap perkembangan ikterus yang dapat menjadi patologis jika tidak dipantau dengan baik.
Tujuan	Refleksi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran mahasiswa bahwa keselamatan pasien merupakan bagian penting dari setiap tindakan kebidanan.	Mahasiswa menyadari pentingnya memantau ikterus secara berkala untuk mencegah keterlambatan rujukan jika kondisi memburuk..
Fokus refleksi	Fokus refleksi meliputi identifikasi risiko, analisis penyebab, tindakan pencegahan, dan pembelajaran yang diperoleh mahasiswa dari pengalaman klinik.	Mahasiswa mengevaluasi apakah sudah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap tanda bahaya seperti bayi lemas, tidak menyusu, atau kuning hingga ekstremitas
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa perlu menunjukkan kemampuan mengenali situasi yang berpotensi membahayakan pasien.	Risiko yang dapat diidentifikasi Jika mahasiswa tidak teliti, ikterus yang meluas dapat terlewat sehingga berisiko berkembang menjadi kondisi serius seperti hiperbilirubinemia.
Tindakan pencegahan	Mahasiswa menjelaskan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko keselamatan pasien.	Mahasiswa mengedukasi ibu agar segera ke fasilitas kesehatan jika bayi tampak kuning hingga kaki, tidak mau menyusu, atau tampak lemas.
Pembelajaran mahasiswa	Refleksi harus menunjukkan apa yang dipelajari mahasiswa dan bagaimana hal itu akan mempengaruhi praktik berikutnya.	Mahasiswa menyadari bahwa edukasi kepada ibu merupakan bagian penting dalam mencegah keterlambatan penanganan di rumah.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, refleksi patient safety menunjukkan perkembangan sikap professional, tanggung jawab klinik, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa terhadap keselamatan pasien.	Mahasiswa mampu menunjukkan outcome berupa tindakan klinis yang aman, seperti melakukan pemantauan ikterus dengan tepat dan memberikan edukasi yang sesuai, sehingga mencerminkan kompetensi yang telah dicapai secara utuh.

F. Ringkasan

Kunjungan neonatus terjadwal merupakan bagian penting dalam asuhan kebidanan untuk memastikan adaptasi bayi baru lahir berjalan optimal serta mendeteksi secara dini adanya kelainan atau komplikasi. Kunjungan ini umumnya dilakukan minimal tiga kali, yaitu pada 6–48 jam (KN1), hari ke-3–7 (KN2), dan hari ke-8–28 (KN3). Pada skenario ini, bidan melakukan kunjungan neonatus kedua (KN2) pada bayi laki-laki usia 5 hari yang lahir cukup bulan dengan berat lahir 3200 gram tanpa komplikasi.

Pada KN2, fokus utama adalah pemantauan kondisi umum bayi, kecukupan nutrisi, eliminasi, pertumbuhan, serta deteksi dini tanda bahaya. Berdasarkan hasil pengkajian, bayi menyusu sering, BAK sering, dan BAB 2–3 kali/hari berwarna kekuningan, yang menunjukkan kecukupan asupan ASI. Pemeriksaan fisik menunjukkan keadaan umum baik dengan suhu 36,8°C, frekuensi napas 44 kali/menit, dan denyut jantung 136 kali/menit, yang semuanya berada dalam batas normal neonatus. Berat badan bayi 3050 gram menunjukkan penurunan fisiologis yang masih wajar pada minggu pertama kehidupan.

Parameter pemantauan pada kunjungan ini meliputi tanda vital, berat badan, warna kulit, aktivitas bayi, refleks, serta kondisi tali pusat. Pada kasus ini, tali pusat tampak kering dan tidak berbau, menandakan tidak adanya infeksi. Namun, ditemukan ikterus ringan pada wajah hingga dada bagian atas. Kondisi ini mengarah pada ikterus fisiologis yang umum terjadi pada bayi usia 3–7 hari, terutama jika bayi aktif menyusu dan tidak disertai tanda bahaya.

Deteksi dini tanda bahaya merupakan aspek krusial dalam kunjungan neonatus. Tanda bahaya yang harus diwaspadai antara lain bayi tidak mau menyusu, lemas, demam atau hipotermia, napas cepat atau sesak, kejang, serta ikterus yang meluas hingga ekstremitas bawah. Dalam kasus ini, tidak ditemukan tanda bahaya sehingga bayi dapat dikategorikan dalam kondisi normal dengan ikterus fisiologis ringan. Meski demikian, edukasi kepada ibu tetap menjadi prioritas untuk memastikan pemantauan berkelanjutan di rumah.

Peran bidan dalam kunjungan ini tidak hanya melakukan pemeriksaan, tetapi juga memberikan edukasi kepada ibu terkait pemberian ASI eksklusif, perawatan tali pusat, pola eliminasi normal, serta tanda bahaya yang harus segera dilaporkan. Edukasi ini merupakan bagian penting dalam upaya promotif dan preventif guna menjaga keselamatan bayi.

Tabel 1. 4 Red Flags & Eskalasi

Red flags	**Makna klinis**	**Tindakan eskalasi**
Ikterus meluas hingga perut bawah/kaki	Mengarah ke hiperbilirubinemia patologis	Rujuk segera ke fasilitas kesehatan untuk pemeriksaan bilirubin
Bayi tampak lemas/tidak aktif	Tanda gangguan sistemik atau infeksi	Rujuk segera, lakukan stabilisasi awal
Tidak mau menyusu atau hisapan lemah	Risiko dehidrasi dan gangguan nutrisi	Evaluasi segera, rujuk jika tidak membaik
Demam (>37,5°C) atau hipotermia (<36,5°C)	Indikasi infeksi atau gangguan termoregulasi	Rujuk segera untuk evaluasi lanjut
Frekuensi napas >60x/menit atau <30x/menit	Gangguan pernapasan	Rujuk segera, pantau jalan napas
Denyut jantung <100 atau >160 x/menit	Gangguan kardiovaskular atau stres	Rujuk untuk evaluasi medis
Tali pusat merah, bernanah, atau berbau	Infeksi tali pusat (omfalitis)	Rujuk dan lakukan perawatan luka sesuai standar
Penurunan berat badan >10% dari berat lahir	Risiko malnutrisi/dehidrasi	Konseling menyusui intensif, rujuk jika berat tidak naik
Kejang atau gerakan tidak normal	Gangguan neurologis serius	Rujuk darurat (emergency)

Form Checklist

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / Skill Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa melakukan anamnesis pada ibu terkait pola menyusu bayi	☐	☐	_____
2	Saya sudah bisa mengkaji pola eliminasi bayi (BAK dan BAB)	☐	☐	_____
3	Saya sudah bisa menilai kondisi umum bayi secara sistematis	☐	☐	_____
4	Saya sudah bisa mengukur suhu tubuh bayi dengan benar	☐	☐	_____
5	Saya sudah bisa menghitung frekuensi napas bayi secara tepat	☐	☐	_____
6	Saya sudah bisa mengukur denyut jantung bayi	☐	☐	_____
7	Saya sudah bisa menilai berat badan bayi dan membandingkan dengan berat lahir	☐	☐	_____
8	Saya sudah bisa mengidentifikasi penurunan berat badan fisiologis pada neonatus	☐	☐	_____
9	Saya sudah bisa melakukan pemeriksaan tali pusat dan menilai tanda infeksi	☐	☐	_____
10	Saya sudah bisa mengidentifikasi ikterus fisiologis pada bayi baru lahir	☐	☐	_____
11	Saya sudah bisa membedakan tanda bahaya ikterus fisiologis dan patologis	☐	☐	_____
12	Saya sudah bisa menilai refleks menghisap bayi	☐	☐	_____
13	Saya sudah bisa menyimpulkan diagnosis neonatus fisiologis dengan tepat	☐	☐	_____
14	Saya sudah bisa memberikan edukasi kepada ibu tentang pemberian ASI	☐	☐	_____

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
15	Saya sudah bisa menjelaskan tanda bahaya pada bayi baru lahir kepada ibu	☐	☐	_____
16	Saya sudah bisa merencanakan tindak lanjut/kunjungan ulang dengan tepat	☐	☐	_____

Refleksi singkat mahasiswa:

Referensi

Afrida, B. R., & Aryani, N. P. (2022). Buku Ajar Asuhan Kebidanan pada Neonatus, Bayi, Balita dan Anak Prasekolah. NEM Publisher.

Andriana, I. S., Yunita, D., & Kirana, N. (2022). Kesehatan Ibu dan Anak: Konsep Dasar Teori Perspektif Akademisi dan Praktisi. Indie Press.

BMC Pregnancy and Childbirth (2023). Determinants of neonatal danger sign recognition among mothers: A cross-sectional study.

Frontiers in Pediatrics (2023). Early detection of neonatal complications during postnatal home visits.

Ikatan Bidan Indonesia (2021). *Standar Profesi Bidan Indonesia*.

International Journal of Pediatrics (2024). Monitoring neonatal health indicators during the first week of life.

Journal of Neonatal Nursing (2022). Assessment of neonatal monitoring parameters in early postnatal visits.

Jurnal Kebidanan dan Kesehatan (2023). Evaluasi pelaksanaan kunjungan neonatus terhadap kesehatan bayi.

Jurnal Kesehatan Reproduksi Indonesia (2022). Hubungan kunjungan neonatus dengan deteksi dini komplikasi bayi baru lahir.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2022). *Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) edisi terbaru*.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022**).** Pedoman Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial.

Midwifery Journal (2021). Effectiveness of scheduled postnatal visits on neonatal outcomes.

Pratama, U., Purwita, E., & Yuniwati, C. (2025). Program Pelaksanaan Kunjungan Bayi Baru Lahir Usia 0–28 Hari. Majalah Kesehatan Masyarakat Aceh (MAKMA)**.**

Raskita, R. Y., & Ristica, O. D. (2023). Asuhan Kebidanan pada Bayi Baru Lahir dengan Kunjungan Neonatus III di Klinik Pratama Arrabih Pekanbaru**.** Jurnal Kebidanan Terkini**,** 2(2), 280-287.

Solehah, S., et al. (2024). Asuhan Kebidanan pada Bayi Baru Lahir dengan Kunjungan Neonatus. Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat**,** 8(9).

UNICEF (2021). *Neonatal care practices and outcomes in low- and middle-income countries: A systematic review*.

World Health Organization (2022). *Postnatal care of the mother and newborn 2022 update: WHO recommendations*.

BAB 2

PEMANTAUAN PERTUMBUHAN NEONATUS: BERAT BADAN, POLA ELIMINASI, DAN STATUS HIDRASI

A. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menunjukkan profesionalisme, etika, dan tanggung jawab legal dalam pelayanan neonatal esensial.	CPMK-1; CPMK-3; CPMK-7
CPL-2	Menerapkan komunikasi terapeutik dan edukasi yang memberdayakan orang tua/keluarga dalam perawatan neonatus.	CPMK-1; CPMK-5; CPMK-6; CPMK-7
CPL-3	Menerapkan keselamatan pasien, pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI), serta K3 pada setiap tindakan neonatal.	CPMK-1; CPMK-3; CPMK-4; CPMK-7
CPL-4	Melakukan pengkajian dan clinical reasoning pada adaptasi fisiologis neonatus untuk mengenali kondisi normal, risiko, dan tanda bahaya.	CPMK-2; CPMK-4; CPMK-7
CPL-5	Melaksanakan keterampilan pelayanan neonatal esensial (termoregulasi, ASI, pencegahan infeksi, pemantauan) secara aman dan bermutu.	CPMK-3; CPMK-4; CPMK-5; CPMK-6; CPMK-7
CPL-6	Melaksanakan dokumentasi, kolaborasi, rujukan/balik rujuk, dan kontinuitas asuhan neonatus berbasis bukti.	CPMK-1; CPMK-7

B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan standar, etika, keselamatan, PPI, dan alur pelayanan neonatal esensial serta peran tenaga kesehatan dalam koordinasi layanan dan edukasi keluarga.
CPMK-2	Menganalisis adaptasi fisiologis neonatus (pernapasan, sirkulasi, termoregulasi) dan menginterpretasi parameter klinis dasar untuk pengambilan keputusan awal.
CPMK-3	Melaksanakan asuhan segera setelah lahir yang aman (pengeringan, kontak kulit, IMD) serta pencegahan hipotermia dan infeksi dasar sesuai SOP.
CPMK-4	Melakukan penilaian risiko termal dan melaksanakan pencegahan serta tata laksana awal hipotermia pada neonatus sesuai pedoman.
CPMK-5	Menilai proses menyusu dan menerapkan praktik pemberian ASI pada neonatus (perlekatan, frekuensi, tanda cukup ASI) disertai edukasi keluarga.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-6	Memberikan dukungan menyusui dan melakukan pemecahan masalah awal laktasi secara sistematis serta menentukan kebutuhan tindak lanjut/rujukan.
CPMK-7	Melaksanakan pemantauan neonatus terjadwal (pertumbuhan, eliminasi, hidrasi, respirasi, sirkulasi), deteksi dini tanda bahaya, skrining risiko, dokumentasi, serta rujukan/balik rujuk untuk kontinuitas asuhan.

D. Pemetaan

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 2. Pemantauan Pertumbuhan Neonatus: Berat Badan, Pola Eliminasi, dan Status Hidrasi	2.1 Melakukan penimbangan dan interpretasi perubahan berat badan serta batas fisiologis penurunan BB.	2.2 Menilai pola eliminasi dan status hidrasi (diuresis, mukosa, turgor, fontanel) untuk keputusan asuhan.	CPMK-7	CPMK-5; CPMK-2

E. Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-2	Ujian kasus tertulis; interpretasi parameter klinis (lembar kerja)	Ketepatan interpretasi parameter (RR/HR/suhu/CRT/warna) ≥75%; analisis hubungan temuan–mekanisme–tindakan awal ≥3 (skala 1–4)	15	Jawaban studi kasus; lembar interpretasi
CPMK-5	OSCE observasi menyusu & konseling (rubrik)	Skor penilaian perlekatan/posisi ≥3 (skala 1–4); ketepatan penilaian tanda cukup ASI ≥80%	10	Rubrik observasi menyusu; catatan konseling
CPMK-7	OSCE/mini-CEX kunjungan neonatus; Portofolio pemantauan (checklist)	Kelengkapan pengkajian & pencatatan parameter ≥85%; keputusan tindak lanjut/rujukan tepat ≥3 (skala 1–4); kelengkapan dokumentasi/format rujukan ≥80%	20	Portofolio kunjungan; lembar pemantauan; dokumentasi SOAP/rujukan

Rubrik CPMK-1

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1 Kepatuhan etika,	Banyak pelanggaran; langkah	Sebagian diterapkan; ada	Hampir seluruhnya	Konsisten patuh; proaktif

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
keselamatan pasien, dan PPI pada skenario pelayanan	keselamatan/PPI sering terlewat; perlu arahan penuh	kesalahan minor berisiko; perlu koreksi	patuh; kesalahan sangat minimal dan segera diperbaiki	mengidentifikasi risiko dan mencegah tanpa diingatkan
1.2 Kejelasan komunikasi edukatif & koordinasi terstruktur	Informasi tidak lengkap/tidak terstruktur; tidak memastikan pemahaman	Informasi cukup namun kurang terstruktur; konfirmasi pemahaman terbatas	Terstruktur dan jelas; bahasa sesuai; melakukan cek balik pemahaman	Sangat jelas, empatik, terarah; melibatkan keluarga; kesepakatan tindak lanjut dinyatakan tegas

Rubrik CPMK-2

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Interpretasi parameter respirasi/sirkulasi/suhu (normal vs abnormal)	Interpretasi banyak salah; tidak membedakan normal–abnormal	Benar sebagian; masih salah pada beberapa parameter kunci; perlu bantuan	Mayoritas benar; kesalahan minor tidak mengubah kesimpulan utama	Akurat dan cepat; mengintegrasikan beberapa parameter untuk kesimpulan tepat
2.2 Penalaran hubungan mekanisme adaptasi–temuan–tindakan awal	Penalaran tidak logis; tidak terhubung dengan mekanisme	Hubungan sebab-akibat kurang lengkap; tindakan awal kurang tepat	Logis dan relevan; tindakan awal sesuai berdasarkan temuan	Mendalam; mempertimbangkan alternatif/risiko; justifikasi tindakan awal sangat kuat

Rubrik CPMK-3

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Urutan dan ketepatan tindakan asuhan segera setelah lahir	Urutan salah/ada langkah kritis terlewat; teknik tidak aman	Urutan cukup namun ada langkah kritis kurang tepat; perlu arahan	Urutan tepat; teknik aman; hanya kesalahan minor	Sangat tepat dan efisien; mengantisipasi masalah sejak awal; teknik aman konsisten
3.2 Implementasi kontak kulit/IMD serta pencegahan	Kontak kulit/IMD tidak dilakukan/keliru;	Dilakukan sebagian; durasi/teknik	Sesuai SOP; menjaga kehangatan dan	Optimal; menjaga kehangatan proaktif; IMD terfasilitasi baik;

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
hipotermia & infeksi dasar	pencegahan tidak adekuat	kurang; kontrol suhu/aseptik belum konsisten	aseptik; monitoring dasar dilakukan	pencegahan infeksi sangat konsisten

Rubrik CPMK-4

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Identifikasi faktor risiko dan strategi pencegahan hipotermia	Risiko tidak teridentifikasi; strategi tidak sesuai	Mengidentifikasi sebagian; strategi masih umum/kurang kontekstual	Mengidentifikasi mayoritas risiko; strategi sesuai konteks	Komprehensif; prioritas tepat; strategi spesifik mempertimbangkan sumber daya
4.2 Tata laksana awal hipotermia, monitoring respons, dan keputusan rujukan	Pemanasan tidak tepat/berbahaya; monitoring tidak ada; keputusan keliru	Pemanasan cukup namun tidak sistematis; monitoring kurang lengkap; keputusan kurang tepat	Sistematis sesuai pedoman; monitoring memadai; keputusan rujukan tepat	Sangat tepat dan aman; monitoring lengkap dengan evaluasi respons; komunikasi rujukan jelas

Rubrik CPMK-5

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Penilaian perlekatan/posisi menyusu dan koreksi	Tidak mampu menilai; koreksi tidak diberikan	Menilai sebagian; koreksi kurang spesifik; masalah masih menetap	Menilai tepat; koreksi spesifik; perlekatan/posisi membaik	Sangat akurat; mengajarkan keterampilan pada ibu/keluarga; hasil optimal dan berkelanjutan
5.2 Penilaian frekuensi menyusu & tanda cukup ASI disertai edukasi	Penilaian keliru; edukasi tidak relevan	Penilaian umum; sebagian benar namun kurang individual	Sesuai kondisi bayi; indikator klinis dinilai benar; edukasi jelas	Sangat tepat berbasis data; edukasi terpersonalisasi dengan rencana tindak lanjut

Rubrik CPMK-6

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Identifikasi penyebab masalah menyusui	Tidak teridentifikasi; data tidak digunakan	Sebagian teridentifikasi; penyebab utama	Tepat berdasarkan data; membedakan beberapa	Komprehensif; memprioritaskan penyebab utama dan

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
berbasis data pengkajian		masih salah; perlu bantuan	penyebab yang mungkin	faktor pendukung secara tepat
6.2 Rencana intervensi, dukungan, tindak lanjut/rujukan	Intervensi tidak sesuai/berisiko; tidak ada tindak lanjut	Intervensi cukup namun kurang sistematis; tindak lanjut/rujukan belum jelas	Intervensi sesuai; tindak lanjut jelas; rujukan sesuai indikasi	Sangat efektif dan memberdayakan; tindak lanjut terjadwal; rujukan disertai komunikasi lengkap

Rubrik CPMK-7

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Kelengkapan pemantauan kunjungan neonatus dan pencatatan parameter	Banyak parameter tidak diukur/dicatat	Parameter dasar ada, namun kekurangan penting; catatan kurang rapi	Lengkap sesuai usia; catatan rapi dan dapat ditelusuri	Sangat lengkap dan konsisten; menginterpretasi tren/perubahan; catatan sangat akurat
7.2 Deteksi dini tanda bahaya/risiko, keputusan tindakan, dan dokumentasi	Tidak mengenali risiko; keputusan tidak tepat; dokumentasi tidak ada	Mengenali sebagian; keputusan kurang tepat; dokumentasi/rujukan belum lengkap	Mengenali dan bertindak tepat (edukasi/observasi/rujukan); dokumentasi lengkap	Deteksi sangat dini dan tepat; keputusan cepat-aman; komunikasi rujukan/balik rujuk sangat jelas dan terdokumentasi

A. Pemantauan Pertumbuhan Neonatus: Berat Badan, Pola Eliminasi, dan Status Hidrasi

Neonatus (bayi usia 0–28 hari) membutuhkan pemantauan ketat untuk memastikan adaptasi fisiologis yang normal setelah lahir. Pemantauan meliputi berat badan, eliminasi (urine/BAB), dan status hidrasi. Dengan pemeriksaan berkala (kunjungan neonatus 1–3) yang terjadwal, intervensi dini dapat diberikan jika ditemukan kegagalan adaptasi (WHO 2024; Kemenkes 2024).

1. Konsep Dasar Pemantauan Neonatus.

Proses penyesuaian fisiologis neonatus terhadap lingkungan ekstrauterin dikenal sebagai periode transisi. Setelah pemutusan tali pusat, organ pernapasan, sistem sirkulasi, dan metabolisme neonatus harus beralih dari ketergantungan pada ibu menuju fungsi mandiri. Berbagai perubahan cepat terjadi pada fase ini:

paru-paru mulai berfungsi untuk ventilasi spontan, sirkulasi darah berfokus ke paru, dan mekanisme termoregulasi aktif mulai bekerja. Homeostasis neonatus sangat dipengaruhi oleh kematangan organ serta status nutrisi; neonatus prematur (kurang bulan) menunjukkan kemampuan adaptasi yang lebih rentan karena organ-organ belum berkembang sempurna. Sebagai contoh, struktur pembuluh darah otak yang masih belum matang meningkatkan risiko terjadinya perdarahan intrakranial pada neonatus prematur.

Pemahaman mengenai karakteristik normal neonatus menjadi sangat esensial. Bayi baru lahir diklasifikasikan sebagai kelompok umur 0–28 hari, yaitu suatu periode dengan angka mortalitas tinggi (sekitar 47% kematian anak usia di bawah 5 tahun terjadi pada masa neonatus). Berbagai kondisi kegawatan, seperti hipoksia, sepsis, dan berat badan lahir rendah (BBLR), sering berkaitan dengan kegagalan proses adaptasi. Oleh sebab itu, bidan harus mampu melakukan identifikasi dini terhadap gangguan yang terjadi, antara lain melalui pemeriksaan fisik awal (idealnya dalam 6–12 jam setelah lahir) untuk menilai apakah bayi lahir dalam keadaan sehat (skor APGAR baik, tidak dijumpai kelainan bawaan yang nyata) serta untuk mengevaluasi fungsi dasar, meliputi respirasi, perfusi, dan tonus otot. Selain itu, bidan berkewajiban memastikan bayi tetap hangat guna mencegah hipotermia, melakukan penilaian refleks primitif, serta memperoleh persetujuan tindakan dari orang tua (informed consent) apabila diperlukan intervensi lebih lanjut.

Pertumbuhan juga memegang peranan penting. Pertumbuhan didefinisikan sebagai peningkatan ukuran fisik secara kuantitatif, yang mencakup jumlah sel, berat badan, dan panjang tubuh sejak konsepsi hingga dewasa. Pada periode neonatus, perhatian utama diarahkan pada kenaikan berat badan sebagai parameter pertumbuhan yang dapat diukur secara objektif. Pertumbuhan harus dibedakan dari perkembangan, yang berkaitan dengan kemajuan kemampuan motorik dan sensorik. Dengan demikian, pemantauan pertumbuhan neonatus terutama berfokus pada ukuran tubuh (khususnya berat badan) dan fungsi fisiologis (misalnya metabolisme), bukan pada derajat kematangan sistem neurologis. Berdasarkan hal tersebut, tujuan utama pemantauan neonatus antara lain sebagai berikut.

a. Menilai kecukupan asupan gizi dan cairan: Kenaikan berat badan setelah fase penurunan fisiologis mencerminkan bahwa neonatus menerima asupan ASI yang memadai. Sebaliknya, berat badan yang tidak meningkat atau terus menurun mengindikasikan insufisiensi asupan nutrisi atau adanya kehilangan cairan (dehidrasi).

b. Deteksi dini gangguan: Pemantauan pola buang air kecil (BAK), buang air besar (BAB), dan tanda-tanda hidrasi membantu mengidentifikasi masalah pada sistem ginjal, gastrointestinal, maupun status imunologis. Sebagai ilustrasi, tidak adanya BAK dalam 24 jam pertama atau tidak keluarnya mekonium dalam 48 jam pertama merupakan tanda bahaya yang memerlukan evaluasi lebih lanjut.
c. Edukasi keluarga: Bersamaan dengan proses pemeriksaan, tenaga kesehatan memberikan pendidikan kepada orang tua mengenai pembedaan tanda-tanda fisiologis dan patologis (misalnya ikterus/kuning fisiologis, muntah yang masih dalam batas normal, dan sebagainya), sehingga keluarga dapat berperan aktif melaporkan keluhan atau perubahan kondisi ke fasilitas pelayanan kesehatan, seperti puskesmas.
d. Dokumentasi layanan kesehatan: Hasil pemantauan dicatat secara sistematis pada Buku Kesehatan Ibu dan Anak (Buku KIA, lembar awal bayi) dan rekam medis. Dokumen ini berfungsi sebagai sumber data pertumbuhan neonatus sekaligus bukti bahwa pemantauan telah dilaksanakan sesuai standar yang ditetapkan (Kementerian Kesehatan, 2024).

Tercapainya pertumbuhan neonatus yang normal mencerminkan keberhasilan pemberian nutrisi (khususnya ASI) serta keberlangsungan adaptasi fisiologis yang optimal.

Pencatatan yang sistematis memiliki arti sangat penting. Seluruh hasil pemeriksaan, termasuk berat badan lahir dan berat badan pascalahir, temuan pemeriksaan fisik, serta pola makan dan eliminasi, harus didokumentasikan dalam Buku KIA dan rekam medis puskesmas sesuai pedoman Kementerian Kesehatan. Dokumen tersebut menjadi dasar untuk penilaian tumbuh kembang pada periode berikutnya. Selain itu, bidan perlu memberikan edukasi berkelanjutan kepada keluarga mengenai pemberian ASI, perawatan dan kebersihan tali pusat, serta tanda bahaya pada neonatus (misalnya tidak mau menyusu, demam, dan kesulitan bernapas), sehingga orang tua dapat melakukan pemantauan mandiri terhadap kondisi bayi di rumah.

Tabel di bawah merangkum jadwal kunjungan neonatus dan parameter utama yang diperiksa menurut pedoman nasional. Kunjungan standar: KN1 (6–48 jam pascalahir), KN2 (hari ke-3–7), KN3 (hari ke-8–28)

Waktu	**Hal yang Diperiksa & Dicatat**
Saat lahir (0 jam)	Berat lahir, panjang, lingkar kepala; status APGAR; pemberian vitamin K, imunisasi HepB0; inisiasi ASI.

Waktu	Hal yang Diperiksa & Dicatat
24 jam	Penimbangan berat (taksir penurunan ≤10%); awal menyusu ASI; frekuensi BAK/BAB pertama; keadaan umum (kesadaran, suhu).
48–72 jam	Berat badan; pola menyusu (≥8 kali/24 jam ASI); jumlah popok basah & keluarnya mekonium; tanda bahaya (tampak lemah, kuning dini).
7 hari	Berat badan (mencapai berat lahir); status ikterus fisiologis (beri edukasi); pemeriksaan penuh (fisik & neurologis); penilaian ASI.
14 hari	Berat badan (naik ~20–30 g/hari); perkembangan menyusui; frekuensi BAK/BAB yang memadai (≥4–5 kali BAB/dasar ASI); edukasi tumbuh-kembang.
28 hari	Berat badan (naik stabil sesuai kurva hijau WHO); vaksinasi Hepatitis B1; skrining akhir neonatus (PEB, refleks; deteksi dini masalah).

Jadwal Pemantauan Neonatus 0-28 Hari					
0	1	3	7	14	28
Lahir – Inisiasi ASI, Vit K, posyandu awal; ukur berat & panjang	24 jam-cek ulang berat, pola menyusu, BAK/BAB pertama	48–72 jam – Evaluasi kenaikan berat, keluarnya mekonium, stabilitas bayi	Hari ke 7 - Cek pertumbuhan berat, tanda ikterus, konseling laktasi	Hari ke 8- Timbang berat (naik ± 20 –30g/ hari), evaluasi kesehatan bayi	Hari ke-28 – Pemeriksaan akhir berat bayi, imunisasi, pertumbuhan

Poin Penting:

- Neonatus (0–28 hari) sangat rentan; hampir setengah kematian balita terjadi dalam periode ini.
- Pemantauan rutin dengan kunjungan terjadwal esensial untuk deteksi dini komplikasi.
- Indikator utama: berat badan, pola BAK/BAB, dan tanda hidrasi (turgor, fontanel, selaput lendir). Petugas kesehatan mencatat ini setiap kunjungan.
- Perubahan berat lahir 5–10% dalam 3–5 hari pertama adalah normal; bayi diharapkan kembali ke berat lahir -+10–14 hari.

- Bayi harus BAK dalam 24 jam dan BAB mekonium dalam 48 jam pertama. Keterlambatan lebih dari itu menandakan bahaya (mis. obstruksi)
- Dokumentasi di Buku KIA dan edukasi keluarga (pola menyusu, popok basah) membantu memastikan kontinuitas perawatan

2. Pemantauan Berat Badan Neonatus

Setelah lahir, bayi akan mengalami kehilangan cairan ekstrauterin melalui proses pernapasan, evaporasi, dan pengeluaran mekonium, sehingga berat badan umumnya menurun sekitar 5–10% dalam 3–5 hari pertama kehidupan. Sebagai ilustrasi, bayi dengan berat lahir 3000 g dapat mengalami penurunan berat hingga sekitar 2700–2850 g. Penurunan berat badan sampai dengan ≤ 10% dikategorikan sebagai proses fisiologis, sedangkan penurunan >10% perlu diwaspadai karena dapat mengindikasikan asupan ASI yang tidak adekuat atau terjadinya dehidrasi. Setelah fase tersebut, bayi diharapkan mulai mengalami kenaikan berat badan. Laju pertumbuhan berat badan tercepat terjadi pada dua tahun pertama kehidupan; pada periode neonatal, setelah minggu pertama, bayi diharapkan mengalami kenaikan sekitar 20–30 g per hari. Berat lahir umumnya tercapai kembali pada usia 10–14 hari.

Pemantauan berat badan dilakukan secara periodik. Bidan melakukan penimbangan bayi pada setiap kunjungan neonatal; apabila bayi dipulangkan sebelum 48 jam pascalahir, sangat penting dilakukan kunjungan rumah (home visit) untuk penimbangan ulang. Pencatatan berat badan dilakukan pada grafik pertumbuhan (WHO) atau KMS (Kartu Menuju Sehat) agar bidan dan orang tua dapat memantau tren kenaikan berat badan. Kegagalan peningkatan berat badan secara konsisten (tidak terdapat penambahan minimal 20 g per hari setelah minggu pertama) diklasifikasikan sebagai gangguan tumbuh dan memerlukan evaluasi lebih lanjut. Dalam praktik, bidan atau tenaga kesehatan perlu menginformasikan kepada ibu bahwa penurunan berat badan ringan merupakan hal yang fisiologis serta memberikan dukungan menyusui untuk mempercepat pemulihan dan peningkatan berat badan.

Penurunan dan Kenaikan Berat Badan Normal:

- 0–5 hari: Penurunan hingga 10% dari berat lahir (adaptasi normal)
- 5–14 hari: Penambahan berat mulai terlihat; berat lahir idealnya tercapai kembali pada akhir minggu ke-2
- >14 hari: Peningkatan berat -+20–30 g/hari, mendorong pertumbuhan kurva.

Klasifikasi Berat Lahir Rendah (BBLR): Menurut standar Kemenkes (2019), bayi lahir <2500 g dikategorikan BBLR. Klasifikasi lebih lanjut:

- BBLR: 1500–2499 g
- BBLSR (sangat rendah): 1000–1499 g.

- BBLER (ekstrem rendah): <1000 g.

Bayi BBLR dan prematur perlu pemantauan khusus (mis. suhu hangat, nutrisi tambahan) karena risiko komplikasinya lebih tinggi.

Faktor yang memengaruhi kenaikan berat badan bayi terutama adalah adekuasi asupan ASI. Kekurangan asupan ASI, misalnya karena proses laktasi yang belum optimal, maupun adanya kehilangan cairan atau energi tambahan akibat infeksi atau gangguan metabolik, dapat memperlambat laju pertumbuhan. Status gizi dan hidrasi ibu menyusui, serta frekuensi dan efektivitas sesi menyusui, juga berkontribusi terhadap kecepatan kenaikan berat badan bayi. Oleh karena itu, selain melakukan pengukuran berat badan, bidan perlu memberikan dukungan melalui konseling laktasi yang komprehensif.

Dalam hal pemantauan dan dokumentasi, seluruh data berat badan bayi harus dicatat secara akurat. WHO merekomendasikan penimbangan harian di unit perinatologi untuk bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR). Di luar fasilitas rumah sakit, penimbangan dilakukan pada setiap kunjungan ibu dan bayi sesuai jadwal pelayanan. Hasil penimbangan dicatat dalam Buku KIA dan dilaporkan sesuai pedoman pelaporan, misalnya melalui sistem pelaporan puskesmas. Komunikasi hasil penimbangan kepada orang tua (misalnya: "Berat badan bayi turun 7% dan saat ini sudah mulai meningkat") penting untuk mengurangi kecemasan, meningkatkan pemahaman, dan memastikan keberlanjutan tindak lanjut yang diperlukan.

3. Pola Eliminasi Neonatus

Eliminasi Feses (Defekasi). Mekonium merupakan feses pertama neonatus yang dikeluarkan dalam 24 jam pertama pascakelahiran, berupa material intrauterin berwarna hijau kehitaman dan bersifat lengket. Mekonium mulai terakumulasi sejak trimester kedua kehamilan. Pasca kelahiran, eliminasi mekonium secara keseluruhan diharapkan terjadi dalam 2–3 hari pertama. Selanjutnya, feses neonatus yang menerima ASI berubah menjadi warna kuning keemasan dengan konsistensi lembek. Pola eliminasi normal meliputi: mekonium pada hari pertama, feses transisi (campuran hijau-emas) pada hari kedua hingga ketiga, serta feses ASI berwarna kuning setelah hari keempat. Pada neonatus ASI, frekuensi defekasi biasanya mencapai 2–5 kali per hari, sedangkan neonatus susu formula cenderung menghasilkan feses lebih padat dengan frekuensi lebih rendah. Ketidakhadiran defekasi lebih dari 48 jam memerlukan pengawasan ketat terhadap kemungkinan obstruksi usus (seperti atresia) atau kelainan patologis lainnya. Oleh karena itu, bidan wajib menanyakan waktu eliminasi feses pertama (untuk mengonfirmasi pengeluaran mekonium) pada setiap kunjungan postnatal. Jika ibu melaporkan tidak adanya defekasi lebih dari 2 hari, neonatus harus

dievaluasi ulang guna menyingkirkan anomali, termasuk rujukan ke dokter spesialis.

Eliminasi Urine (Miksi). Urine pertama neonatus harus dikeluarkan dalam 24 jam pertama pascakelahiran. Frekuensi miksi pada neonatus sehat meningkat secara cepat, dimulai dari 4–8 kali per 24 jam (yang bertambah seiring peningkatan asupan cairan), hingga mencapai lebih dari 6 popok basah per 24 jam pada minggu pertama. Pada minggu pertama kehidupan, volume urine harian meningkat dari sekitar 30 mL menjadi 100–200 mL (Santoso, 2020). Warna urine normal berupa kuning muda; temuan urine berwarna pink atau keruh ringan pada hari pertama sering kali disebabkan oleh eritrosit intraseluler pascapartum. Output urine yang adekuat mencerminkan status hidrasi yang optimal; sebaliknya, jumlah popok basah kurang dari 2 kali per 24 jam mengindikasikan dehidrasi.

Implikasi Klinis. Pola eliminasi abnormal merupakan temuan klinis yang serius dan memerlukan intervensi segera. Misalnya, ketidakhadiran mekonium lebih dari 48 jam menunjukkan kemungkinan obstruksi mekanis. Oliguria (frekuensi miksi jarang) atau urine pekat mengindikasikan dehidrasi, sedangkan feses berdarah atau hematuria memerlukan penanganan darurat (misalnya perdarahan saluran cerna atau traktus urinaria). Bidan bertanggung jawab mencatat jumlah popok basah dan karakteristik feses pada setiap kunjungan, serta memberikan edukasi kepada ibu untuk mengenali tanda-tanda output urine rendah, seperti popok yang tidak basah atau cekungan mata neonatus.

4. Status Hidrasi Neonatus.

Hidrasi bayi dinilai melalui kombinasi tanda klinis dan data eliminasi. Karena neonatus memiliki volume cairan tubuh relatif tinggi, kehilangan kecil pun cepat berdampak. Tanda-tanda hidrasi meliputi :

- Turgor Kulit: Kulit neonatus kembali pelan bila dicubit (turgor kurang/cekung) menandakan dehidrasi; kulit kenyal menunjukkan hidrasi adekuat.
- Fontanel Anterior: Cekungnya fontanel (tengah ubun-ubun) adalah tanda dehidrasi berat; tidak boleh diabaikan.
- Perubahan Berat: Penurunan berat >5–10% awal dan gagal naikan berat dapat menunjukkan defisit cairan.
- Kelembapan Mukosa: Bibir/mulut kering mengindikasikan kurang cairan, selaput lendir lembab normal.
- Frekuensi BAK: ≥6 popok basah/24 jam menunjukkan intake dan sirkulasi cukup

Apabila bayi mengalami muntah berulang, menangis dengan suara sangat lemah, atau tampak letargis dan tidak responsif, kondisi tersebut perlu segera

dicurigai sebagai tanda dehidrasi berat. Penatalaksanaan utama berfokus pada upaya rehidrasi, yang dapat dilakukan melalui peningkatan frekuensi pemberian ASI, pemberian larutan rehidrasi oral, atau cairan intravena di fasilitas pelayanan kesehatan. Sebaliknya, kondisi kelebihan cairan (misalnya pada bayi dengan gagal jantung kongestif) harus dihindari dan dikelola secara hati-hati. Secara praktis, evaluasi tanda vital (terutama takikardia pada dehidrasi) dan pemantauan jumlah keluaran urin (jumlah popok basah) merupakan cara sederhana untuk menilai status hidrasi dalam pemantauan harian. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menekankan pentingnya pemantauan kadar natrium serum: kadar natrium tinggi mengindikasikan dehidrasi, sedangkan kadar natrium rendah mengindikasikan overhidrasi. Bidan diharapkan memantau indikator-indikator tersebut pada setiap kunjungan, serta memberikan edukasi kepada keluarga mengenai tanda-tanda dehidrasi (antara lain mata cekung, ketiadaan air mata saat menangis) untuk memungkinkan intervensi dini.

5. Peran Tenaga Kesehatan dalam Asuhan Neonatus.

   Bidan dan tenaga kesehatan neonatal (dokter, perawat) memiliki peran sentral dalam pemantauan kondisi neonatus. Peran tersebut meliputi :

   - Pemeriksaan fisik menyeluruh: Pada setiap kunjungan, bidan melakukan penilaian lengkap terhadap status bayi, termasuk tanda vital, kemampuan menyusu, tonus otot, dan refleks fisiologis, serta memastikan pencatatan berat badan. Pemeriksaan fisik sebaiknya dilakukan setelah bayi dalam keadaan hangat dan stabil.
   - Pemantauan nutrisi dan eliminasi: Bidan mengkaji pola menyusu (sekitar ≥8 kali dalam 24 jam), menghitung jumlah popok basah, serta menilai frekuensi buang air besar. Setiap penyimpangan dari pola normal diidentifikasi secara dini untuk ditindaklanjuti.
   - Deteksi dini masalah kesehatan: Bidan bertugas mengenali tanda bahaya neonatal, seperti gangguan pernapasan, asupan minum yang tidak adekuat, ikterus dini, dan kejang, sesuai dengan standar pelatihan neonatal. Bayi yang menunjukkan gejala tersebut harus segera mendapatkan penatalaksanaan, termasuk penyesuaian pemberian cairan atau rujukan ke rumah sakit.
   - Edukasi keluarga: Bidan memberikan edukasi komprehensif kepada orang tua mengenai teknik menyusui yang benar, cara melakukan pemantauan kondisi bayi di rumah (misalnya memperhatikan popok basah dan frekuensi menyusu), serta tanda bahaya yang perlu diwaspadai. Peningkatan pengetahuan ini memperkuat keterlibatan keluarga dalam proses monitoring neonatus.
   - Dokumentasi dan pelaporan: Seluruh hasil pemeriksaan dicatat secara sistematis dalam Buku KIA dan rekam medis. Selain itu, bidan berkewajiban

melaporkan cakupan kunjungan neonatal ke puskesmas sesuai pedoman yang berlaku, sebagai dasar evaluasi program kesehatan ibu dan anak.

Melalui kolaborasi antara kunjungan terjadwal dan pemberdayaan keluarga, kondisi setiap neonatus dapat dipantau secara optimal. Dengan demikian, berbagai masalah seperti gagal tumbuh, infeksi, maupun malnutrisi dapat terdeteksi dan ditangani sejak dini, sehingga peluang bayi untuk tumbuh dan berkembang secara sehat pada tahap usia berikutnya menjadi lebih besar.

Aktivitas 1 — *Knows How*

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Contoh :

Seorang anak jenis kelamin Perempuan, usia 24 bulan, datang ke TPMB bersama ibu dan ayahnya pukul 08.00 mengatakan ingin melakukan pemeriksaan tumbuh kembang karena sudah 2 bulan di timbang di posyandu tidak naik berat badannya. Hasil pemeriksaan awal : keadaan umum baik, BB 9000 gram, PB 85 cm, Lingkar kepala 45 cm, LILA 12,5 cm, lingkar dada 55 cm, BJA 125x/menit, suhu 36,8°C. Ibu mengatakan memiliki memiliki Riwayat di keluarganya tinggi bada pendek. Anaknya selesai menyusui 2 tahun, ASI Eksklusif (+), imunisasi dasar lengkap (+), pola makan normal, pola istirahat normal, pola aktivitas normal, BAB 1-2 kali/hari, BAK 3-4 x/hari. Riwayat sakit dalam 3 bulan terakhir (-). Riwayat BB lahir (2,7 kg); PB lahir (48 cm).

Pertanyaan Diskusi

1. Apa masalah utama pada kasus di atas?
2. Data apa saja yang mendukung analisis Anda?
3. Berdasarkan konsep 3P, faktor mana yang paling mungkin menjadi penyebab utama?
4. Adakah tanda bahaya apa yang mulai muncul pada anak?
5. Apa tindakan awal yang harus dilakukan bidan pada kasus ini?
6. Apakah kasus ini masih dapat ditangani expectant di fasilitas awal, atau perlu eskalasi/rujukan? Jelaskan alasan Anda.
7. Informasi penting apa yang harus disampaikan bidan kepada ibu dan keluarga sebelum tindakan lanjutan atau rujukan?

Aktivitas 2 — *Shows How*

Pemantauan Pertumbuhan Neonatus: Berat Badan, Pola Eliminasi, dan Status Hidrasi

Fokus urutan tindakan + komunikasi + keselamatan

Catatan untuk penulis:

- Tidak loncat ke ujian
- Mahasiswa naik tangga kompetensi

Asesmen (Piramida Miller)

Level Miller	Metode
Knows / Knows How	Self-check + analisis mini-case
Shows How	OSCE Pemantauan Berat Badan, Pola Eliminasi, dan Status Hidrasi

Catatan untuk penulis:

- Karena CP Bab = *mendemonstrasikan*OSCE logis, bukan dipaksakan

OSCE Ringkas + Critical Items

Critical Items (WAJIB LULUS)

- Penimbangan berat badan balita
- Melakukan pengkajian riwayat eliminasi
- Menilai status hidrasi

Cuplikan Rubrik

Kriteria	4	3	2	1
Keselamatan pasien	Aman & konsisten	Minor	Risiko kecil	Tidak aman
Asesmen & keputusan	Tepat & jelas	Cukup	Ragu	Keliru
Komunikasi	Empatik & jelas	Baik	Kurang	Buruk

Catatan untuk penulis:

- Nilai tinggi tidak menutup kegagalan keselamatan

TEMPLATE SOAL OSCE KEBIDANAN

No.	Komponen	Isi
1	No. Stasiun	5
2	Judul	Balita, Anak, Prasekolah
3	Kasus	Tumbuh kembang
4	Tujuan	Untuk mengetahui bahwa peserta dapat menunjukkan kriteria sebagai calon bidan yang kompeten dalam :
5	Kompetensi	1. **Anamnesis** 2. **Pemeriksaan fisik dan/atau laboratorium sederhana** 3. **Perumusan diagnosis dan/atau masalah** 4. **Prosedur tindakan klinis** **5. KIE/konseling** **6. Kolaborasi/rujukan** **7. Perilaku profesional**
6	Soal: Skenario dan tugas peserta ujian	SKENARIO KLINIK Seorang anak jenis kelamin Perempuan, usia 24 bulan, datang ke TPMB bersama ibu dan ayahnya pukul 08.00 mengatakan ingin melakukan pemeriksaan tumbuh kembang karena sudah 2 bulan di timbang di posyandu tidak naik berat badannya. Hasil pemeriksaan awal : keadaan umum baik, BB 9000 gram, PB 85 cm, Lingkar kepala 45 cm, LILA 12,5 cm, lingkar dada 55 cm, BJA 125x/menit, suhu 36,8°C. Ibu mengatakan memiliki memiliki Riwayat di keluarganya tinggi bada pendek. Anaknya selesai menyusui 2 tahun, ASI Eksklusif (+), imunisasi dasar lengkap (+), pola makan normal, pola istirahat normal, pola aktivitas normal, BAB 1-2 kali/hari, BAK 3-4 x/hari. Riwayat sakit dalam 3 bulan terakhir (-). Riwayat BB lahir (2,7 kg); PB lahir (48 cm). TUGAS 1. Lakukan anamnesis terarah sesuai kasus. 2. Lakukan pemeriksaan fisik terfokus sesuai kasus. 3. Sampaikan diagnosis/masalah kebidanan berdasarkan data yang diperoleh. 4. Lakukan tindakan awal yang tepat pada kasus tersebut. 5. Berikan KIE singkat kepada ibu/keluarga dan jelaskan rencana kolaborasi/rujukan.

No.	Komponen	Isi
7	Instruksi penguji	INSTRUKSI UMUM 1. Pastikan identitas peserta ujian sesuai dengan kartu ujian. 2. Tulislah nomor peserta berdasarkan jumlah peserta yang ikut : a. Ujian institusi- 2 digit jika peserta berjumlah 01–99-3 digit jika peserta berjumlah 100–999-4 digit terakhir jika menggunakan NIM peserta b. Ujian nasional- 4 digit jika peserta berjumlah ribuan-atau 4 digit terakhir bila nomor mengikutkan kode area dan lebih dari 4 angka 3. Amati peserta dan beri penilaian pada lembar penilaian yang disesuaikan dengan format penilaian : - Actual mark (0/1/2/3) - Global rating (1/2/3/4) 4. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interaksi apa pun kepada peserta selain yang ditentukan. 5. Taatilah peraturan dan laksanakan tugas sebagai penguji OSCE. INSTRUKSI KHUSUS 1. Jika peserta melakukan anamnesis dengan benar, PS menjawab sesuai dialog PS. 2. Jika peserta menyatakan akan melakukan penimbangan berat badan anak dengan benar, pengkajian Riwayat eliminasi dengan benar, dan pemantauan pola hidrasi dengan benar 3. Jika peserta meminta hasil pemeriksaan dalam atau interpretasi, penguji memberikan data: Hasil pemeriksaan awal : keadaan umum baik, BB 9000 gram, PB 85 cm, Lingkar kepala 45 cm, LILA 12,5 cm, lingkar dada 55 cm, BJA 125x/menit, suhu 36,8°C. 4. Diharapkan dari peserta meliputi:- Menilai ulang kondisi anak secara cepat-Menjelaskan kondisi anak secara singkat dan jelas- Menjelaskan hasil pemeriksaan dengan akurat -Memberikan dukungan emosional dan KIE singkat.

No.	Komponen	Isi
		5. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang ditentukan. 6. Penguji memberikan data tambahan hanya jika diminta atau jika peserta melakukan langkah pemeriksaan yang sesuai. INSTRUKSI TAMBAHAN 1. Rapikan alat yang telah digunakan oleh peserta ujian seperti keadaan semula agar siap digunakan oleh peserta berikutnya. 2. Siapkan lembar baru untuk lembar habis pakai dan pastikan lembar yang sudah diisi peserta sebelumnya telah diambil dan diberi identitas peserta.
8	Kebutuhan dan instruksi PS	Instruksi PS: 4. PS berperan sebagai ibu dan anak 5. PS tampak biasa tidak menunjukan rasa sakit. Ibu terlihat tampak cemas. 6. Bila peserta memberikan penjelasan atau dukungan, PS merespons kooperatif. 7. Bila peserta menyampaikan bahwa ibu perlu dirujuk, PS tampak khawatir tetapi bersedia mengikuti arahan.
9	Dialog PS	Peserta: Selamat pagi/siang, Bu dan dede bayi. PS: Pagi/siang, Bu Bidan Peserta: Saya bidan yang akan memeriksa anak ibu. Apakah ibu bersedia? PS: Iya, Bu, saya bersedia. Peserta: Apa keluhan utama anak ibu? PS: Saya ingin memeriksa tumbuh kembang anak saya, karena sudah 2 bulan tidak ada kenaikan berat badan. Peserta: Baik. Bagaimana Riwayat pola makan dede bayinya bu ? PS: Seperti biasa, makan 3 x 1. Setiap makan 1 porsi habis, ada nasi, lauk dan sayur Peserta : bagaimana pola aktivitasnya ? PS : anak saya sangat aktif Peserta : bagaimana pola tidurnya ?

No.	Komponen	Isi
		PS : anak saya jarang tidur siang, tidur malam rata-rata 6-8 jam mulai jam malam bangun jam 5 pagi. Peserta : bagaimana pola BAB dan BAKnya ? PS : BAB 1-1 kali/hari, dan BAK 3-4 kali/hari. Peserta : bagaimana pola minumnya ? PS : anak saya sudah selesai menyusunya, susu formula diberikan sejak usia > 6 bulan, ASI eksklusif 6 bulan Catatan: Jika ada pertanyaan lain terkait riwayat penyakit, riwayat perinatal, sosial, spiritual, ekonomi, dan ADL, PS memberi jawaban normatif dan tidak mengarah ke diagnosis lain.
10	Kebutuhan manikin	- Alat pemeriksaan fisik anak - Buku KIA pink - KMS - KPSP/DDST
11	Kebutuhan laboran	Peran laboran: - Menyiapkan dan merapikan kembali alat - Mengganti lembar KMS bila diperlukan - Memastikan set station siap digunakan peserta berikutnya
12	Kebutuhan alat	1. Tempat tidur/periksa — 1 2. Tensimeter — 1 3. Stetoskop anak — 1 4. Jam tangan/stopwatch — 1 5. Termometer — 1 6. Sarung tangan bersih — 1 pasang 7. Handrub — 1 botol 8. Kain penutup/selimut — 1 9. Tissue — 1 pack 10. Lembar jawaban peserta — 1 lembar 11. Pena — 1 12. KMS-(sesuai jumlah peserta) 13. Lembar anamnesa 14. Lembar kosong dokumentasi SOAP
13	Penulis	Annisa Ridlayanti, S.Keb.,Bd.,M.Keb

No.	Komponen	Isi
14	Referensi	1. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Standar profesi bidan: Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/320/2020. 2. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Standar kompetensi kerja bidang kebidanan: Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1261/2022. 3. World Health Organization. (2008). Education material for teachers of midwifery: Midwifery education modules (2nd ed.): Managing prolonged and obstructed labour. 4. World Health Organization. (2018). WHO recommendations: Intrapartum care for a positive childbirth experience.

DOPS (Does)

DOPS di Lahan Praktik

- Melakukan penimbangan berat badan, mengkaji Riwayat eliminasi, menilaistuatus hidrasi
- Checklist + umpan balik singkat
- Keputusan: kompeten / supervisi / remedial

Catatan untuk penulis:

- Dari simulasi → praktik nyata
- Bukti performa sesungguhnya

Contoh Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada Kasus Bayi, Balita, dan Anak Prasekolah : Pemantauan Pertumbuhan Neonatus (Berat Badan, Pola Eliminasi, dan Status Hidrasi)

Komponen	**Deskripsi**	**Contoh pada Kasus pemantauan pertumbuhan neonatus (Berat Badan, Pola Eliminasi, dan status Hidrasi)**
Metode penilaian	DOPS merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap keterampilan prosedural. Penilai mengamati tindakan yang dilakukan peserta, lalu memberikan umpan balik segera setelah prosedur selesai. Domain yang lazim dinilai mencakup informed consent, persiapan pra-tindakan, kemampuan teknis, komunikasi, profesionalisme, dan keselamatan pasien.	Pembimbing mengamati secara langsung bagaimana mahasiswa melakukan pengkajian dan pemeriksaan fisik pada anak balita, lalu menilai keterampilan mahasiswa saat melakukan tindakan awal dan memberikan konseling.
Tujuan penilaian	Tujuan DOPS pada topik ini adalah menilai kemampuan mahasiswa melakukan tindakan awal yang aman, cepat, dan sistematis pada asuhan kebidanan bayi balita dan anak pra sekolah dengan tetap berpusat pada	Mahasiswa tidak hanya dinilai dari pengetahuannya tentang pengkajian balita, tetapi dari kemampuannya menilai kondisi balita, membaca data hasil, menegakan diagnosa, melakukan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus pemantauan pertumbuhan neonatus (Berat Badan, Pola Eliminasi, dan status Hidrasi)
	keselamatan ibu dan anak serta penghormatan pada asuhan yang bermartabat.	tata laksana awal, dan menjelaskan kebutuhan kolaborasi atau rujukan.
Kasus klinik	Kasus dipilih dari situasi nyata di lahan praktik yang sesuai dengan capaian pembelajaran profesi bidan, khususnya pengenalan penimbangan berat badan, pengkajian pola eliminasi, dan asupan hidrasi.	Seorang anak jenis kelamin Perempuan, usia 24 bulan, datang ke TPMB bersama ibu dan ayahnya pukul 08.00 mengatakan ingin melakukan pemeriksaan tumbuh kembang karena sudah 2 bulan di timbang di posyandu tidak naik berat badannya. Hasil pemeriksaan awal : keadaan umum baik, BB 9000 gram, PB 85 cm, Lingkar kepala 45 cm, LILA 12,5 cm, lingkar dada 55 cm, BJA 125x/menit, suhu 36,8°C. Ibu mengatakan memiliki memiliki Riwayat di keluarganya tinggi bada pendek. Anaknya selesai menyusui 2 tahun, ASI Eksklusif (+), imunisasi dasar lengkap (+), pola makan normal, pola istirahat normal, pola aktivitas normal, BAB 1-2 kali/hari, BAK 3-4 x/hari. Riwayat sakit dalam 3 bulan terakhir (-). Riwayat BB lahir (2,7 kg); PB lahir (48 cm).
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Pada DOPS, mahasiswa diamati saat melakukan prosedur atau rangkaian tindakan klinik tertentu, bukan sekadar berdiskusi tentang kasus. Pada topik ini, keterampilan yang relevan antara lain menilai keadaan umum anak balita, tanda	Mahasiswa memperkenalkan diri, meminta persetujuan orang tua klien, melakukan pengkajian, melakukan pemeriksaan fisik anak balita, melakukan inputing hasil pemeriksaan ke KMS, menganalisis

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus pemantauan pertumbuhan neonatus (Berat Badan, Pola Eliminasi, dan status Hidrasi)
	vital, pemeriksaan fisik, memberikan konseling.	data, dam memberikan konseling anak balita.
Aspek yang dinilai	Aspek yang dinilai meliputi pemahaman indikasi tindakan, persetujuan tindakan, persiapan pra-prosedur, kemampuan teknis, komunikasi, kemampuan mencari bantuan ketika diperlukan, rencana pascatindakan, dan profesionalisme.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa memperkenalkan diri, meminta persetujuan orang tua klien, melakukan pengkajian, melakukan pemeriksaan fisik anak balita, melakukan inputing hasil pemeriksaan ke KMS, menganalisis data, dan memberikan konseling anak balita.
Fokus observasi pembimbing	Fokus observasi pembimbing adalah mutu performa nyata mahasiswa saat melakukan tindakan.	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa tepat melakukan tindakan .
Umpan balik	Umpan balik dalam DOPS diberikan segera setelah observasi dan berisi apa yang sudah efektif serta apa yang perlu diperbaiki. Form DOPS juga menekankan komentar assessor mengenai kekuatan, area yang perlu ditingkatkan, dan rencana perbaikan.	Pembimbing dapat menyampaikan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi dan membubuhkan hasil penimbangan BB di KMS, tetapi masih perlu meningkatkan ketegasan saat memutuskan eskalasi, ketelitian dalam menilai analisis data kepada keluarga.
Keputusan penilaian	Dalam buku ajar ini, hasil DOPS dapat diringkas menjadi kompeten, perlu supervisi, atau remedial. Keputusan ditetapkan berdasarkan ketepatan langkah, keselamatan pasien, komunikasi, dan kemampuan mengambil keputusan awal.	Mahasiswa dinyatakan kompeten apabila mampu melakukan tindakan awal secara runtut, aman, dan tepat. Mahasiswa dinyatakan perlu supervisi apabila langkah utama sudah benar tetapi masih memerlukan arahan. Mahasiswa dinyatakan remedial apabila gagal

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus pemantauan pertumbuhan neonatus (Berat Badan, Pola Eliminasi, dan status Hidrasi)
		mengenali kegawatan, salah menentukan prioritas, atau tidak menyiapkan eskalasi dengan benar.
Makna dalam OBE	DOPS memberikan bukti autentik bahwa mahasiswa mampu menunjukkan capaian pembelajaran pada level does karena performanya diamati langsung saat melakukan tindakan klinik. Observasi langsung pada pasien nyata dan umpan balik segera menjadikan DOPS sangat sesuai untuk pembelajaran berbasis kompetensi.	Pada kasus bayi balita, anak prasekolah ini, mahasiswa dinilai bukan hanya memahami teori, tetapi mampu menerapkan tindakan/ asuhan secara langsung, aman, cepat, dan profesional di lahan praktik.

Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

- OSCE + DOPS
- Catatan kasus singkat
- Refleksi patient safety
- Feedback CI/dosen

Catatan untuk penulis:

- Bukan sekali ujian
- Bukti konsistensi kompetensi

Tabel 2. 1 Portofolio pada Kasus pemantauan pertumbuhan neonatus (Berat Badan, Pola Eliminasi, dan status Hidrasi)

Komponen	**Deskripsi**	**Contoh pada Kasus pemantauan pertumbuhan neonatus (Berat Badan, Pola Eliminasi, dan status Hidrasi)**
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu, bukan hanya dari satu kali ujian.	Pada topik partus lama dan distosia, portofolio memuat bukti bahwa mahasiswa mampu melakukan pengkajian, menilai antropometric, melakukan pemeriksaan fisik, serta memperbaiki performa berdasarkan umpan balik.
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik.	Mahasiswa tidak hanya menunjukkan bahwa ia pernah melakukan penimbangan BB balita, tetapi juga menunjukkan bagaimana kemampuannya berkembang setelah mendapat masukan dari dosen atau CI.
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS dapat menjadi bagian penting dalam portofolio karena memberikan bukti keterampilan terstruktur di laboratorium dan bukti performa nyata di lahan praktik.	OSCE dapat memuat hasil ujian keterampilan, melakukan pengkajian interpretasi hasil, melakukan penanganan pada kasus balita , dan konseling asuhan yang diberikan. DOPS memuat hasil observasi langsung saat mahasiswa melakukan tindakan.
Catatan kasus singkat	Catatan kasus singkat berisi ringkasan kasus pasien yang pernah ditangani mahasiswa, data penting, masalah kebidanan, tindakan utama, dan hasil yang dicapai.	Mahasiswa menuliskan ringkasan SOAP dari asuhan yang diberikan. Diagnosa pasien : Balita 24 bulan, dalam keadaan normal.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus pemantauan pertumbuhan neonatus (Berat Badan, Pola Eliminasi, dan status Hidrasi)
Refleksi patient safety	Refleksi patient safety menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi kesalahan, dan menyusun langkah pencegahan dalam asuhan kebidanan.	Mahasiswa merefleksikan pentingnya penanganan pasien safety pada saat melakukan asuhan pada balita
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari Clinical Instructor (CI) atau dosen menjadi bukti pembinaan yang menunjukkan area kekuatan dan area yang masih perlu ditingkatkan.	CI menuliskan bahwa mahasiswa sudah baik dalam mengenali kasus dan menjelaskan hasil asuhan, tetapi masih perlu meningkatkan ketelitian dalam menganalis hasil dari pengukuran KMS.
Karakteristik penilaian	Portofolio bukan penilaian sekali selesai, tetapi kumpulan bukti yang dibangun secara berulang dan berkesinambungan. Penekanan utamanya adalah konsistensi performa mahasiswa.	Mahasiswa dinilai bukan hanya dari satu kasus, tetapi dari beberapa pengalaman belajar yang menunjukkan bahwa ia konsisten mampu menilai seluruh asuhan kebidanan balita secara komprehensif
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio memperlihatkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan mutu performa pada berbagai kesempatan praktik dan pada waktu yang berbeda.	Dari hasil OSCE, DOPS, catatan kasus, refleksi, dan umpan balik, terlihat bahwa mahasiswa secara konsisten mampu menggunakan, mengenali, dan mengambil keputusan awal yang tepat pada kasus balita ini,
Makna dalam OBE	Dalam OBE, portofolio memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tidak hanya dimiliki	Pada topik ini, portofolio menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya paham

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus pemantauan pertumbuhan neonatus (Berat Badan, Pola Eliminasi, dan status Hidrasi)
	secara teoritis, tetapi benar-benar tampak dalam performa yang berulang, berkembang, dan terdokumentasi.	konsep, tetapi juga konsisten mampu menerapkannya dalam praktik kebidanan nyata.

Tabel 2. 2 Case Report pada Kasus pemantauan pertumbuhan neonatus (Berat Badan, Pola Eliminasi, dan status Hidrasi)

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus pemantauan pertumbuhan neonatus (Berat Badan, Pola Eliminasi, dan status Hidrasi)
Hakikat case report	Case report merupakan laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien yang ditangani mahasiswa selama praktik klinik. Dalam OBE, case report berfungsi sebagai bukti kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan mendokumentasikan kasus secara ilmiah dan klinis.	Mahasiswa menyusun laporan singkat tentang anak balita umur 24 bulan
Tujuan	Case report bertujuan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data pengkajian, masalah kebidanan, rencana tindakan, implementasi, dan evaluasi hasil asuhan.	Mahasiswa tidak hanya menuliskan data balita, tetapi pengukuran antropometri, pola eliminasi, dan pola hidrasi tetapi juga menjelaskan masalah prioritas, tindakan awal yang diberikan, dan perkembangan kondisi balita setelah intervensi awal.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus pemantauan pertumbuhan neonatus (Berat Badan, Pola Eliminasi, dan status Hidrasi)
Isi laporan	Isi case report biasanya mencakup identitas singkat pasien, keluhan utama, data subjektif dan objektif, analisis masalah, diagnosis/masalah kebidanan, tindakan, implementasi, evaluasi, dan pembelajaran dari kasus.	Pada kasus ini, mahasiswa seorang anak jenis kelamin Perempuan, usia 24 bulan, datang ke TPMB bersama ibu dan ayahnya pukul 08.00 mengatakan ingin melakukan pemeriksaan tumbuh kembang karena sudah 2 bulan di timbang di posyandu tidak naik berat badannya. Hasil pemeriksaan awal : keadaan umum baik, BB 9000 gram, PB 85 cm, Lingkar kepala 45 cm, LILA 12,5 cm, lingkar dada 55 cm, BJA 125x/menit, suhu 36,8°C. Ibu mengatakan memiliki memiliki Riwayat di keluarganya tinggi bada pendek. Anaknya selesai menyusui 2 tahun, ASI Eksklusif (+), imunisasi dasar lengkap (+), pola makan normal, pola istirahat normal, pola aktivitas normal, BAB 1-2 kali/hari, BAK 3-4 x/hari. Riwayat sakit dalam 3 bulan terakhir (-). Riwayat BB lahir (2,7 kg); PB lahir (48 cm).
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan pengkajian, relevansi analisis masalah, logika penalaran klinik, ketepatan tindakan awal, dan kemampuan mengevaluasi hasil asuhan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu melakukan pengkajian, pemeriksaan fisik, menegakan diagnose, dan melakukan asuhan kebidanan pada balita.
Nilai edukatif	Case report membantu mahasiswa mengembangkan clinical reasoning,	Dari kasus balita ini, mahasiswa belajar melakukan pengukuran

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus pemantauan pertumbuhan neonatus (Berat Badan, Pola Eliminasi, dan status Hidrasi)
	keterampilan dokumentasi, dan kebiasaan merefleksikan praktik klinik secara ilmiah.	antropomteris khususnya berat badan, melakukan pengkajian pola eliminasi, dan pola hidrasi.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, case report menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori ke dalam analisis kasus nyata secara sistematis dan bertanggung jawab.	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya memahami konsep monitoring BB balita, melakukan anamnesa Riwayat hidrasi dan eliminasi tetapi juga mampu menyusun laporan kasus yang menggambarkan asuhan kebidanan secara utuh.

Tabel 2. 3 Refleksi Patient Safety pada Kasus pemantauan pertumbuhan neonatus (Berat Badan, Pola Eliminasi, dan status Hidrasi)

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus pemantauan pertumbuhan neonatus (Berat Badan, Pola Eliminasi, dan status Hidrasi)
Hakikat refleksi patient safety	Refleksi patient safety merupakan tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi masalah, dan merencanakan tindakan pencegahan.	Pada kasus ini, mahasiswa merefleksikan bahwa pemantauan berat badan, pola eliminasi, dan hidrasi sangat penting pada balita,
Tujuan	Refleksi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran mahasiswa bahwa keselamatan pasien merupakan bagian	Mahasiswa memahami bahwa kesalahan kecil dalam melihat hasil pengukuran berat badan dan menginputkannya pada grafik BB (WHO) di KMS dapat berdampak

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus pemantauan pertumbuhan neonatus (Berat Badan, Pola Eliminasi, dan status Hidrasi)
	penting dari setiap tindakan kebidanan.	besar pada pertumbuhan dan perkembangan balita .
Fokus refleksi	Fokus refleksi meliputi identifikasi risiko, analisis penyebab, tindakan pencegahan, dan pembelajaran yang diperoleh mahasiswa dari pengalaman klinik.	Mahasiswa menuliskan bahwa risiko utama pada kasus ini adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan jika tidak dipantau dengan benar.
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa perlu menunjukkan kemampuan mengenali situasi yang berpotensi membahayakan pasien.	Risiko yang dapat diidentifikasi antara lain kekeliruan dalam interpretasi data, kesalahan dalam mendiagnosa, ketidaklengkapan data anamnesa yang dieroleh, keliru dalam memberikan asuhan/konseling
Tindakan pencegahan	Mahasiswa menjelaskan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko keselamatan pasien.	Mahasiswa menuliskan pentingnya persiapan rujukan jika terjadi masalah potensial pada kasus balita.
Pembelajaran mahasiswa	Refleksi harus menunjukkan apa yang dipelajari mahasiswa dan bagaimana hal itu akan memengaruhi praktik berikutnya.	Mahasiswa menyadari bahwa pada kasus anak balita, pengkajian awal, pengambilan Keputusan yang tepat, dan keberanian melakukan eskalasi adalah bagian penting dari praktik bidan yang aman.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, refleksi patient safety menunjukkan perkembangan sikap professional, tanggung jawab klinik, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa terhadap keselamatan pasien.	Mahasiswa membuktikan bahwa ia tidak hanya melakukan tindakan, tetapi juga mampu mengevaluasi risiko dan meningkatkan kualitas praktik asuhan kebidanan secara berkelanjutan.

B. Ringkasan

1. Pemantauan Pertumbuhan Neonatus : berat Badan, Pola Eliminasi, dan Status Hidrasi
   - Neonatus (bayi usia 0–28 hari) membutuhkan pemantauan ketat untuk memastikan adaptasi fisiologis yang normal setelah lahir. Pemantauan meliputi berat badan, eliminasi (urine/BAB), dan status hidrasi. Dengan pemeriksaan berkala (kunjungan neonatus 1–3) yang terjadwal, intervensi dini dapat diberikan jika ditemukan kegagalan adaptasi (WHO 2024; Kemenkes 2024).
   - Setelah lahir, bayi akan mengalami kehilangan cairan ekstrauterin melalui proses pernapasan, evaporasi, dan pengeluaran mekonium, sehingga berat badan umumnya menurun sekitar 5–10% dalam 3–5 hari pertama kehidupan. Berat lahir umumnya tercapai kembali pada usia 10–14 hari.
   - Pola eliminasi pada bayi dan balita terdiri dari eliminasi feses (defekasi), eliminasi urine (miksi), implikasi klinis
   - Status hidrasi anak balita dinilai melalui kombinasi tanda klinis dan data eliminasi. Karena neonatus memiliki volume cairan tubuh relatif tinggi, kehilangan kecil pun cepat berdampak. Tanda-tanda hidrasi meliputi turgor kulitam frontanel anterior, perubahan berat, kelembapan mukosa, frekuensi BAK
2. Alur asuhan singkat

   Anak balita datang untuk dilakukan pemantauan tumbuh kembang → anamnesa atau pengkajian data subjektif secara komprehensif dan holistik → melakukan pemeriksaan fisik, tanda vital, dan antropometrik → menegakan diagnose → melakukan asuhan atau tindakan yang diperlukan → melakukan *follow-up* → mendokumentasikan asuhan yang diberikan.

Tabel 2. 4 Red Flags & Eskalasi

Red flags	**Makna klinis**	**Tindakan eskalasi**
BJA <110 x/menit atau >160 x/menit	Menunjukkan kemungkinan gawat janin	Berikan oksigen, lakukan rujukan
Anak tampak sangat lelah, gelisah, dehidrasi, nadi meningkat, atau suhu meningkat	Menunjukkan perburukan kondisi anak dan risiko infeksi/kelelahan persalinan	Stabilisasi awal, cairan sesuai kebutuhan, pantau ketat, kolaborasi/rujukan
Anak tampak kesakitan karena sulitan BAB/BAK atau sering BAB/BAK	Menunjukan permasalahan pada system pencernaan anak, system perkemilhan, dan system ekskresi	Lakukan tidnakan awal, cairan sesuai kebutuhan, pantau ketat, kolaborasi/rujukan
Keputusan rujukan sudah jelas tetapi proses tertunda	Menambah risiko ibu dan janin	Aktifkan rencana rujukan tanpa delay, lengkapi handover, komunikasikan ke keluarga dan fasilitas penerima

Form Checklist "Saya sudah bisa..."

Nama Mahasiswa :_____

NIM :_____

Tanggal :_____

Tempat Praktik / Skill Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan pengertian balita	☐	☐	_____
2	Saya sudah bisa menjelaskan grafik berat badan	☐	☐	_____
3	Saya sudah bisa melakukan anamnesis terarah pada ibu sesuai kasus anaknya	☐	☐	_____
4	Saya sudah bisa menginput hasil pengukuran berat badan anak pada KMS dari data yang tersedia	☐	☐	_____
5	Saya sudah bisa membaca KMS dan mengenali cara pengisiannya.	☐	☐	_____
6	Saya sudah bisa mengidentifikasi kemungkinan penyebab data tidak sesuai	☐	☐	_____
7	Saya sudah bisa melakukan anamnesa pola hidrasi pada anak	☐	☐	_____
8	Saya sudah bisa melakukan anamnesa pola eliminasi pada anak balita	☐	☐	_____
9	Saya sudah bisa melakukan tindakan awal yang aman sesuai kewenangan bidan	☐	☐	_____
10	Saya sudah bisa menegakan diagnose pada anak balita	☐	☐	_____
11	Saya sudah bisa menyiapkan asuhan yang akan diberikan pada anak secara cepat dan sistematis	☐	☐	_____
12	Saya sudah bisa menjelaskan kondisi anak kepada keluarga dengan bahasa sederhana	☐	☐	_____
13	Saya sudah bisa menentukan kapan kasus harus dikolaborasikan atau dirujuk segera	☐	☐	_____
14	Saya sudah bisa melaksanakan asuhan pada anak balita sesuai dengan kebutuhan	☐	☐	_____
15	Saya sudah bisa mendokumentasikan temuan dan tindakan awal secara ringkas dan tepat	☐	☐	_____

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
16	Saya sudah bisa menjaga privasi, keselamatan, dan perilaku profesional selama tindakan	☐	☐	_____

Refleksi singkat mahasiswa:

Referensi

Armini, N. W., Sriasih, N. G. K., & Marhaeni, G. A. (2017). *Asuhan kebidanan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah*. Andi.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). *Buku kesehatan ibu dan anak (KIA)*. Kementerian Kesehatan RI.

Kartini, Pitri, Z. Y., Wijayati, W., Wahyuni, Astutik, L. P., Lubis, K., Ningtyas, S. F., Nugraheni, D. E., Widyandini, M., Safitri, N., Fajrin, I., Darmawati, D., Nilawati, I., & Luthfa, A. (2024). *Asuhan kebidanan neonatus, bayi, dan balita*. CV Eureka Media Aksara.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). *Laporan nasional Riskesdas 2018*. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.

Octa Dwienda R., dkk. (2014). *Buku ajar asuhan kebidanan neonatus, bayi, balita dan anak prasekolah untuk para bidan*. Deepublish.

UNICEF. (2023). *The state of the world's children 2023: For every child, vaccination*. UNICEF.

World Health Organization. (2017). *WHO recommendations on newborn health: Guidelines approved by the WHO Guidelines Review Committee*. World Health Organization.

World Health Organization. (2024, March 14). *Newborn mortality*. World Health Organization.

Ministry of Health (Eswatini). (2018). *Neonatal care clinical guidelines*. UNICEF Eswatini / World Health Organization platform.

BAB 3

EDUKASI ORANG TUA: PERAWATAN BAYI DI RUMAH, TANDA BAHAYA, DAN KAPAN KEMBALI KE FASYANKES

A. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menunjukkan profesionalisme, etika, dan tanggung jawab legal dalam pelayanan neonatal esensial.	CPMK-1; CPMK-3; CPMK-7
CPL-2	Menerapkan komunikasi terapeutik dan edukasi yang memberdayakan orang tua/keluarga dalam perawatan neonatus.	CPMK-1; CPMK-5; CPMK-6; CPMK-7
CPL-3	Menerapkan keselamatan pasien, pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI), serta K3 pada setiap tindakan neonatal.	CPMK-1; CPMK-3; CPMK-4; CPMK-7
CPL-4	Melakukan pengkajian dan clinical reasoning pada adaptasi fisiologis neonatus untuk mengenali kondisi normal, risiko, dan tanda bahaya.	CPMK-2; CPMK-4; CPMK-7
CPL-5	Melaksanakan keterampilan pelayanan neonatal esensial (termoregulasi, ASI, pencegahan infeksi, pemantauan) secara aman dan bermutu.	CPMK-3; CPMK-4; CPMK-5; CPMK-6; CPMK-7
CPL-6	Melaksanakan dokumentasi, kolaborasi, rujukan/balik rujuk, dan kontinuitas asuhan neonatus berbasis bukti.	CPMK-1; CPMK-7

B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan standar, etika, keselamatan, PPI, dan alur pelayanan neonatal esensial serta peran tenaga kesehatan dalam koordinasi layanan dan edukasi keluarga.
CPMK-2	Menganalisis adaptasi fisiologis neonatus (pernapasan, sirkulasi, termoregulasi) dan menginterpretasi parameter klinis dasar untuk pengambilan keputusan awal.
CPMK-3	Melaksanakan asuhan segera setelah lahir yang aman (pengeringan, kontak kulit, IMD) serta pencegahan hipotermia dan infeksi dasar sesuai SOP.
CPMK-4	Melakukan penilaian risiko termal dan melaksanakan pencegahan serta tata laksana awal hipotermia pada neonatus sesuai pedoman.
CPMK-5	Menilai proses menyusu dan menerapkan praktik pemberian ASI pada neonatus (perlekatan, frekuensi, tanda cukup ASI) disertai edukasi keluarga.
CPMK-6	Memberikan dukungan menyusui dan melakukan pemecahan masalah awal laktasi secara sistematis serta menentukan kebutuhan tindak lanjut/rujukan.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-7	Melaksanakan pemantauan neonatus terjadwal (pertumbuhan, eliminasi, hidrasi, respirasi, sirkulasi), deteksi dini tanda bahaya, skrining risiko, dokumentasi, serta rujukan/balik rujuk untuk kontinuitas asuhan.

E. Pemetaan

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 3. Edukasi Orang Tua: Perawatan Bayi di Rumah, Tanda Bahaya, dan Kapan Kembali ke Fasyankes	3.1 Merancang materi edukasi perawatan bayi di rumah (kehangatan, menyusui, kebersihan, keamanan) sesuai kebutuhan keluarga.	3.2 Melakukan konseling tanda bahaya dan keputusan kapan kembali ke fasyankes dengan komunikasi empatik dan jelas.	CPMK-1	CPMK-5; CPMK-7

F. Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-2	Ujian kasus tertulis; interpretasi parameter klinis (lembar kerja)	Ketepatan interpretasi parameter (RR/HR/suhu/CRT/warna) ≥75%; analisis hubungan temuan–mekanisme–tindakan awal ≥3 (skala 1–4)	15	Jawaban studi kasus; lembar interpretasi
CPMK-5	OSCE observasi menyusu & konseling (rubrik)	Skor penilaian perlekatan/posisi ≥3 (skala 1–4); ketepatan penilaian tanda cukup ASI ≥80%	10	Rubrik observasi menyusu; catatan konseling
CPMK-7	OSCE/mini-CEX kunjungan neonatus; Portofolio pemantauan (checklist)	Kelengkapan pengkajian & pencatatan parameter ≥85%; keputusan tindak lanjut/rujukan tepat ≥3 (skala 1–4); kelengkapan dokumentasi/format rujukan ≥80%	20	Portofolio kunjungan; lembar pemantauan; dokumentasi SOAP/rujukan

Rubrik CPMK-1

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1 Kepatuhan etika,	Banyak pelanggaran; langkah	Sebagian diterapkan; ada	Hampir seluruhnya	Konsisten patuh; proaktif

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
keselamatan pasien, dan PPI pada skenario pelayanan	keselamatan/PPI sering terlewat; perlu arahan penuh	kesalahan minor berisiko; perlu koreksi	patuh; kesalahan sangat minimal dan segera diperbaiki	mengidentifikasi risiko dan mencegah tanpa diingatkan
1.2 Kejelasan komunikasi edukatif & koordinasi terstruktur	Informasi tidak lengkap/tidak terstruktur; tidak memastikan pemahaman	Informasi cukup namun kurang terstruktur; konfirmasi pemahaman terbatas	Terstruktur dan jelas; bahasa sesuai; melakukan cek balik pemahaman	Sangat jelas, empatik, terarah; melibatkan keluarga; kesepakatan tindak lanjut dinyatakan tegas

Rubrik CPMK-2

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Interpretasi parameter respirasi/sirkulasi/suhu (normal vs abnormal)	Interpretasi banyak salah; tidak membedakan normal–abnormal	Benar sebagian; masih salah pada beberapa parameter kunci; perlu bantuan	Mayoritas benar; kesalahan minor tidak mengubah kesimpulan utama	Akurat dan cepat; mengintegrasikan beberapa parameter untuk kesimpulan tepat
2.2 Penalaran hubungan mekanisme adaptasi–temuan–tindakan awal	Penalaran tidak logis; tidak terhubung dengan mekanisme	Hubungan sebab-akibat kurang lengkap; tindakan awal kurang tepat	Logis dan relevan; tindakan awal sesuai berdasarkan temuan	Mendalam; mempertimbangkan alternatif/risiko; justifikasi tindakan awal sangat kuat

Rubrik CPMK-3

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Urutan dan ketepatan tindakan asuhan segera setelah lahir	Urutan salah/ada langkah kritis terlewat; teknik tidak aman	Urutan cukup namun ada langkah kritis kurang tepat; perlu arahan	Urutan tepat; teknik aman; hanya kesalahan minor	Sangat tepat dan efisien; mengantisipasi masalah sejak awal; teknik aman konsisten
3.2 Implementasi kontak kulit/IMD serta pencegahan	Kontak kulit/IMD tidak dilakukan/keliru;	Dilakukan sebagian; durasi/teknik kurang; kontrol	Sesuai SOP; menjaga kehangatan dan aseptik;	Optimal; menjaga kehangatan proaktif; IMD terfasilitasi baik;

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
hipotermia & infeksi dasar	pencegahan tidak adekuat	suhu/aseptik belum konsisten	monitoring dasar dilakukan	pencegahan infeksi sangat konsisten

Rubrik CPMK-4

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Identifikasi faktor risiko dan strategi pencegahan hipotermia	Risiko tidak teridentifikasi; strategi tidak sesuai	Mengidentifikasi sebagian; strategi masih umum/kurang kontekstual	Mengidentifikasi mayoritas risiko; strategi sesuai konteks	Komprehensif; prioritas tepat; strategi spesifik mempertimbangkan sumber daya
4.2 Tata laksana awal hipotermia, monitoring respons, dan keputusan rujukan	Pemanasan tidak tepat/berbahaya; monitoring tidak ada; keputusan keliru	Pemanasan cukup namun tidak sistematis; monitoring kurang lengkap; keputusan kurang tepat	Sistematis sesuai pedoman; monitoring memadai; keputusan rujukan tepat	Sangat tepat dan aman; monitoring lengkap dengan evaluasi respons; komunikasi rujukan jelas

Rubrik CPMK-5

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Penilaian perlekatan/posisi menyusu dan koreksi	Tidak mampu menilai; koreksi tidak diberikan	Menilai sebagian; koreksi kurang spesifik; masalah masih menetap	Menilai tepat; koreksi spesifik; perlekatan/posisi membaik	Sangat akurat; mengajarkan keterampilan pada ibu/keluarga; hasil optimal dan berkelanjutan
5.2 Penilaian frekuensi menyusu & tanda cukup ASI disertai edukasi	Penilaian keliru; edukasi tidak relevan	Penilaian umum; sebagian benar namun kurang individual	Sesuai kondisi bayi; indikator klinis dinilai benar; edukasi jelas	Sangat tepat berbasis data; edukasi terpersonalisasi dengan rencana tindak lanjut

Rubrik CPMK-6

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Identifikasi penyebab masalah menyusui berbasis data pengkajian	Tidak teridentifikasi; data tidak digunakan	Sebagian teridentifikasi; penyebab utama masih salah; perlu bantuan	Tepat berdasarkan data; membedakan beberapa penyebab yang mungkin	Komprehensif; memprioritaskan penyebab utama dan faktor pendukung secara tepat

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.2 Rencana intervensi, dukungan, tindak lanjut/rujukan	Intervensi tidak sesuai/berisiko; tidak ada tindak lanjut	Intervensi cukup namun kurang sistematis; tindak lanjut/rujukan belum jelas	Intervensi sesuai; tindak lanjut jelas; rujukan sesuai indikasi	Sangat efektif dan memberdayakan; tindak lanjut terjadwal; rujukan disertai komunikasi lengkap

Rubrik CPMK-7

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Kelengkapan pemantauan kunjungan neonatus dan pencatatan parameter	Banyak parameter tidak diukur/dicatat	Parameter dasar ada, namun kekurangan penting; catatan kurang rapi	Lengkap sesuai usia; catatan rapi dan dapat ditelusuri	Sangat lengkap dan konsisten; menginterpretasi tren/perubahan; catatan sangat akurat
7.2 Deteksi dini tanda bahaya/risiko, keputusan tindakan, dan dokumentasi	Tidak mengenali risiko; keputusan tidak tepat; dokumentasi tidak ada	Mengenali sebagian; keputusan kurang tepat; dokumentasi/rujukan belum lengkap	Mengenali dan bertindak tepat (edukasi/observasi/rujukan); dokumentasi lengkap	Deteksi sangat dini dan tepat; keputusan cepat-aman; komunikasi rujukan/balik rujuk sangat jelas dan terdokumentasi

Pendahuluan

Masa segera sesudah dilahirkan adalah permulaan kehidupan yang kurang membahagiakan untuk bayi. Hal ini dikarenakan lingkungan kehidupan sebelumnya (*intra uterine)* dengan lingkungan kehidupan saat ini (*extra uteine)* yang tidak sama. Janin hidup dan tumbuh di dalam rahim dengan sangat nyaman karena setiap hari dia bertumbuh dengan bantuan dari ibunya. Begitu bayi terlahir ke dunia, bermacam-macam kondisi mengalami perubahan, meliputi aktifitas penting yang harus dikerjakan. Fokus dan prioritas utama harus lebih mengutamakan pada kebutuhan bayi.

Seorang bidan, harus mampu memberikan edukasi kepada orangtua terkait dengan perawatan bayi Ketika di rumah, tanda bahaya yang dapat terjadi pada bayi, dan kapan harus Kembali ke fasilitas pelayanan Kesehatan (fasyankes).

BAB ini akan membahas tentang Edukasi Orang Tua: Perawatan Bayi di Rumah, Tanda Bahaya, dan Kapan Kembali ke Fasyankes. Tujuan penulisan BAB ini yaitu peserta

didik mampu melakukan edukasi kepada orang tua tentang Perawatan Bayi di Rumah, Tanda Bahaya, dan Kapan Kembali ke Fasyankes. Sasaran pembaca buku ini yaitu mahasiswi Program Studi Sarjana Kebidanan.

Gambaran pembahasan pada BAB ini yaitu Edukasi pada Orangtua yang meliputi: Perawatan Bayi di Rumah (Memandikan Bayi, Perawatan Tali Pusat, Pemenuhan Nutrisi pada Bayi, Menyendawakan Bayi, Pijat Bayi, Kesegaran Jasmani, Merawat Gigi Bayi), Tanda Bahaya, Kapan Kembali ke Fasyankes.

Tujuan Instruksional Umum

Mahasiswa mampu memberikan edukasi kepada orang tua tentang perawatan bayi di rumah, tanda bahaya pada bayi, kapan Kembali ke fasyankes

Tujuan Instruksional Khusus

1. Mahasiswa mampu melakukan KIE pada orangtua mengenai perawatan bayi di rumah meliputi memandikan bayi, perawatan tali pusat, pemenuhan nutrisi pada bayi, menyendawakan bayi, pijat bayi, kesegaran jasmani, merawat gigi bayi)
2. Mahasiswa mampu melakukan KIE pada orangtua mengenai tanda bahaya
3. Mahasiswa mampu melakukan Kie pada orangtua mengenai kapan kembali ke fasyankes

Capaian Pembelajaran:

Kognitif:

1. Mahasiswa memahami mengenai perawatan bayi, tanda bahaya, dan kapan kembali ke fasyankes
2. Mahasiswa mampu menghubungkan teori dengan praktik melalui analisis kasus dalam skenario klinis.

Psikomotor:

Mahasiswa mampu melaksanakan tindakan kebidanan yang spesifik dan tepat, meliputi Memandikan Bayi, Perawatan Tali Pusat, Pemenuhan Nutrisi pada Bayi, Menyendawakan Bayi, Pijat Bayi, Kesegaran Jasmani (Olah Raga dan Rekreasi), Merawat Gigi Bayi.

Afektif:

1. Mahasiswa menunjukkan profesionalisme, etika, dan tanggung jawab legal dalam pelayanan neonatal esensial.
2. Mahasiswa mampu menerapkan komunikasi terapeutik dan edukasi yang memberdayakan orang tua/keluarga dalam perawatan neonatus..

Uraian Materi

A. Komunikasi, Infromasi, dan Edukasi (KIE)

KIE kepanjangan dari Komunikasi, Informasi dan Edukasi.

1. Komunikasi

   Menurut (Effendy, 1984) dalam (Paramitha Amelia Kusumawardani, Paramitha Amelia & Azizah, 2021), komunikasi kesehatan yaitu proses menyampaikan pesan yang isinya hal-hal yang memiliki hubungan dengan kesehatan dan disampaikan oleh pemberi pesan tersebut kepada penerimanya menggunakan atau melalui bermacam-macam media yang dianggap tepat (Mansyur, 2020). Menurut Notoatmodjo, komunikasi kesehatan adalah upaya yang sistematis untuk memengaruhi secara positif perilaku kesehatan yang dilaksanakan masyarakat dengan menggunakan bermacam-macam prinsip dan metode untuk komunikasi serta baik menggunakan komunikasi yang dilaksanakan antar pribadi ataupun komunikasi massa.

2. Informasi

   Informasi yaitu pesan yang disampaikan atau keterangan gagasan ataupun kenyataan yang harus diketahui oleh masyarakat. Informasi yang disampaikan pada Masyarakat bisa berupa sebuah edukasi.

3. Edukasi

   Menurut (Effendy, 1984), edukasi pada bidang kesehatan yaitu salah satu kompetensi yang dituntut dari tenaga kesehatan disebabkan merupakan salah satu yang harus dilaksanakan dalam setiap memberikan pelayanan kesehatan baik pelayanan kepada individu, keluarga, kelompok ataupun kepada masyarakat. (Paramitha Amelia Kusumawardani, Paramitha Amelia & Azizah, 2021)**.**

B. Perawatan Bayi di Rumah

1. Memandikan Bayi

   Orang tua harus selalu menjaga bayi baru lahir supaya terjaga kebersihan, kehangatannya. Berbagai hal yang dapat dilakukan supaya kebersihan kulit bayi terjaga ialah dengan memandikan bayi, *diapers/* baju bayi diganti sesuai dengan kebutuhan, memastikan bayi dalam keadaan hangat, dan terjaga kebersihan baju serta berbagai sesuatu yang menempel dengan bayi. (Heryani, 2019).

   a. Pengertian Memandikan Bayi

      Memandikan bayi yaitu teknik untuk membuat tubuh bayi bersih melalui langkah-langkah menyiram, merendam tubuh bayi di air secara tepat dan berurutan. (Noorbaya, Siti, 2020)

b. Tujuan Memandikan Bayi
   1) Membuat bersih badan bayi
   2) Membuat bayi merasa nyaman
      (Noorbaya, Siti, 2020)

c. Waktu Memandikan Bayi

   Waktu yang tepat bagi bayi untuk dimandikan yaitu apabila suhu tubuh bayi sudah stabil atau menundanya hingga enam jam setelah bayi lahir. Hal ini dilakukan supaya bayi tidak mengalami hipotermia, di samping itu, meminimalisir risiko infeksi. Beberapa prinsip ketika memandikan bayi meliputi:

   1) Menjaga kehangatan bayi
   2) Menjaga keamanan dan keselamatan bayi
   3) Menggunakan air dengan suhu yang Suhu air tidak boleh terlalu panas atau terlalu dingin

   Bayi dimandikan sebaiknya menggunakan sabun pH netral dan tanpa parfum/pewarna (tidak menggunakan sabun dewasa).

d. Langkah-langkah Memandikan Bayi

   Menurut (Heryani, 2019), langkah-langkah memandikan bayi, antara lain:

   1) Persiapan Alat dan Bahan
      a) Pakaian bersih
      b) 2 waslap (1 untuk seka muka dan tubuh, 1 untuk membersihkan kelamin.
      c) Kapas (guna bersihkan kotoran di area mata, kapas cebok, dan *cotton buds*)
      d) Perlak
      e) Perlengkapan mandi (handuk, sisir, *baby oil,* sabun, dan shampoo bayi.
      f) Air hangat 37 ^{o}C
      g) Baskom mandi
   2) Persiapan Ruangan
      a) Menyiapkan ruangan dan meja periksa hangat, bersih, dan datar
      b) Menyiapkan bahan dan peralatan yang akan dipakai serta disusun dengan ergonomis
   3) Prosedur Pelaksanaan
      a) Melakukan *informed concent:* beritahu dan jelaskan kepada ibu/keluarga mengenai tujuan serta prosedur tindakan yang akan dilaksanakan
      b) Siapkan alat dan bahan secara ergonomis (pastikan peralatan sudah lengkap)
      c) Cuci tangan pakai sabun, bilas dengan air mengalir, mengeringkan pakai handuk

d) Jaga suhu bayi dan lingkungan dalam kondisi sehat: matikan AC dan kipas angin.
e) Letakkan bayi di perlak dan di tempat yang datar (upayakan tempatnya aman, hindari bayi agar tidak jatuh), mengatur bayi pada posisi terlentang dan melepas semua bajunya.
f) Bila pusar belum puput, melepas kasa yang membungkus tali pusar
g) Bila bayi Buang Air Kecil (BAK)/ Buang Air Besar (BAB), membersihkannya dengan kapas cebok
h) Seka wajah bayi dengan *washlap* pertama, mencelupkan *washlap* ke dalam air di bak mandi, memeras sedikit, kemudian menyeka lembut secara berurutan yaitu muka, tangan, tubuh, punggung dan kaki.
i) Mengganti *washlap* dengan *washlap* kedua, mencelupkan ke dalam air di bak mandi, lalu bersihkan daerah sekitar kelamin.
j) Mengganti dengan waslap ke-1 lagi, tuangi sabun. Menyabuni semua badan bayi dari tangan sampai kaki. Upayakan telapak tangan tidak kena sabun sebab bayi selalu memasukkan tangannya ke mulut. Alat kelamin bayi laki-laki boleh disabuni (pakai *washlap* kedua), tetapi kelamin bayi perempuan tidak boleh.
k) Mengangkat bayi, memasukkan ke dalam bak mandi dengan cara:
   (1) Selusupkan tangan kiri di bawah leher dan kepala bayi, ibu jari menutup telinga kanan dan jari tengah menutup telinga kiri. Jika menggunakan tangan kanan, lakukan sebaliknya.
   (2) Dengan tangan kanan, rapatkan kedua kaki bayi. Posisi telunjuk di antara kedua kaki
   (3) Masukkan bayi ke bak mandi
l) Dalam bak mandi, mandikan bayi dengan cara:
   (1) Posisi tubuh bayi di air hangat lebih rendah dari kepala. Melepaskan tangan kanan dari kakinya, lalu bilas tubuhnya bagian depan, tangan dan kaki hingga bersih. Badan bagian belakang dapat dibilas tanpa harus membalikkan tubuh bayi.
   (2) Jika akan membalikkan badan bayi, menelungkupkan bayi di atas tangan kiri, dengan ibu jari menutup telinga kanan dan kiri bayi
   (3) Bersihkan sabun yang menempel de tubuh bayi mulai dari punggung, pantat, kaki dengan tangan kanan penolong
   (4) Bila akan keramasi rambut bayi beri sedikit shampoo di rambut, mengusap lembut sampai shampoo rata, kemudian membilas dengan air sampai bersih. Tapi tindakan ini dilakukan sebelum membilas tubuhnya.

m) Lepaskan waslap dengan cara:
   (1) Angkat dan meletakkan bayi di atas handuk bersih, lembut dan kering
   (2) Keringkan badan bayi mulai dari kepala (rambut), wajah, leher, dada, tangan, perut, punggung, kaki dan pantat dan bagian kelamin
   (3) Membersihkan dan mengeringkan tali pusat
n) Bersihkan tali pusat dan bungkus dengan kasa steril tanpa diberikan cairan apapun. Bungkus seperti membedong, yaitu berbentuk segitiga. Jika tali pusat pendek, kasa cukup disimpul
o) Pakaikan popoknya, baju, bedong dan sisir rambut bayi

2. Perawatan Tali Pusat
   a. Pengertian Perawatan Tali Pusat
      Perawatan tali pusat yaitu tindakan merawat atau memelihara pada tali pusar bayi sesudah pusat dipotong atau sebelum puput.
   b. Tujuan Perawatan Tali Pusat
      1) Mencegah infeksi pada bayi (Timisela et al., 2023)
      2) Mempercepat proses pengeringan tali pusat. (Anggeriani et al., 2021)
   c. Prosedur Kerja Perawatan Tali Pusat
      1) Sikap
         a) Salam terapeutik
         b) Jelaskan pada ibu dan keluarga mengenai prosedur dan tindakan
         c) Jelaskan tujuan dan hasil yang diharapkan dari tindakan
         d) Minta persetujuan klien dan keluarga untuk melakukan tindakan perawatan tali pusat
         e) Menjaga privasi klien
      2) Persiapan Alat
         a) 2 bagian air hangat DTT, 1 untuk membasahi dan menyabuni dan yang 1 nya untuk membilas
         b) *Washlap* kering dan basah
         c) Sabun bayi
         d) Kasa steril
         e) 1 set baju bayi
      3) Pelaksanaan
         a) Memastikan cahaya memadai
         b) Memastikan kondisi bayi hangat, membuka bagian yang akan diperiksa (bila bayi telanjang pemeriksaan harus di bawah lampu pemancar) dan segera selimuti kembali dengan cepat
         c) Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun

d) Mencuci tali pusar dengan air bersih dan sabun, membilas dan mengeringkan sebaik-baiknya
e) Mempertahankan sisa tali pusardalam kondisi terbuka supaya kena udara serta menutupi dengan kain bersih secara longgar
f) Lipat popok di bawah sisa tali pusat
g) Jika tali pusat terkena kotoran atau tinja, cuci dengan sabun dan air bersih, dan keringkan betul betul
h) Cuci tangan Kembali setelah membersihkan tali pusat

4) Teknik
a) Percaya diri
b) Melakukan Tindakan secara sistematis
c) Menggunakan Bahasa yang mudah dimengerti
d) Tanggap terhadap respon pasien
e) Dokumentasikan hasil tindakan (Noorbaya, Siti, 2020)

3. Pemenuhan Nutrisi pada Bayi

a. Pemberian ASI Eksklusif

Menurut WHO dalam (Maritalia, 2017), ASI eksklusif yaitu pemberian ASI saja pada bayi hingga umur enam bulan tanpa tambahan cairan maupun makanan lain. ASI bisa diberikan hingga bayi berumur dua tahun.

b. Kebutuhan Minum

Kebutuhan minum bayi adalah:

1) Hari pertama = 50-60 cc/kg BB/hari
2) Hari kedua = 90 cc/kg BB/hari
3) Hari ketiga = 120 cc/kg BB/hari
4) Hari keempat = 150 cc/kg BB/hari
5) Tiap harinya sampai mencapai 180-200 cc/kg BB/hari.
(Armini, Sriasih, 2017)

c. Prinsip Umum Menyusui

Beberapa prinsip umum dalam menyusui dini dan eksklusif antara lain:

1) Bayi harus disusui secepatnya segera sesudah lahir (khususnya pada satu jam pertama) dan dilanjutkan sampai enam bulan pertama kehidupan
2) Kolostrum harus diberikan, tidak boleh dibuang
3) Bayi harus diberi ASI eksklusif selama enam bulan pertama. Hal ini berarti tidak boleh memberikan makanan apapun pada bayi selain ASI selama periode tersebut.
4) Bayi harus disusui kapanpun dia mau, siang atau malam (*ondemand)* yang akan merangsang mammae memproduksi ASI secara adekuat. (Armini, Sriasih, 2017)

d. Cara Menyusui yang Benar
   1) Memposisikan dan melekatkan bayi pada posisi yang benar agar efektif dalam menyusui
   2) Bayi disusui sedikitnya delapan kali perhari (24 jam)
   3) Bayi disusui secara bergantian pada kedua mammae, pindah dari mammae kanan ke kiri setelah mammae kosong yang telah disusukan kosong
   4) Keuntungan mengosongkan mammae yaitu:
      a) Mencegah mammae bengkak
      b) Meningkatkan produksi ASI
      c) Bayi mendapatkan komposisi ASI yang lengkap (ASI awal dan akhir). (Heryani, 2019)

e. Teknik Menyusui
   1) Gendong bayi senyaman mungkin agar pipi bayi menyentuh mammae.
   2) Tekanan melawan bibir bawah memulai *refleks rooting*
   3) Bayi akan berputar ke arah putting
   4) Bayi bisa mencium bau colostrum dan ASI, yang juga membuat bayi memalingkan muka ke arah puting
   5) Letakkan bayi pada mammae dengan menuntun puting dan jaringan areola ke mulut bayi di atas lidah
   6) Tekan mammae dengan ibu jari di atas areola untuk memungkinkan bayi menghisap dengan efektif.
      (Heryani, 2019).

f. Posisi Menyusui

   Beberapa posisi menyusui antara lain: (Heryani, 2019)

   1) Posisi Madonna/ Menggendong (*Cradle Hold)*

      Pada posisi ini bayi berbaring miring, menghadap ibu. Kepala, leher, dan punggung atas bayi diletakkan pada lengan bawah lateral mammae. Ibu memakai tangan sebelahnya untuk menggendong mammae bila dibutuhkan.

      Cara:

      a) Bayi digendong dengan kepala bersandar pada lekukan siku tangan ibu.
      b) Pantat bayi dipegang dengan telapak tangan berlawanan.
      c) Mengarahkan tubuh bayi sampai muka, perut dan lututnya menempel di dada dan perut ibu.
      d) Mengarahkan tangan bayi yang ada di atas merangkul tubuh/mammae ibu.(Choice, n.d.)



Gambar 3. 1 *Posisi Madonna/ Menggendong (Cradle Hold)*
Sumber: (Choice, n.d.)

2) Posisi Menggendong Menyilang (*Crossover Hold*)

Bayi diposisikan miring, menghadap ibu, kepala, leher, dan punggung atas bayi diletakkan pada telapak kontra lateral dan sepanjang lengan bawahnya. Ibu memakai tangan sebelahnya guna memegang mammae bila dibutuhkan.

Tekhnik ini berguna bagi bayi yang sulit menempelkan mulutnya ke putting mammae.

Cara:

a) Kepala bayi dipegang dengan tangan yang berlawanan dengan posisi mammae. Misalnya, bila yang disusukan mammae sebelah kiri, maka ibu harus memakai tangan kanan, begitu juga sebaliknya.
b) Arahkan badan bayi hingga kepala, dada dan perutnya menghadap ke dada dan perut ibu.
c) Arahkan mulutnya ke puting susu dengan ibu jari.
d) Meletakkan tangan yang tidak dipakai di belakang kepala atau bawah telinga bayi



Gambar 3. 2 *Posisi Menggendong Menyilang (Crossover Hold)*
Sumber: (Choice, n.d.)

3) Posisi *Footbal (*Mengapit)

Bayi diposisikan secara berbaring miring atau punggung melingkar antara tangan dan samping dada ibu. Lengan bawah dan tangan ibu menyangga bayi, dan dia memakai tangan sebelahnya guna memegang mammae bila dibutuhkan.

Posisi ini berguna bagi ibu yang telah mengalami persalinan secara *Section Caesarea (SC)* agar bayi tidak menempel pada perut ibu, bayi yang berat badannya rendah, bayi kembar, atau mammae yang sangat besar.

Cara:

a) Memposisikan bayi di antara siku tangan ibu
b) Menggunakan tangan kanan guna memegang kepala bayi bila ibu memakai mammae sebelah kanan untuk menyusui, begitupun sebaliknya.
c) Mengarahkan mulut bayi ke putting payudara di mulai dari dagu, supaya bayi tidak mudah menolak dengan posisi ini.



Gambar 3. 3 *Football Position*
Sumber: (Choice, n.d.)

4) Posisi Berbaring Miring (*Side-lying Position*)

Memposisikan ibu dan bayi berbaring miring saling berhadapan. Posisi ini adalah posisi paling nyaman buat ibu yang menjalani penyembuhan dari proses persalinan dengan operasi SC.

Ibu juga dapat menyusui sambil berbaring. Hal tersebut merupakan posisi yang tepat bila bayi terbangun pada malam hari ingin menyusu.

a) Berbaring di salah satu sisi menghadap bayi.
b) Mengarahkan bayi menghadap badan ibu secara berlawanan.
c) Dorong sedikit punggung bayi supaya bibirnya mendekati putting mammae.
d) Menyusui dengan posisi ini cukup pegal, posisi bayi juga dalam keadaan miring. Memastikan bayi tidak tertidur saat menyusui.



Gambar 3. 4 *Posisi Berbaring Miring Side-lying Position)*
Sumber: (Choice, n.d.)

5) Posisi Bersandar (*Laid-back Position*)

Posisi ini lazim digunakan bagi ibu yang baru menyusui bayi baru lahir. Posisi ini berguna bagi ibu yang ingin santai sebab kaki ibu dapat diluruskan, serta tekniknta lebih mudah diterapkan.

Posisi ini tepat bagi ibu yang mempunyai mammae kecil, atau menyusui bayi yang memiliki perut yang sensitif.

Caranya:

a) Punggung ibu disandarkan dengan bantal.
b) Memposisikan perut bayi di bawah dada, dan kepala bayi sejajar dengan mammae.
c) Memastikan hidung bayi tidak tertekan dan lehernya tidak menekuk.
d) Memulai menyusui secara rilex.



Gambar 6.5
Posisi Bersandar (*Laid-back Position*)

6) Posisi Bayi Duduk (*Sitting Baby)*

Posisi ini berguna bagi bayi yang telah dapat duduk sendiri. Keuntungan posisi ini yaitu tidak pegal dan mempunyai risiko paling kecil pada kasus bayi tersedak.

Cara:

a) Ibu duduk dalam posisi tegak dengan bersandar pada bantal agar nyaman.
b) Memposisikan bayi duduk menghadap ke badan ibu.
c) Mengalungkan tangan ibu ke pinggang atau punggung bayi sebagai tempat bayi bersandar.
d) Memastikan leher dan punggung bayi sejajar, dan hidung bayi tidak tertekan.



Gambar 3. 5 Posisi Bayi Duduk (Sitting Baby)

g. Tanda-tanda Bayi Cukup ASI
   1) Bayi nampak tenang
   2) Tubuh bayi menempel pada perut ibu
   3) Mulut bayi terbuka lebar
   4) Dagu bayi menempel pada mammae ibu
   5) Sebagian areola masuk ke dalam mulut bayi, areola bawah lebih banyak yang masuk
   6) Bayi tampak mengisap kuat dengan irama perlahan
   7) Putting susu tidak terasa sakit
   8) Telinga dan lengan bayi terletak pada satu garis lurus
   9) Kepala bayi sedikit tengadah
h. Cara Mengeluarkan/ Memerah ASI
   1) Siapkan: gelas/ cangkir tertutup
   2) Mencuci tangan sebelum memegang mammae
   3) Mencari posisi yang nyaman, duduk/berdiri dengan santai
   4) Memegang cangkir yang bersih guna menampung ASI
   5) Mencondongkan tubuh ke depan dan sangga mammae dengan tangan
   6) Meletakkan ibu jari pada batas atas areola mammae dan meletakkan jari telunjuk pada batas areola bagian bawah
   7) Menekan kedua jari ini ke dalam ke arah dinding dada tanpa menggeser letak kedua jari tadi
   8) Memijat area di antara kedua jari tadi ke arah depan sehingga akan memerah dan mengeluarkan ASI. Jangan menekan, memijat atau menarik puting susu karena ini tidak akan mengeluarkan ASI dan akan menyebabkan rasa sakit.
   9) Ulangi gerakan tangan, pijat dan lepas beberapa kali.

a) Sesudah ASI berkurang pancarannya, memindahkan posisi ibu jari dan telunjuk tadi dengan cara berputar pada sisi-sisi lain dari batas areola dengan kedua jari selalu berhadapan
b) Melakukan hal yang sama pada setiap posisi sampai mammae kosong

i. Cara Menyimpan ASI
1) ASI bisa disimpan dalam botol gelas/plastik, termasuk plastik klip ± 80-100 cc (untuk satu kali konsumsi)
2) ASI yang disimpan dalam *freezer* dan telah dikeluarkan sebaiknya tidak dipakai kembali sesudah dua hari
3) ASI beku harus dicairkan dulu dalam lemari es 4 derajat celcius
4) ASI beku jangan dimasak/dipanaskan, hanya dihangatkan dengan merendam dalam air hangat
5) Petunjuk umum menyimpan ASI di rumah:
a) Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir
b) Sesudah diperah, ASI bisa disimpan dalam kulkas/ *freezer*
c) Tuliskan jam, hari dan tanggal saat diperah.

Tabel 3. 1 Penyimpanan ASI

No	ASI	Suhu Ruang	Lemari Es	*Freezer*
1	Setelah diperah	6-8 jam (±26 ^{o}C)	3-5 hari (±4 ^{o}C)	dua minggu (*freezer* jadi satu dengan refrigerator), tiga bulan dengan pintu sendiri, 6-12 bulan (-18 ^{o}C)
2	Dari *freezer,* disimpan di kulkas (tidak dihangatkan)	empat jam atau kurang (minum berikutnya)	24 jam	Tidak boleh dibekukan ulang
4	Dikeluarkan dari kulkas (dihangatkan pada suhu ruang)	Langsung diberikan	empat jam / minum berikutnya	Tidak boleh dibekukan ulang
5	Sisa minum bayi	Minum berikutnya	Buang	buang

Sumber: (Maritalia, 2017)

j. Pijat Oksitosin

1) Pengertian

Pijat oksitosin yaitu pemijatan tulang belakang pada costa ke 5-6 sampai ke scapula yang akan mempercepat kerja syaraf parasimpatis dalam merangsang hipofisis posterior untuk mengeluarkan oksitosin. (Sutanto, 2018)

2) Manfaat

a) Merangsang oxitosin
b) Meningkatkan kenyamanan
c) Meningkatkan gerak ASI ke mammae
d) Menambah pengisian ASI ke mammae
e) Memperlancar pengeluaran ASI. (Wahyuningsih & Kusumadewi, 2025), (Widhawati, Riswahyuni & Ramawati, 2020), (Lahu, Yolanda Ester & Yeni, 2024), (Kartini et al., 2024)
f) Mempercepat proses involusi

3) Langkah-langkah Pijat Oksitosin

Langkah-langkah melaksanakan pijat oksitosin dengan metode oksitosin sebagai berikut (Purwati, 2018) (Purwati, 2018):

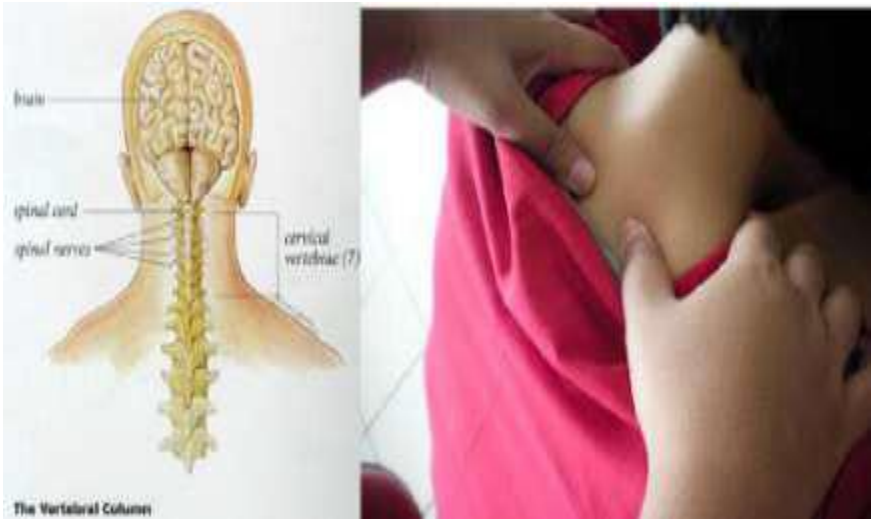
a) Melepas pakaian ibu bagian atas.
b) Ibu miring ke kanan ataupun ke kiri, kemudian memeluk bantal, tapi terdapat 2 posisi alternative, ialah: boleh telungkup di meja seperti gambar dibawah ini:



Gambar 3. 6 Posisi telungkup di meja Sumber : Naziroh (20ssc17)

c) Memasang handuk.
d) Melumuri kedua telapak tangan dengan minyak atau baby oil.
e) Memijat sepanjang kedua sisi tulang belakang ibu dengan memakai kedua kepala tangan, dengan ibu jari menunjuk ke depan. Area tulang

belakang leher, cari daerah dengan tulang yang paling menonjol, namanya *processus spinosus/ cervical vertebrae* 7.



Gambar 3. 7 Cara Memijat dengan Ibu Jari Menunjuk ke Depan
Sumber : (Naziroh, 2017)

f) Tekan kuat-kuat kedua sisi tulang belakang membentuk gerakan-gerakan melingkar kecil-kecil dengan kedua ibu jarinya.



Gambar 3. 8 Memijat dengan Membentuk Gerakan Melingkar Kecil-Kecil dengan kedua Ibu Jari
Sumber : (Naziroh, 2017)

g) Pada waktu bersamaan, pijat kedua sisi tulang belakang ke arah bawah, dari leher ke arah tulang belikat, selama 2-3 menit.
h) Ulangi pemijatan sampai tiga kali.
i) Bersihkan punggung ibu dengan *washlap* air hangat dan dingin secara bergantian

4. Menyendawakan Bayi
   a. Pengertian
      Menyendawakan bayi adalah proses untuk membantu mengeluarkan udara yang terperangkap di dalam perut bayi sesudah menetek.
   b. Fungsi Menyendawakan
      Menyendawakan bayi berfungsi untuk menolong mengeluarkan udara yang ada di dalam perut bayi atau agar tidak kembung agar bayi nyaman dan tidak rewel. (Delima et al., 2018),
   c. Teknik Menyendawakan
      Beberapa teknik menyendawakan bayi antara lain:
      1) Taruh di Pundak
         Cara:
         a) Bayi digendong di bahu dengan muka menghadap ke belakang.
         b) Memegang bagian bokongnya dengan 1 tangan, sedangkan tangan yang lainnya memegang leher dan menepuk-nepuk punggungnya. Tidak lebih dari 3 menit, mulut bayi akan mengeluarkan bunyi khas sendawa.



Gambar 3. 9 Teknik Menyendawakan Bayi dengan Menaruh di Pundak
Sumber: https://healthfy.kr

      2) Posisi Telungkup
         a) Menelungkupkan bayi di pangkuan ibu
         b) Menepuk-nepuk bagian punggungnya
         c) Saat ibu melaksanakannya, upayakan agar posisi dada bayi lebih tinggi dari perutnya
            Teknik ini juga bisa dilaksanakan di boks bayi/ranjang bayi. Selain membuat udara di perut keluar, posisi ini dapat membuat bayi lebih rilex.



Gambar 3. 10 Teknik Menyendawakan Bayi dengan Posisi Telungkup
Sumber: https://healthfy.kr

5. Pijat Bayi
   a. Pengertian

      Pijat bayi yaitu sebuah tindakan yang dilaksanakan secara alamiah/sentuhan yang dilaksanakan pada bayi supaya bayi merasa nyaman. Sentuhan alamiah yang diberikan kepada bayi dengan tindakan mengurut atau memijat (Merida, Yunri & Hanifa, 2021).

   b. Manfaat

      Jika pijat bayi dilaksanakan dengan teratur dan sesuai dengan tata cara dan teknik pemijatan bayi, pemijatan ini dapat menjadi terapi untuk memperoleh manfaat yang banyak bagi bayi.

      Adapun manfaat pijat bayi antara lain:

      1) Meningkatkan berat badan dan pertumbuhan bayi. (Merida, Yunri & Hanifa, 2021), (Maryani, 2024), (Sartika et al., 2023)
      2) Meningkatkan pola tidur bayi. (Hastuti, Fuji, Hidayah, Fika Nurul, Magasida, 2024), (Utami, 2020)
      3) Meningkatkan konsentrasi
      4) Meningkatkan motorik bayi. (Jannah et al., 2025), (Yanti et al., 2022)
      5) Meningkatkan daya tahan tubuh
      6) Membina ikatan kasih sayang antara orang tua dengan anak. (Merida, Yunri & Hanifa, 2021).

   c. Langkah-langkah Pijat Bayi: (Rizki, 2023), (Heryani, 2019)

      1) Persiapan dan Perkenalan
         a) Menyambut ibu dengan ramah dan sopan
         b) Memperkenalkan diri dengan ibu
         c) Merespon terhadap reaksi ibu

d) Percaya diri
e) Menjelaskan prosedur, tujuan, dan manfaat tindakan

2) Persiapan Ruangan
a) Ruangan tertutup
b) Ruangan dalam keadaan yang terang/pencahayaan cukup
c) Perhatikan suhu ruangan, tetap jaga kehangatan suhu ruang

3) Persiapan Alat
a) Handuk
b) Washlap
c) Popok
d) *Baby lotion* atau *baby oil*
e) Pakaian bayi
f) Phantom bayi

4) Persiapan Klien
a) Meminta persetujuan kepada ibu bahwa bayi akan dipijat

5) Prosedur Tindakan
a) Mencuci tangan dengan sabun kemudian dibilas dengan air mengalir. Pastikan perhiasan seperti cincin dan gelang telah dilepas
b) Melepaskan baju bayi, selalu menjaga kehangatan ruangan.

6) Teknik Pemijatan:
a) Memijat Daerah Kaki
(1) Perahan cara India:
(a) Pegang kaki bayi pada pangkal paha, seperti memegang *soft ball*
(b) Menggerakkan tangan ke arah bawah secara bergantian, seperti memerah susu
(2) Peras dan Putar
(a) Pegang kaki bayi pada pangkal paha dengan kedua tangan secara bersamaan
(b) Peras dan putar kaki bayi dengan lembut di mulai dari pangkal paha ke arah mata kaki
(3) Telapak Kaki
(a) Mengurut telapak kaki dengan kedua ibu jari secara bergantian, dimulai dari tumit kaki menuju jari-jari di seluruh telapak kaki
(4) Tarikan lembut jari
(a) Memijat jari-jari satu per satu dengan gerakan memutar menjauhi telapak kaki, diakhiri dengan tarikan kasih sayang lembut pada setiap ujung jari

(5) Gerakan peregangan (*stretch)*
   (a) Memijat telapak kaki dimulai dari batas jari-jari ke arah tumit dengan menggunakan sisi jari telunjuk, lalu diulangi Kembali dari perbatasan jari ke arah tumit
   (b) Meregangkan secara lembut punggung kaki pada daerah pangkal kaki ke arah tumit dengan jari tangan lain
(6) Titik Tekanan
   (a) Menekan-nekan kedua ibu jari secara bersamaan di semua permukaan telapak kaki dari arah tumit ke jari-jari
(7) Punggung Kaki
   (a) Memijat punggung kaki dari pergelangan kaki ke arah jari-jari dengan menggunakan kedua ibu jari secara bergantian.
(8) Peras dan Putar Pergelangan Kaki (*Anklecircles)*
   (a) Membuat gerakan seperti memeras dengan menggunakan ibu jari dan jari-jari lainnya di pergelangan kaki bayi
(9) Perahan secara Swedia
   (a) Memegang pergelangan kaki bayi
   (b) Menggerakkan tangan secara bergantian dari pergelangan kaki ke pangkal paha
(10) Gerakan Menggulung
   (a) Memegang pangkal paha dengan kedua tangan
   (b) Membuat gerakan menggulung dari pangkal paha menuju pergelangan kaki
(11) Gerakan akhir
   (a) Sesudah gerakan 1 sampai 10 dilaksanakan pada kaki kanan dan kiri, rapatkan kedua kaki bayi
   (b) Letakkan kedua tangan anda secara bersamaan pada pantat dan pangkal paha
   (c) Mengusap kedua kaki dengan tekanan lembut dari paha ke arah pergelangan kaki. Hal tersebut adalah gerakan terakhir bagian kaki.

b) Memijat Bagian Perut

Perhatian: Jangan memijat di tulang rusuk/ujung tulang rusuk!

(1) Mengayuh Sepeda
   (a) Melakukan gerakan memijat di perut bayi seperti mengayuh pedal sepeda, dari atas ke bawah perut, secara berganti-ganti dengan tangan kanan dan kiri
(2) Mengayuh Sepeda dengan Kaki Diangkat
   (a) Mengangkat kedua kaki bayi dengan salah satu tangan

(b) Memijat perut bayi dari perut bagian atas sampai ke jari-jari kaki dengan tangan yang lain.

(3) Ibu jari ke Samping

(a) Meletakkan kedua ibu jari di samping kanan kiri pusar bayi

(b) Menggerakan kedua ibu jari ke arah tepi perut kanan dan kiri

(4) Bulan – Matahari

(a) Membuat lingkaran searah jarum jam dengan jari tangan kiri memulai dari perut sebelah kanan bawah (daerah usus buntu) ke atas, selanjutnya kembali ke daerah kanan bawah (seolah membentuk gambar matahari) beberapa kali

(b) Menggunakan tangan kanan untuk membuat gerakan setengah lingkaran mulai dari bagian kanan bawah perut bayi hingga bagian kiri perut bayi (seolah membentuk gambar bulan)

(c) Melakukan kedua gerakan ini bersama-sama. Tangan kiri selalu membuat bulatan penuh (matahari), sedangkan tangan kanan akan membuat gerakan setengah lingkaran (bulan)

(5) Gerakan I Love You

(a) "I" Memijat perut bayi mulai dari bagian kiri atas ke bawah dengan menggunakan jari-jari tangan kanan membentuk huruf "I"

(b) "LOVE" Memijat perut bayi membentuk huruf "L" terbalik, mulai dari kanan atas ke kiri atas, lalu dari kiri atas ke kiri bawah

(c) "YOU" Memijat perut bayi membentuk huruf "U" terbalik, dimulai dari kanan bawah (daerah usus buntu) ke atas, kemudian ke kiri, ke bawah, dan berakhir di perut kiri bawah.

(6) Gelembung atau jari-jari berjalan (*walking fingers)*

(a) Meletakkan ujung jari-jari satu tangan pada perut bagian kanan

(b) Menggerakkan jari-jari pada perut dari bagian kanan ke bagian kiri guna mengeluarkan gelembung-gelembung udara

c) Memijat Daerah Dada

(1) Jantung Besar

(a) Membuat gerakan yang menggambarkan jantung dengan meletakkan ujung-ujung jari kedua tangan anda di tengah dada bayi/ ulu hati

(b) Membuat gerakan ke atas hingga di bawah leher, kemudian ke samping di atas tulang selangka, selanjutnya ke bawah membentuk bentuk jantung, dan kembali ke ulu hati

(2) Kupu-kupu

(a) Membuat gerakan diagonal seperti gambar kupu-kupu, dimulai dengan tangan kanan membuat gerakan memijat menyilang dari tengah dada/ ulu hati ke arah bahu kanan, dan kembali ke ulu hati

(b) Gerakan tangan kiri ke bahu kiri dan kembali ke ulu hati

d) Memijat Daerah Tangan

(1) Memijat Ketiak (*Ampist*)

(a) Membuat gerakan memijat pada daerah ketiak dari atas ke bawah. Harus diingat, jikalau ada bengkak kelenjar di area ketiak seharusnya gerakan ini tidak dilaksanakan.

(2) Perahan Cara India

(a) Memegang lengan bayi bagian pundak dengan tangan kanan seperti memegang pemukul *soft ball,* tangan kiri memegang pergelangan tangan bayi

(b) Menggerakkan tangan kanan mulai dari bagian bahu ke arah pergelangan tangan, lalu gerakan tangan kiri dari bahu ke arah pergelangan tangan, demikian seterusnya.

(c) Menggerakkan tangan kanan dan kiri ke bawah secara bergantian dan berulang-ulang seolah memerah susu sapi

(3) Peras dan Putar (*Squeeze and twist)*

(a) Peras dan putar lengan bayi dengan lembut mulai dari bahu ke pergelangan tangan

(4) Membuka Tangan

(a) Pijat telapak tangan dengan kedua ibu jari, dari pergelangan tangan ke arah jari-jari

(b) Memutar jari-jari

(c) Memijat lembut jari bayi 1 per 1 menuju ke arah ujung jari dengan gerakan memutar

(d) Mengakhiri gerakan ini dengan tarikan lembut pada tiap ujung jari

(5) Punggung Tangan

(a) Meletakkan tangan bayi di antara kedua tangan pemijat

(b) Mengusap punggung tangannya dari pergelangan tangan ke arah jari-jari dengan lembut

(6) Peras dan Putar Pergelangan Tangan (*Wirstcicle)*

(a) Memeras sekeliling pergelangan tangan dengan ibu jari dan jari telunjuk

(7) Perahan Cara Swedia

Pijatan ini akan bermanfaat guna mengalirkan darah ke jantung dan paru-paru

(a) Gerakkan tangan kanan dan kiri anda secara bergantian, dimulai dari pergelangan tangan kanan bayi ke arah bahu

(b) Melanjutkan dengan memijat dari pergelangan kiri bayi ke arah bahu

(8) Gerakan Menggulung

(a) Memegang lengan bayi bagian atas/bahu dengan kedua telapak tangan

(b) Bentuklah gerakan menggulung dari pangkal lengan menuju ke arah pergelangan tangan/ jari-jari

e) Memijat Daerah Muka

(1) Dahi: Menyetrika Dahi *(Open Book)*

(a) Meletakkan jari-jari kedua tangan pemijat pada pertengahan dahi

(b) Tekankan jari-jari pemijat dengan lembut mulai dari tengah dahi keluar ke samping kanan dan kiri seolah menyetrika dahi/ membuka lembaran buku

(c) Gerakan ke bawah ke arah daerah pelipis, lalu gerakan ke dalam melalui daerah pipi di area mata

(2) Alis: Menyetrika Alis

(a) Meletakkan kedua ibu jari anda di antara kedua alis mata

(b) Gunakan kedua ibu jari untuk memijat secara lembut pada alis mata dan di atas kelopak mata, mulai dari tangah ke samping seolah menyetrika alis

(3) Hidung: Senyum I

(a) Meletakkan kedua ibu jari pemijat di pertengahan alis

(b) Menekankan ibu jari pemijat dari pertengahan kedua alis turun melalui tepi hidung ke arah pipi dengan membuat gerakan ke samping dan ke atas seperti membuat bayi tersenyum

(4) Mulut Bagian Atas: Senyum II

(a) Meletakkan kedua ibu jari pemijat di atas mulut di bawah sekat hidung

(b) Menggerakkan kedua ibu jari pemijat dari tengah ke samping dan ke atas ke daerah pipi seperti membuat bayi tersenyum

(5) Mulut Bagian Bawah: Senyum III

(a) kedua ibu jari anda di tengah dagu

(b) Menekankan dua ibu jari pada dagu dengan gerakan dari tengah ke samping, lalu ke atas ke arah pipi seperti membuat bayi tersenyum.

(6) Lingkaran Kecil di Rahang (*Small Circlesaround Jaw)*

Membuat lingkaran-lingkaran kecil daerah rahang bayi dengan jari kedua tangan.

(7) Belakang Telinga

(a) Memberikan tekanan lembut pada daerah belakang telinga kanan dan kiri dengan menggunakan ujung-ujung jari.

(b) Menggerakkan ke arah pertengahan dagu di bawah dagu

f) Memijat Daerah Punggung

(1) Gerakan Maju Mundur (Kursi Goyang)

(a) Menengkurapkan bayi melintang di depan pemijat dengan kepala di sebelah kiri dan kaki di sebelah kanan pemijat

(b) Memiijatlah sepanjang punggung bayi dengan gerakan maju mundur memakai kedua telapak tangan, dari bawah leher sampai ke pantat bayi, lalu kembali ke leher.

(2) Gerakan Menyetrika

(a) Memegang bokong bayi dengan tangan kanan

(b) Memijatlah mulai dari leher ke bawah sampai bertemu dengan tangan kanan yang menahan pantat bayi seolah menyetrika punggung dengan tangan kiri.

(3) Gerakan Menyetrika dan Mengangkat

(a) Ulangi gerakan menyetrika punggung, hanya kali ini tangan kanan memegang kaki bayi dan gerakan dilanjutkan sampai tumit kaki bayi

(4) Gerakan Melingkar

(a) Membuat gerakan-gerakan melingkar kecil-kecil mulai dari batas tengkuk turun ke bawah di sebelah kanan dan kiri tulang punggung hingga ke bokong dengan jari-jari kedua tangan pemijat

(b) Memulai dengan lingkaran-lingkaran kecil di area leher, kemudian lingkaran yang besar di daerah bokong.

(5) Gerakan Mengaruk

(a) Menekankan dengan lembut kelima jari-jari tangan kanan pemijat pada punggung bayi

(b) Membuat gerakan menggaruk ke bawah memanjang sampai ke bokong bayi

g) Sentuhan Relaksasi

Relaksasi membuat goyangan-goyangan ringan, tepukan-tepukan halus dan melambung-lambungkan secara lembut. Sentuhan relaksasi bisa dilakukan pada tiap bagian tubuh bayi seperti di area tangan, dan perut. Sentuhan relaksasi digunakan untuk memulai gerakan pada setiap bagian tubuh bayi.

Peregangan Lembut:

(1) Tangan disilangkan
   (a) Memegang kedua pergelangan tangan bayi dan menyilangkan keduanya di dada
   (b) Meluruskan kembali kedua tangan bayi ke samping
   Mengulangi gerakan ini sebanyak 4-5 kali

(2) Membentuk Diagonal Tangan-Kaki
   (a) Pertemukan ujung kaki kanan dan ujung tangan kiri bayi di atas tubuh bayi sampai membentuk garis diagonal. Selanjutnya, tarik lagi kaki kanan dan tangan kiri bayi ke posisi sebelumnya
   (b) Pertemukan ujung kaki kiri dengan ujung tangan kanan di atas badan bayi. Lalu, tarik lagi tangan dan kaki bayi ke posisi sebelumnya.

(3) Menyilangkan Kaki
   (a) Memegang pergelangan kaki kanan dan kiri bayi, kemudian menyilangkan ke atas. Membuat silangan mata kaki kanan luar bertemu mata kaki pada posisi sebelumnya.
   (b) Pegang kedua pergelangan kaki bayi dan silangkan kedua kakinya ke atas sehingga mata kaki kanan dalam bertemu dengan mata kaki kiri luar. Sesudah itu, kembalikan pada posisi sebelumnya. Gerakan ini bisa diulangi empat sampai lima kali.

(4) Menekuk Kaki
   (a) Memegang pergelangan kaki kanan dan kiri bayi dalam posisi kaki lurus, lalu tekuk lutut kaki perlahan menuju ke arah perut. Gerakan menekuk lutut ini bisa diulangi empat sampai lima kali.

(5) Menekuk Kaki Bergantian
   Gerakannya sama seperti menekuk kaki, tetapi dengan mempergunakan kaki secara bergantian

(6) Selesai memijat bayi, lanjutkan dengan membersihkan badan bayi dari minyak. Lap bayi dengan washlap basah, kemudian pakaikan pakaian bersih, jika mau dimandiin dapat langsung ke proses memandikannya.

(7) Mengembalikan bayi kepada ibu
(8) Merapikan peralatan
(9) Mencuci tangan sesudah melaksanakan tindakan
Perhatikanlah mencuci tangan yang efektif dan sesuai prosedur

6. Kesegaran Jasmani (Olah Raga dan Rekreasi)

Aktivitas olah raga dan rekreasi dipakai guna melatih otot-otot badan serta membuang sisa metabolisme, selain itu juga membantu meningkatkan motorik anak, dan aspek perkembangan lainnya. Aktivitas olah raga dan rekreasi bagi anak merupakan aktivitas bermain yang menyenangkan.

7. Merawat Gigi Bayi
   a. Cara merawat mulut bayi pada ketika umur 0-6 bulan
      1) Membersihkan gusi bayi dengan kain lembab, minimal 2 x sehari
      2) Jika bayi tidur, lepaskan botol susu dari mulutnya.
      3) Mulut bayi dibersihkan dengan kain lembab setelah selesai menyusu.
      4) Tidak menambahkan rasa manis di botol susu dengan madu/sesuatu yang manis
   b. Cara merawat mulut dan gigi bayi umur 7-12 bulan:
      1) Menanyakan pada dokter anak/ dokter gigi apakah bayi cukup mendapat *fluor*
      2) Ingatlah untuk membersihkan mulut bayi dengan kain lembab (tidak basah sekali), setelah menyusui
      3) Tidak membiarkan bayi tidur sambil minum susu dari botol kecuali air putih
      4) Memberikan air putih jika bayi ingin minum di luar jadwal minum susu
      5) Ketika gigi mulai tumbuh, mulailah membersihkan dengan memakai kain lembab. Membersihkan tiap permukaan gigi dan batas antara gigi dengan gusi secara teliti, sebab makanan sering sekali tertinggal di permukaan tersebut
      6) Ketika gigi geraham bayi mulai tumbuh, mulai menggunakan sikat gigi yang kecil dengan permukaan lembut dan dari bahan nilon
      7) Tidak menggunakan pasta gigi dan ingat untuk selalu membasahi sikat gigi dengan air
      8) Memeriksakan gigi anak ke dokter gigi, sesudah enam bulan sejak gigi pertama tumbuh, atau ketika umur anak 1 tahun.

C. Tanda Bahaya Bayi

1. Penilaian Tanda Bahaya pada Bayi

   Penilaian tanda bahaya pada bayi yaitu (Heryani, 2019):

   a. BBL dinyatakan sakit jika memiliki salah satu/beberapa tanda-tanda berikut:
      1) Sesak napas
      2) Napas lebih dari 60 x/mnt
      3) Gerakan retraksi dinding dada
      4) Malas minum
      5) Panas atau suhu bayi rendah
      6) Kurang aktif
      7) BBLR (1500-2500 gram) dengan kesulitan minum
   b. Tanda-tanda bayi sakit berat, antara lain:
      1) Kesulit minum
      2) Sianosis sentral (lidah biru)
      3) Perut kembung
      4) Periode *apnea*
      5) Kejang/ periode kejang-kejang kecil
      6) Merintih
      7) Perdarahan
      8) Sangat kuning
      9) Berat badan lahir < 1500 gram

   Tanda-tanda yang menunjukkan potensi bahaya bagi bayi yang baru lahir termasuk berbagai manifestasi yang dapat diamati antara lain (Lisca, 2025):

   a. Bayi baru lahir mengalami kesulitan bernapas, ditandai dengan laju pernapasan > 60 x/ menit.
   b. Demam, khususnya ketika suhu tubuh bayi naik > 38 derajat Celcius. Sebaliknya, suhu tubuh rendah yang berbahaya < 36 derajat Celcius juga dapat menandakan potensi ancaman bagi kesehatan bayi baru lahir.
   c. Refleks hisap selama menyusui lemah, disertai dengan rewel dan muntah yang sering, itu bisa menjadi indikasi masalah mendasar yang memerlukan perhatian segera.
   d. Munculnya tali pusat, yang mungkin kemerahan, bengkak, dan mengeluarkan cairan berbau busuk, menunjukkan kemungkinan infeksi.
   e. Kejang pada bayi baru lahir adalah bendera merah serius yang membutuhkan intervensi medis segera.

f. Menangis terus menerus tanpa penyebab yang jelas tidak boleh diabaikan dengan enteng, karena itu bisa menjadi tanda kesusahan atau kondisi medis yang mendasarinya.

2. Kapan Kembali ke Fasyankes

Meninjau kembali bayi baru lahir melibatkan setidaknya tiga kunjungan ulang penting dalam tahap awal kehidupan:

a. Kunjungan pada umur 6-48 jam umumnya dikenal sebagai kunjungan neonatal 1, yang sangat penting untuk memantau kesehatan awal dan perkembangan bayi.
b. Kunjungan pada umur 3-7 hari (Kunjungan Neonatal 2), untuk menilai lebih lanjut kemajuan dan kesejahteraan bayi.
c. Kunjungan pada umur 8-28 hari (Kunjungan Neonatal 3), untuk memastikan pemantauan dan dukungan berkelanjutan untuk pertumbuhan bayi baru lahir.

Selama kunjungan ini, sangat penting untuk melakukan pemeriksaan fisik yang komprehensif, termasuk menimbang bayi, memeriksa suhu tubuh mereka, dan mengamati kebiasaan makan mereka mengidentifikasi masalah atau masalah potensial. Untuk:

a. Memeriksa tanda-tanda bahaya selama kunjungan ini untuk segera mengatasi komplikasi kesehatan. Tanda-tanda ini mungkin termasuk infeksi kulit superfisial, seperti adanya nanah di sekitar umbilicus, kemerahan di daerah pusar, atau munculnya lebih dari 10 pustula pada kulit. Selain itu, pembengkakan, kemerahan, dan pengerasan kulit merupakan indikator penting yang memerlukan perhatian dan intervensi segera.
b. Memeriksa tanda-tanda bahaya selama kunjungan ini untuk segera mengatasi komplikasi kesehatan.
c. Dalam kasus di mana tanda-tanda bahaya atau infeksi terdeteksi, sangat penting untuk merujuk bayi ke fasilitas kesehatan untuk evaluasi dan perawatan lebih lanjut. d. Selain itu, penting untuk menekankan pentingnya menyusui eksklusif, karena memberikan nutrisi optimal dan dukungan kekebalan tubuh untuk perkembangan sehat bayi (Kemenkes, 2018).

Menurut (Menkes RI, 2021), beberapa keadaan yang harus dinasehatkan kepada ibu kapan Kembali ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes), yaitu:

a. Menasehati Ibu Kapan Kembali Segera

Nasehati ibu supaya segera kembali, bila bayi menunjukkan salah satu tanda di bawah ini:

1) Gerakan bayi berkurang atau tidak normal
2) Napas cepat/ Sesak napas
3) Warna kulit berubah (kebiruan, kuning)

4) Malas/ tidak dapat menyusu atau minum
5) Badan teraba dingin/panas
6) Kulit bertambah kuning
7) Semakin tambah parah

b. Menasehati Ibu Kapan Kunjungan Ulang

Pelayanan kesehatan bagi BBL dilakukan minimal 3 (tiga) kali antara lain:

1) 1 kali pada 6 jam – 2 hari setelah melahirkan
2) 1 kali pada 3 – 7 hari setelah melahirkan
3) 1 kali pada 8 – 28 setelah melahirkan

Tabel 3. 2 Kunjungan Ulang

Bayi dengan:	**Kunjungan Ulang**
• Infeksi bakteri local • Diare dehidrasi ringan/ sedang • Icterus • Masalah pemberian ASI • Luka/ bercak putih di mulut (*trush)*	2 hari
• BB rendah menurut umur	14 hari

Sumber: (WHO, n.d.)

AKTIVITAS 1 – *KNOWS HOW*
***MINI-CASE* TERTULIS (DISKUSI KELOMPOK)**

Seorang bayi laki-laki, usia 3 hari dibawa ibunya ke TPMB pada tanggal 17 Maret 2026 pukul 16.00 WIB dengan keluhan khawatir tidak bisa mendapatkan ASI secara eksklusif karena ASI keluarnya sedikit. Hasil pemeriksaan: KU baik, laju jantung 140 x/menit, suhu 37°C, pernafasan 40 x/menit. BB 3200 gram, PB 49 cm, lingkar kepala 34 cm, lingkar dada 34 cm, lingkar lengan 12 cm. Pada pemeriksaan fisik (*head to toe*) tidak ditemukan kelainan serta tanda bahaya pada bayi. Bidan memberikan edukasi tentang pemenuhan kebutuhan nutrisi pada bayi.

Pertanyaan Diskusi:

1. Apa yang dimaksud dengan ASI eksklusif?
2. Berapa kebutuhan minum ASI neonates tiap harinya?
3. Apa saja prinsip umum menyusui?
4. Bagaimana cara menyusui yang benar?
5. Bagaimana teknik menyusui bayi yang benar?
6. Jelaskan berbagai posisi menyusui?
7. Apa saja tanda bayi cukup ASI?
8. Bagaimana cara mengeluarkan/ memerah ASI?
9. Bagaimana cara menyimpan ASI?
10. Bagaimana cara pijat oksitosin?

TEMPLATE SOAL OSCE KEBIDANAN

No.	**Komponen**	**Isi**
1	No. Stasiun	1
2	Judul	Asuhan Neonatus: Edukasi Pemenuhan Nutrisi pada Bayi
3	Kasus	Cara mengeluarkan/ Memerah ASI
4	Tujuan	Untuk mengetahui bahwa peserta dapat menunjukkan kriteria sebagai calon bidan yang kompeten dalam: mempraktikkan Edukasi Cara mengeluarkan/ Memerah ASI
5	Kompetensi	1. Anamnesis 2. Pemeriksaan fisik dan/atau laboratorium sederhana 3. **Perumusan diagnosis dan/atau masalah** 4. Prosedur tindakan klinis 5. **KIE/konseling** 6. Kolaborasi/rujukan

No.	Komponen	Isi
		7. **Perilaku profesional**
6	Soal: Skenario dan tugas peserta ujian	SKENARIO KLINIK Seorang perempuan, membawa bayinya yang berusia 3 hari datang ke TPMB dengan keluhan khawatir tidak bisa memberikan ASI secara eksklusif kepada bayinya karena puting susu datar. Hasil anamnesis: Bayi lahir normal di PONED dengan usia kehamilan 38 minggu, BB lahir 3000 gram, PB 50 cm, LK 30 cm, lingkar dada 32 cm, bayi susah menyusu dan rewel. TUGAS 1. Sampaikan diagnosis dan/atau masalah kasus tersebut! 2. Berikan KIE kepada ibu/keluarga cara mengeluarkan/ memerah ASI!
7	Instruksi penguji	INSTRUKSI UMUM 1. Pastikan identitas peserta ujian sesuai dengan kartu ujian. 2. Tulislah nomor peserta berdasarkan jumlah peserta yang ikut: a. Ujian institusi-2 digit jika peserta berjumlah 01–99-3 digit jika peserta berjumlah 100–999-4 digit terakhir jika menggunakan NIM peserta b. Ujian nasional-4 digit jika peserta berjumlah ribuan- atau 4 digit terakhir bila nomor mengikutkan kode area dan lebih dari 4 angka 3. Amati peserta dan beri penilaian pada lembar penilaian yang disesuaikan dengan format penilaian: - Actual mark (0/1/2/3) - Global rating (1/2/3/4) 4. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interaksi apa pun kepada peserta selain yang ditentukan. 5. Taatilah peraturan dan laksanakan tugas sebagai penguji OSCE. INSTRUKSI KHUSUS 1. Perumusan diagnosis dan/atau masalah yang diharapkan dari peserta yaitu: Neonatus Cukup Bulan Sesuai Masa Kehamilan (NCB SMK) 3 hari *postnata*l/ Normal

No.	Komponen	Isi
		2. Jika peserta menyatakan akan memberikan edukasi cara mengeluarkan/ memerah ASI, diharapkan informasi yang diberikan meliputi (Heryani, 2019): 1) Siapkan: gelas/ cangkir tertutup 2) Cuci tangan ibu sebelum memegang mammae 3) Cari posisi yang nyaman, duduk atau berdiri dengan santai 4) Pegang cangkir yang bersih untuk menampung ASI 5) Condongkan badan ke depan dan sangga mammae dengan tangan 6) Letakkan ibu jari pada batas atas areola mammae dan letakkan jari telunjuk pada batas areola bagian bawah 7) Tekan kedua jari ini ke dalam ke arah dinding dada tanpa menggeser letak kedua jari tadi 8) Pijat daerah di antara kedua jari tadi ke arah depan sehingga akan memerah dan mengeluarkan ASI. Jangan menekan, memijat atau menarik puting susu karena ini tidak akan mengeluarkan ASI dan akan menyebabkan rasa sakit. 9) Ulangi gerakan tangan, pijat dan lepas beberapa kali. c) Setelah pancaran ASI berkurang, pindahkan posisi ibu jari dan telunjuk tadi dengan cara berputar pada sisi-sisi lain dari batas areola dengan kedua jari selalu berhadapan d) Lakukan hal yang sama pada setiap posisi sampai mammae kosong 3. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang ditentukan. 4. Penguji memberikan data tambahan hanya jika diminta atau jika peserta melakukan langkah pemeriksaan yang sesuai.

No.	Komponen	Isi
		INSTRUKSI TAMBAHAN 1. Rapikan alat yang telah digunakan oleh peserta ujian seperti keadaan semula agar siap digunakan oleh peserta berikutnya. 2. Siapkan lembar baru untuk lembar habis pakai dan pastikan lembar yang sudah diisi peserta sebelumnya telah diambil dan diberi identitas peserta.
8	Kebutuhan dan instruksi PS	Instruksi PS: 8. PS berperan sebagai ibu postpartum 3 hari. 9. PS tampak khawatir 10. Bila peserta memberikan edukasi atau konseling, PS merespons kooperatif.
9	Dialog PS	Peserta: Selamat Sore, Bu. PS: Selamat Sore, Bu. Peserta: Saya bidan yang akan memeriksa ibu. Apakah ibu bersedia? PS: Iya, Bu, saya bersedia. Peserta: Apa keluhan utama ibu? PS: Saya khawatir tidak bisa memberikan ASI secara eksklusif kepada bayi saya karena puting susu datar. Peserta: Kemarin melahirkan di mana? PS: Saya melahirkan di PONED Peserta: Apakah persalinannya normal? PS: Yah, Normal Bu. Peserta: Berapa Berat Badan, Panjang Badan, Lingkar Kepala dan Lingkar Dada Bayi waktu lahir? PS: BB waktu lahir 3000 gram, PB 50 cm, LK 30 cm, lingkar dada 32 cm, Peserta: Apa keluhan yang dialami bayi? PS: bayi susah menyusu dan rewel. Peserta: Ibu, persalinannya belum maju dan bayi perlu segera.
10	Kebutuhan manikin	Phantom mammae
11	Kebutuhan laboran	Peran laboran: - Menyiapkan dan merapikan kembali alat serta manikin

No.	Komponen	Isi
		- Memastikan set station siap digunakan peserta berikutnya
12	Kebutuhan alat	1. Tempat tidur/periksa — 1 2. Phantom mammae — 1 3. Gelas/ Cangkir tertutup — 1 4. Tempat sampah — 1 4. Kursi — 2 5. Handrub — 1 botol 6. Kain penutup/selimut — 1 7. Tisu — 1 pack 8. Lembar jawaban peserta — 1 lembar 9. Pena — 1
13	Penulis	Tonasih, SST.,M.Kes.
14	Referensi	Heryani, R. (2019). *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Neonatus Bayi, Balita dan Anak Pra Sekolah* (Pertama). CV. Trans Info Media.

Contoh Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada Cara Mengeluarkan/ Memerah ASI dengan Tangan

Komponen	**Deskripsi**	**Contoh pada Kasus Cara Mengeluarkan/ Memerah ASI dengan Tangan**
Metode penilaian	DOPS merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap keterampilan prosedural. Penilai mengamati tindakan yang dilakukan peserta, lalu memberikan umpan balik segera setelah prosedur selesai. Domain yang lazim dinilai mencakup *informed consent*, persiapan pra-tindakan, kemampuan teknis, komunikasi, profesionalisme, dan keselamatan pasien.	Pembimbing mengamati secara langsung bagaimana mahasiswa melakukan KIE tentang cara mengeluarkan/ memerah ASI dengan tangan, lalu menilai keterampilan mahasiswa saat melakukan tindakan memerah ASI
Tujuan penilaian	Tujuan DOPS pada topik ini adalah menilai kemampuan mahasiswa melakukan KIE tentang cara mengeluarkan/ memerah ASI yang benar agar ASI keluar lebih lancar dan banyak, dengan tetap berpusat pada kenyamanan ibu.	Mahasiswa tidak hanya dinilai dari pengetahuannya tentang memerah ASI melalui KIE, tetapi dari kemampuannya membantu mengeluarkan/ memerah ASI yang benar.
Kasus klinik	Kasus dipilih dari situasi nyata di lahan praktik yang sesuai dengan capaian pembelajaran profesi bidan, khususnya pemenuhan nutrisi pada bayi. *World Health Organization* (WHO) mengingatkan bahwa Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif adalah kunci sukses untuk menurunkan *stunting*	Seorang perempuan, membawa bayinya yang berusia 3 hari datang ke TPMB dengan keluhan khawatir tidak bisa memberikan ASI secara eksklusif kepada bayinya karena puting susu datar. Hasil anamnesis: Bayi lahir normal di PONED dengan usia kehamilan 38 minggu, BB lahir 3000 gram, PB 50 cm, LK 30 cm, lingkar dada 32 cm, bayi susah menyusu dan rewel.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Cara Mengeluarkan/ Memerah ASI dengan Tangan
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Pada DOPS, mahasiswa diamati saat melakukan prosedur atau rangkaian tindakan klinik tertentu, bukan sekadar berdiskusi tentang kasus. Pada topik ini, keterampilan yang relevan antara lain melakukan KIE tentang pemenuhan nutrisi pada bayi dengan cara mengeluarkan/ memerah ASI	Mahasiswa memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan dan prosedur konseling, meminta persetujuan, komunikasi selama tindakan, memberi perhatian, memulai konseling, memberi kesempatan menanyakan kembali, melakukaan umpan balik, memberi kesempatan mengambil keputusan, menjaga privasi, merangkum/ menyimpulkan materi konseling.
Aspek yang dinilai	Aspek yang dinilai meliputi pemahaman tentang pengertian memerah ASI, tujuan, persiapan alat, persiapan diri dan urutan tindakan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu melakukan KIE tentang pemenuhan nutrisi pada bayi yang meliputi pengertian memerah ASI, tujuan, persiapan alat, persiapan diri dan urutan tindakan.
Fokus observasi pembimbing	Fokus observasi pembimbing adalah mutu performa nyata mahasiswa saat melakukan KIE tentang pemenuhan nutrisi pada bayi dengan cara mengeluarkan/ memerah ASI dengan benar	Pembimbing memerhatikan apakah mahasiswa dapat melakukan KIE tentang pemenuhan nutrisi pada bayi dengan cara mengeluarkan/ memerah ASI dengan benar.
Umpan balik	Umpan balik dalam DOPS diberikan segera setelah observasi dan berisi apa yang sudah efektif serta apa yang perlu diperbaiki. Form DOPS juga menekankan komentar assessor mengenai kekuatan, area yang perlu ditingkatkan, dan rencana perbaikan.	Pembimbing dapat menyampaikan bahwa mahasiswa sudah baik dalam Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE), tetapi masih perlu meningkatkan kelengkapan penjelasan kepada ibu dan keluarga.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Cara Mengeluarkan/ Memerah ASI dengan Tangan
Keputusan penilaian	Dalam buku ajar ini, hasil DOPS dapat diringkas menjadi kompeten, perlu supervisi, atau remedial. Keputusan ditetapkan berdasarkan ketepatan langkah, keselamatan pasien, komunikasi, dan kemampuan melakukan KIE dengan benar.	Mahasiswa dinyatakan kompeten apabila mampu melakukan KIE secara runtut, dan tepat. Mahasiswa dinyatakan perlu supervisi apabila langkah utama sudah benar tetapi masih memerlukan arahan. Mahasiswa dinyatakan remedial apabila gagal melakukan KIE cara mengeluarkan/ memerah ASI.
Makna dalam OBE	DOPS memberikan bukti autentik bahwa mahasiswa mampu menunjukkan capaian pembelajaran pada level does karena performanya diamati langsung saat melakukan tindakan klinik. Observasi langsung pada pasien nyata dan umpan balik segera menjadikan DOPS sangat sesuai untuk pembelajaran berbasis kompetensi.	Pada kasus pemenuhan nutrisi pada bayi, mahasiswa dinilai bukan hanya memahami teori, tetapi mampu melakukan KIE tentang mengeluarkan/ memerah ASI yang benar

Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

- OSCE + DOPS
- Catatan kasus singkat
- Refleksi patient safety
- Feedback CI/dosen

Catatan untuk penulis:

- Bukan sekali ujian
- Bukti konsistensi kompetensi

Tabel 3. 3 Portofolio pada Edukasi Orang Tua: Perawatan Bayi Di Rumah, Tanda Bahaya, Dan Kapan Kembali Ke Fasyankes

Komponen	**Deskripsi**	**Contoh pada Kasus Cara Mengeluarkan/ Memerah ASI dengan Tangan**
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu, bukan hanya dari satu kali ujian.	Pada topik Edukasi Orang Tua: Perawatan Bayi di Rumah, Tanda Bahaya, dan Kapan Kembali Ke Fasyankes, portofolio memuat bukti bahwa mahasiswa mampu melakukan edukasi: Perawatan Bayi di Rumah, antara lain: Memandikan Bayi, Perawatan Tali Pusat, Pemenuhan Nutrisi pada Bayi, Menyendawakan Bayi, Pijat Bayi, Kesegaran Jasmani (Olah Raga dan Rekreasi), Merawat Gigi Bayi, Tanda Bahaya dan Kapan Kembali ke Fasyankes
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik.	Mahasiswa tidak hanya menunjukkan bahwa ia tahu tentang Perawatan Bayi di Rumah, Tanda Bahaya, dan Kapan Kembali Ke Fasyankes, portofolio memuat bukti bahwa mahasiswa mampu melakukan edukasi: Perawatan Bayi di Rumah, antara

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Cara Mengeluarkan/ Memerah ASI dengan Tangan
		lain: Memandikan Bayi, Perawatan Tali Pusat, Pemenuhan Nutrisi pada Bayi, Menyendawakan Bayi, Pijat Bayi, Kesegaran Jasmani (Olah Raga dan Rekreasi), Merawat Gigi Bayi, Tanda Bahaya dan Kapan Kembali ke Fasyankes tetapi juga mampu melakukan KIE kepada klien langsung tentang Perawatan Bayi di Rumah, Tanda Bahaya, dan Kapan Kembali Ke Fasyankes, portofolio memuat bukti bahwa mahasiswa mampu melakukan edukasi: Perawatan Bayi di Rumah, antara lain: Memandikan Bayi, Perawatan Tali Pusat, Pemenuhan Nutrisi pada Bayi, Menyendawakan Bayi, Pijat Bayi, Kesegaran Jasmani (Olah Raga dan Rekreasi), Merawat Gigi Bayi, Tanda Bahaya dan Kapan Kembali ke Fasyankes
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS dapat menjadi bagian penting dalam portofolio karena memberikan bukti keterampilan terstruktur di laboratorium dan bukti performa nyata di lahan praktik.	OSCE dapat memuat hasil ujian keterampilan interpretasi profesional, Perawatan Bayi di Rumah, antara lain: Pemenuhan Nutrisi pada Bayi dengan melakukan mengeluarkan/ memerah ASI. DOPS memuat hasil observasi langsung saat mahasiswa melakukan penilaian KIE cara melakukan mengeluarkan/ memerah ASI.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Cara Mengeluarkan/ Memerah ASI dengan Tangan
Catatan kasus singkat	Catatan kasus singkat berisi ringkasan kasus pasien yang pernah ditangani mahasiswa, data penting, masalah kebidanan, tindakan utama, dan hasil yang dicapai.	Mahasiswa menuliskan ringkasan kasus seorang perempuan, membawa bayinya yang berusia 3 hari datang ke TPMB dengan keluhan khawatir tidak bisa memberikan ASI secara eksklusif kepada bayinya karena puting susu datar, BB lahir 3000 gram, PB 50 cm, LK 30 cm, lingkar dada 32 cm, bayi susah menyusu dan rewel. Memberikan KIE tentang pemenuhan nutrisi pada bayi dengan cara mengeluarkan/ memerah ASI
Refleksi patient safety	Refleksi patient safety menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi kesalahan, dan menyusun langkah pencegahan dalam asuhan kebidanan.	Mahasiswa merefleksikan pentingnya melakukan KIE dengan benar dan tepat serta menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh klien.
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari Clinical Instructor (CI) atau dosen menjadi bukti pembinaan yang menunjukkan area kekuatan dan area yang masih perlu ditingkatkan.	CI menuliskan bahwa mahasiswa sudah baik dalam melakukan KIE tentang pemenuhan nutirsi pada bayi melalui cara mengeluarkan/ memerah ASI
Karakteristik penilaian	Portofolio bukan penilaian sekali selesai, tetapi kumpulan bukti yang dibangun secara berulang dan berkesinambungan. Penekanan utamanya adalah konsistensi performa mahasiswa.	Mahasiswa dinilai bukan hanya dari satu kasus KIE pemenuhan nutrisi pada bayi, tetapi dari beberapa pengalaman belajar yang menunjukkan bahwa ia konsisten mampu melakukan KIE pemenuhan nutrisi pada bayi

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Cara Mengeluarkan/ Memerah ASI dengan Tangan
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio memperlihatkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan mutu performa pada berbagai kesempatan praktik dan pada waktu yang berbeda.	Dari hasil OSCE, DOPS, catatan kasus, refleksi, dan umpan balik, terlihat bahwa mahasiswa secara konsisten mampu menggunakan profession, Edukasi Orang Tua: Perawatan Bayi di Rumah, Tanda Bahaya, dan Kapan Kembali Ke Fasyankes, portofolio memuat bukti bahwa mahasiswa mampu melakukan edukasi: Perawatan Bayi di Rumah, antara lain: Memandikan Bayi, Perawatan Tali Pusat, Pemenuhan Nutrisi pada Bayi, Menyendawakan Bayi, Pijat Bayi, Kesegaran Jasmani (Olah Raga dan Rekreasi), Merawat Gigi Bayi, Tanda Bahaya dan Kapan Kembali ke Fasyankes.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, portofolio memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tidak hanya dimiliki secara teoritis, tetapi benar-benar tampak dalam performa yang berulang, berkembang, dan terdokumentasi.	Pada topik KIE pemenuhan nutrisi pada bayi portofolio menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya paham konsep, tetapi juga konsisten mampu menerapkannya dalam praktik kebidanan nyata.

Tabel 3. 4 Case Report pada Edukasi Orang Tua: Perawatan Bayi Di Rumah, Tanda Bahaya, dan Kapan Kembali ke Fasyankes

Komponen	**Deskripsi**	**Contoh pada Kasus Cara Mengeluarkan/ Memerah ASI dengan Tangan**
Hakikat case report	Case report merupakan laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien yang ditangani mahasiswa selama praktik klinik. Dalam OBE, case report berfungsi sebagai bukti kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan mendokumentasikan kasus secara ilmiah dan klinis.	Mahasiswa menyusun laporan singkat tentang seorang perempuan, membawa bayinya yang berusia 3 hari datang ke TPMB dengan keluhan khawatir tidak bisa memberikan ASI secara eksklusif kepada bayinya karena puting susu datar, BB lahir 3000 gram, PB 50 cm, LK 30 cm, lingkar dada 32 cm, bayi susah menyusu dan rewel
Tujuan	Case report bertujuan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data pengkajian, masalah kebidanan, rencana tindakan, implementasi, dan evaluasi hasil asuhan.	Mahasiswa tidak hanya menuliskan data ibu, tetapi juga menjelaskan tentang pemenuhan nutrisi pada bayi yang meliputi pengertian memerah ASI, tujuan, persiapan alat, persiapan diri dan urutan tindakan.
Isi laporan	Isi case report biasanya mencakup identitas singkat pasien, keluhan utama, data subjektif dan objektif, analisis masalah, diagnosis/masalah kebidanan, tindakan, implementasi, evaluasi, dan pembelajaran dari kasus.	Pada kasus ini, mahasiswa menuliskan keluhan khawatir tidak bisa memberikan ASI secara eksklusif kepada bayinya karena puting susu datar, BB lahir 3000 gram, PB 50 cm, LK 30 cm, lingkar dada 32 cm, bayi susah menyusu dan rewel, Tindakan melakukan KIE pemenuhan nutrisi pada bayi dengan cara mengeluarkan/ memerah ASI
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan pengkajian, relevansi analisis	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu melakukan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Cara Mengeluarkan/ Memerah ASI dengan Tangan
	masalah, logika penalaran klinik, ketepatan tindakan awal, dan kemampuan mengevaluasi hasil asuhan.	tindakan melakukan KIE pemenuhan nutrisi pada bayi dengan cara mengeluarkan/ memerah ASI.
Nilai edukatif	Case report membantu mahasiswa mengembangkan clinical reasoning, keterampilan dokumentasi, dan kebiasaan merefleksikan praktik klinik secara ilmiah.	Dari kasus pemenuhan nutrisi pada bayi dengan cara mengeluarkan/ memerah ASI, mahasiswa belajar bahwa profession, ketepatan dan kejelasan bahasa merupakan inti keselamatan dalam melakukan KIE
Makna dalam OBE	Dalam OBE, case report menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori ke dalam analisis kasus nyata secara sistematis dan bertanggung jawab.	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya memahami konsep KIE, tetapi juga mampu menyusun laporan kasus yang menggambarkan asuhan kebidanan secara utuh.

Tabel 3. 5 Refleksi Patient Safety pada Edukasi Orang Tua: Perawatan Bayi di Rumah, Tanda Bahaya, dan Kapan Kembali Ke Fasyankes

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Cara Mengeluarkan/ Memerah ASI dengan Tangan
Hakikat refleksi patient safety	Refleksi patient safety merupakan tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi masalah, dan merencanakan tindakan pencegahan.	Pada kasus KIE, mahasiswa merefleksikan bahwa ketidaktepatan dan ketidakjelasan bahasa dapat menyebabkan perbedaan persepsi dan miskomunikasi.
Tujuan	Refleksi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran	Mahasiswa memahami bahwa kesalahan kecil, seperti salah

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Cara Mengeluarkan/ Memerah ASI dengan Tangan
	mahasiswa bahwa keselamatan pasien merupakan bagian penting dari setiap tindakan kebidanan.	memberikan informasi, ketidakjelasan bahasa dapat berdampak pada kesalahpahaman ibu
Fokus refleksi	Fokus refleksi meliputi identifikasi risiko, analisis penyebab, tindakan pencegahan, dan pembelajaran yang diperoleh mahasiswa dari pengalaman klinik.	Mahasiswa menuliskan bahwa risiko utama pada kasus ini adalah ketidakpahaman klien tentang informasi kesehatan yang disampaikan oleh mahasiswa
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa perlu menunjukkan kemampuan mengenali situasi yang berpotensi membahayakan pasien.	Risiko yang dapat diidentifikasi antara lain kesalahan informasi, bahasa susah dipahami oleh klien
Tindakan pencegahan	Mahasiswa menjelaskan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko keselamatan pasien.	Mahasiswa menuliskan pentingnya penggunaan profession secara konsisten.
Pembelajaran mahasiswa	Refleksi harus menunjukkan apa yang dipelajari mahasiswa dan bagaimana hal itu akan memengaruhi praktik berikutnya.	Mahasiswa menyadari bahwa pada KIE Edukasi Orang Tua: Perawatan Bayi di Rumah, Tanda Bahaya, dan Kapan Kembali Ke Fasyankes adalah bagian penting dari praktik bidan yang aman.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, refleksi patient safety menunjukkan perkembangan sikap professional, tanggung jawab klinik, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa terhadap keselamatan pasien.	Mahasiswa membuktikan bahwa ia tidak hanya melakukan tindakan, tetapi juga mampu mengevaluasi risiko dan meningkatkan kualitas praktik kebidanan secara berkelanjutan.

D. Ringkasan

Komunikasi kesehatan ialah proses penyampaian pesan yang berisi hal-hal yang mempunyai kaitan dengan kesehatan dan disampaikan oleh pemberi pesan tersebut kepada penerimanya menggunakan atau melalui berbagai media yang dianggapnya tepat. Informasi adalah pesan yang disampaikan atau keterangan gagasan maupun kenyataan kenyataan yang perlu untuk diketahui oleh masyarakat. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat dapat berupa sebuah edukasi. Edukasi pada bidang kesehatan ialah salah satu kompetensi yang dituntut dari tenaga kesehatan dikarenakan merupakan salah satu pernana yang harus dilakukan dalam setiap memberikan pelayanan kesehatan baik pelayanan kepada individu, pelayanan ke keluarga, pelayanan kelompok maupun pelayanan ke masyarakat. Tenaga kesehatan harus mampu melaksanakan dan menyampaikan informasi dan edukasi kepada masyarakat sehingga tenaga kesehatan tersebut harus mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dalam bidang Kesehatan.

Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) yang diberikan kepada orang tua meliputi: Perawatan Bayi di Rumah (Memandikan Bayi, Perawatan Tali Pusat, Pemenuhan Nutrisi pada Bayi, Menyendawakan Bayi, Pijat Bayi, Kesegaran Jasmani (Olah Raga dan Rekreasi), Merawat Gigi Bayi, Tanda Bahaya pada bayi dan Kapan Kembali ke Fasyankes.

Tabel 3. 6 Red Flags & Eskalasi

Red Flags	**Makna Klinis**	**Tindakan Eskalasi**
Sesak Napas	Bayi baru lahir mengalami kesulitan bernapas, ditandai dengan laju pernapasan > 60 x/ menit	Bila bayi mengalami sesak segera periksakan ke dokter untuk mendapatkan pengobatan yang tepat
Panas atau suhu bayi rendah	Panas, khususnya ketika suhu tubuh bayi naik > 38 derajat Celcius. Sebaliknya, suhu tubuh rendah yang berbahaya < 36 derajat celcius juga dapat menandakan potensi ancaman bagi kesehatan bayi baru lahir.	• Berikan obat penurun panas yang sesuai. • Jika demam bayi tidak kunjung turun, segera bawa bayi ke fasilitas kesehatan untuk mendapat pertolongan lebih lanjut.

Red Flags	Makna Klinis	Tindakan Eskalasi
Malas minum	Bisa disebabkan refleks hisap selama menyusui lemah, disertai dengan rewel dan muntah yang sering menjadi indikasi masalah mendasar yang memerlukan perhatian segera.	• Jika ibu memiliki puting susu datar: dicoba menggunakan pompa ASI. Pompa ASI akan membantu mengangkat putting sebelum menyusui • Posisi menyusui yang salah dapat membuat bayi merasa tidak nyaman: Anjurkan untuk melakukan posisi menyusui yang benar seperti memastikan kepala bayi lebih tinggi dari tubuhnya agar memudahkannya untuk menelan.
Tali pusat kemerahan, bengkak, dan mengeluarkan cairan berbau busuk	Menunjukkan adanya infeksi pada tali pusat.	• Usahakan tali pusat tetap kering, jaga agar tidak basah dan lembab karena kondisi lembab memicu pertumbuhan kuman yang menyebabkan infeksi (umumnya timbul pada kebersihan yang tidak terjaga baik). • Infeksi tali pusat harus segera diobati. Infeksi ringanpun jika mendera tali pusat bisa berubah menjadi sesuatu yang serius
Kejang pada bayi baru lahir	Gangguan aktivitas listrik di otak yang terjadi secara spontan dan dan tidak terkendali.	• Amati kondisinya saat kejang, terutama bila dia kesulitan bernapas atau wajahnya pucat dan kebiruan. • Ini menandakan bahwa ia kekurangan oksigen dan membutuhkan penanganan medis secepatnya
Menangis terus menerus tanpa	Kondisi ketika bayi menangis dalam durasi	• Menenangkan atau mengatasi bayi menangis

Red Flags	Makna Klinis	Tindakan Eskalasi
penyebab yang jelas	cukup lama, lebih dari 3 jam sehari, hampir setiap hari, dan sulit ditenangkan	• Mencari tahu lingkungan seperti apa yang membuatnya lebih nyaman • Jika bayi menangis terus tanpa henti, bisa jadi ada sesuatu yang perlu orang tua waspadai.

Form Checklist

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / Skill Lab : _____

1. Mahasiswa mampu memberikan edukasi kepada orang tua tentang perawatan bayi di rumah meliputi memandikan bayi, perawatan tali pusat, pemenuhan nutrisi pada bayi, menyendawakan bayi, pijat bayi, kesegaran jasmani, merawat gigi bayi)
2. Mahasiswa mampu memberikan edukasi kepada orang tua tentang tanda bahaya pada bayi
3. Mahasiswa mampu memberikan edukasi kepada orang tua tentang kapan Kembali ke fasyankes

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan pengertian komunikasi	☐	☐	_____
2	Saya sudah bisa menjelaskan pengertian informasi	☐	☐	_____
3	Saya sudah bisa menjelaskan pengertian edukasi	☐	☐	_____
4	Saya sudah bisa melakukan edukasi tentang memandikan bayi	☐	☐	_____
5	Saya sudah bisa melakukan edukasi tentang perawatan tali pusat	☐	☐	_____
6	Saya sudah bisa melakukan edukasi tentang pemenuhan nutris pada bayi yang meliputi: a. Pengertian ASI eksklusif b. Kebutuhan minum ASI neonatus tiap harinya c. Prinsip umum menyusui d. Cara menyusui yang benar e. Teknik menyusui bayi yang benar f. Berbagai posisi menyusui g. Tanda bayi cukup ASI h. Cara mengeluarkan/ memerah ASI i. Cara menyimpan ASI j. Cara Pijat Oksitosin			

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
7	Saya sudah bisa melakukan edukasi tentang menyendawakan bayi	☐	☐	_____
8	Saya sudah bisa melakukan edukasi tentang pijat bayi	☐	☐	_____
9	Saya sudah bisa melakukan edukasi tentang kesegaran jasmani	☐	☐	_____
10	Saya sudah bisa melakukan edukasi tentang merawat gigi bayi	☐	☐	_____
11	Saya sudah bisa melakukan edukasi tentang tanda bahaya pada bayi	☐	☐	_____
12	Saya sudah bisa melakukan edukasi tentang kapan kembali ke fasyankes	☐	☐	_____

Refleksi singkat mahasiswa:

Referensi

Anggeriani, R., Lamdayani, R., Tinggi, S., Kesehatan, I., & Palembang, A. (2021). *Pengaruh perawatan tali pusat secara terbuka dengan lamanya pelepasan tali pusat pada bayi baru lahir di bpm lismarini*. *6*(September), 126–132.

Armini, Sriasih, M. (2017). *Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi, Balita & Anak Prasekolah* (A. Pramesta (ed.); I). ANDI OFFSET.

Choice, M. (n.d.). *Agar Bayi Tak Tersedak, Lakukan 6 Posisi Menyusui yang Benar*. Retrieved March 1, 2026, from https://mamaschoice.id/article/6-posisi-menyusui-yang-benar/

Delima, M., Kartina, N., & Rosya, E. (2018). *PENGARUH MENYENDAWAKAN BAYI SETELAH DISUSUI DENGAN KEJADIAN REGURGITASI PADA BAYI USIA 0 - 6BULAN*.

Hastuti, Fuji, Hidayah, Fika Nurul, Magasida, D. (2024). Pengaruh Pijat Bayi Terhadap Kualitas Tidur Bayi Usia 0-6 Bulan Di Wilayah Puskesmas Astanajapura Kabupaten Cirebon. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, *5*(4), 11817–11822.

Heryani, R. (2019). *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Neonatus Bayi, Balita dan Anak Pra Sekolah* (Pertama). CV. Trans Info Media.

Jannah, M., Nawangsari, D., & Akaputri, D. E. (2025). *Efektivitas Pijat Bayi Terhadap Peningkatan Motorik Pada Bayi Usia 6- 12 Bulan di Klinik " A " Bogor*. *15*(2), 177–182.

Kartini, A., Kurnia, S., & Puteri, S. (2024). Hubungan Pijat Oksitosin Terhadap Proses Pengeluaran Asi Pada Ibu Post Partum Di Puskesmas Pattoppakang Kabupaten Takalar. *J Ur Nal K e p e r a w a t a n M u h a m m a d i y a H*, *9*(2), 29–35.

Lahu, Yolanda Ester & Yeni, R. I. (2024). Efektivitas Pijat Oksitosin Untuk Meningkatkan Produksi Asi Pada Ibu Post Sectio Caesarea. *Jurnal Menara Medika*, *7*(1), 118–124.

Lisca, M. S. dkk. (2025). *Buku Ajar Asuhan Kebidanan pada Masa Persalinan dan Bayi Baru Lahir* (S. Syafei, Abdullah & Salsabila (ed.); Pertama). UIMA PRESS.

Maritalia, D. (2017). *Asuhan Kebidanan pada Ibu Nifas*. Gosyen Publishing.

Maryani, D. (2024). Study Literatur Review: Pengaruh Pijat Bayi Terhadap Tumbuh Kembang Bayi. *Jurnal Ilmu Kesehatan Karya Bunda Husada*, *10*(2), 6–16.

Merida, Yunri & Hanifa, F. N. (2021). Pengaruh pijat bayi dengan tumbuh kembang bayi. *Jurnal Kesehatan*, *10*(2), 27–32. https://doi.org/10.37048/kesehatan.v11i1.424

Naziroh, Y. (2017). Pengaruh Pijat Oksitosin Terhadap Pengeluaran ASI pada Ibu Postpartum di BPM Pipin Heriyanti Yogyakarta. *Jurnal Media Ilmu*

Kesehatan, *6*(1).

Noorbaya, Siti, D. (2020). *Panduan Belajar Asuhan Neonatus Bayi, Balita dan Anak Prasekolah* (I). Gosyen Publishing.

Paramitha Amelia Kusumawardani, Paramitha Amelia & Azizah, N. (2021). *Buku Ajar Konsep Kependudukan Dan KIE Dalam Pelayanan KB* (M. T. Multazam, M. Tanzil & Wardana (ed.)). UMSIDA Press.

Purwati. (2018). Perbedaan Pijat Oksitosin Dengan Kompres Hangat Terhadap Produksi ASI pada ibu Post Operasi Sectio Caesaria di Rawat inap A RS Wava Husada. *Jurnal Ilmu Kebidanan Dan Kesehatan*, *8*(1).

Rizki, N. (2023). *Teknik Pijat Bayi Lengkap dan Gambar*. 17 Maret 2023. https://id.scribd.com/document/631871544/3-Langkah-langkah-Pijat-Bayi

Sartika, W., Herlina, S., Qomariah, S., & Abdurrab, U. (2023). *Pengaruh pijat bayi terhadap pertumbuhan bayi*. *15*(1).

Sutanto, A. V. (2018). *Asuhan Kebidanan Nifas & Menyusui (Teori dalam Praktik Kebidanan Profesional)*. PUSTAKA BARU PRESS.

Timisela, J., Ratulangi, J. I. L., Hitijahubessy, C. N. M., & Eny, S. (2023). *Pengaruh Perawatan Tali Pusat Terbuka Terhadap Risiko Infeksi Pada Bayi Baru Lahir : Studi Kasus*. *4*(2), 130–136.

Utami, M. W. (2020). *PENGARUH PIJAT BAYI TERHADAP KUALITAS TIDUR BAYI USIA 3-6 BULAN*. 9–18.

Wahyuningsih, R., & Kusumadewi, R. R. (2025). *Pengaruh Pijat Oksitosin Terhadap Pengeluaran ASI Pada Ibu Nifas The Effect of Oxytocin Massage on Breast Milk Explosion for Postpartum Mother*. *12*(1).

WHO. (n.d.). *Bagan Penilaian, Klasifikasi dan Tindakan bayi muda umur kurang dari 2 bulan (MTBM)*. Retrieved March 17, 2026, from https://platform.who.int/docs/default-source/mca-documents/policy-documents/guideline/IDN-MN-62-02-GUIDELINE-2018-ind-Integrated-Management-on-Young-Baby.pdf

Widhawati, Riswahyuni & Ramawati, A. (2020). Pengaruh Pijat Oksitosin Terhadap Kelancaranasi (Air Susu Ibu) Pada Ibu Nifas Di BPM (Bidan Praktek Mandiri) Bidan Dian. *Jurnal Kesehatan STIKes IMC Bintaro*, *35*, 43–47.

Yanti, D., Fatonah, S., & Mulyasari, R. (2022). *PENGARUH PIJAT BAYI TERHADAP PENINGKATAN PERKEMBANGAN MOTORIK KASAR PADA BAYI USIA 0-TIGA BULAN*. *08*(2), 148–156. https://doi.org/10.35329/jkesmas.v8i2.2857

Profil Penulis



Lida Khalimatus Sa'diya, SSiT., Bd., M.Kes.

lahir di Sidoarjo tahun 1980. Penulis merupakan dosen Program Studi Sarjana Kebidanan Universitas Bina Sehat PPNI Mojokerto. Penulis menempuh Pendidikan perguruan tinggi pada program D-III Kebidanan di Akademi Kebidanan Siti Khodijah Sepanjang Sidoarjo (2001), D-IV Bidan Pendidik di Universitas Gadja Mada Yogyakarta (2005) dan S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat di Universitas Sebelas Maret Surakarta (2012).

Penulis merupakan anggota IBI (Ikatan Bidan Indonesia) Cabang Kabupaten Mojokerto. Penulis memiliki concern terhadap issue – issue terkini mengenai kesehatan bayi, balita dan anak serta Keluarga Berencana. Penulis juga sebagai bidan praktek mandiri yang mengembangkan layanan holistik. Penulis juga aktif dalam kegiatan penelitian dimana hasil penelitian telah banyak dipublikasikan ke dalam jurnal penelitian maupun prosiding penelitian yang bereputasi baik berskala nasional maupun internasional. Email: lidarafi2@gmail.com.

Profil Penulis



Annisa Ridlayanti, S.Keb., Bd., M.Keb.

Lahir di Bandung, 24 Februari 1985. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, Universitas Airlangga Surabaya tahun 2012.

Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Brawijaya Malang dan lulus tahun pada tahun 2016. Saat ini sedang menempuh Studi S3 Ilmu Kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2006-2009 sebagai praktisi bidan di Rumah Bersalin Afiatun Hasanah Kota Bandung. Tahun 2007-2009 bekerja sebagai praktisi bidan honorer di Puskesmas Garuda Kota Bandung. Tahun 2009-2012 bekerja sebagai laboran dan tenaga pengajar di Akademi Kebidanan Aisyiyah Bandung. 2012 hingga saat ini bekerja sebagai dosen kebidanan, peneliti, dan motivator. Saat ini penulis bekerja di Universitas Aisyiyah Bandung dan mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir, Asuhan Kebidanan Holistik Islami, Asuhan Kebidanan Muslimah, Asuhan Kebidanan Bayi, Balita, Anak dan Prasekolah, Asuhan Kebidanan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal, Metodologi Riset 1, Metodologi Penelitian, Statistika Penelitian. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, *international conference*, pengabdian masyarakat, serta aktif dalam berorganisasi. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: annisa_ridlayanti@yahoo.com.

Motto: *"Hidup karena Allah, Kuatkan Iman, Kembangkan Ilmu, Hadirkan Kemaslahatan, Berkarya untuk umat, Menuju ridha-Nya".*

Profil Penulis



Tonasih, SST., M.Kes.

Lahir di Brebes pada tahun 1981. Penulis adalah Dosen Program Studi Sarjana Kebidanan di Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan (UMMADA) Cirebon. Penulis telah menempuh Pendidikan pada Program Studi Diploma III Kebidanan di Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya Prodi Kebidanan Cirebon (Lulus Tahun 2003), Diploma IV Bidan Pendidik di Poltekkes Kemenkes Bandung (Lulus Tahun 2005) dan S2 Kesehatan Masyarakat di Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang (Lulus Tahun 2013).

Penulis aktif dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi antara lain Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Dalam bidang Pendidikan penulis sebagai Dosen Asuhan Kebidanan Nifas dan telah menghasilkan beberapa Buku Ajar.

Dalam bidang Penelitian penulis juga telah melakukan penelitian dan mempublikasikannya baik dalam jurnal Nasional Tidak Terakreditasi maupun Jurnal Nasional Terakreditasi.

Dalam bidang Pengabdian kepada Masyarakat juga telah melakukan beberapa kegiatan yang sesuai dengan bidang keahlian antara lain:

Penulis dapat dihubungi melalui alamat email: asih_islamiyah@yahoo.co.id

Motto: **“Hidup adalah Perjuangan”**

Sinopsis

Buku Ajar *Pelayanan Neonatal Esensial: Termoregulasi, ASI, Pencegahan Infeksi, dan Pemantauan* disusun sebagai sumber pembelajaran yang memberikan pemahaman komprehensif mengenai pelayanan dasar pada bayi baru lahir. Masa neonatal merupakan periode yang sangat penting karena bayi sedang beradaptasi dengan kehidupan di luar rahim. Pada masa ini, berbagai gangguan kesehatan dapat terjadi secara cepat sehingga diperlukan pemantauan yang teratur, edukasi yang tepat kepada orang tua, serta kemampuan tenaga kesehatan dalam mendeteksi dini tanda bahaya.

Buku ini membahas pentingnya kunjungan neonatus terjadwal sebagai upaya pemantauan kesehatan bayi secara berkesinambungan. Melalui kunjungan tersebut, tenaga kesehatan dapat menilai kondisi umum bayi, suhu tubuh, kemampuan menyusu, tanda infeksi, serta berbagai parameter lain yang berkaitan dengan keselamatan neonatus. Pemantauan yang dilakukan secara tepat dapat membantu menemukan masalah sejak dini sehingga bayi dapat segera memperoleh penanganan sesuai kebutuhan.

Selain itu, buku ini juga menguraikan pemantauan pertumbuhan neonatus melalui penilaian berat badan, pola eliminasi, dan status hidrasi. Ketiga aspek tersebut menjadi indikator penting dalam menilai kecukupan asupan, keberhasilan pemberian ASI, serta kondisi kesehatan bayi secara umum. Pemahaman terhadap perubahan berat badan, frekuensi buang air kecil dan buang air besar, serta tanda-tanda dehidrasi sangat diperlukan agar tenaga kesehatan dan orang tua mampu mengenali kondisi normal maupun kondisi yang memerlukan perhatian khusus.

Pembahasan dalam buku ini juga menekankan pentingnya edukasi kepada orang tua mengenai perawatan bayi di rumah. Orang tua perlu dibekali pengetahuan tentang cara menjaga kehangatan bayi, mendukung pemberian ASI, menjaga kebersihan, mencegah infeksi, serta mengenali tanda bahaya pada neonatus. Edukasi yang baik akan membantu keluarga lebih percaya diri dalam merawat bayi baru lahir dan memahami kapan harus segera kembali ke fasilitas pelayanan kesehatan.

Secara keseluruhan, buku ajar ini diharapkan dapat menjadi referensi pembelajaran yang sistematis, aplikatif, dan mudah dipahami oleh mahasiswa, dosen, serta tenaga kesehatan. Melalui materi yang disajikan, pembaca diharapkan mampu memahami prinsip pelayanan neonatal esensial dan menerapkannya dalam praktik pelayanan kesehatan secara aman, tepat, dan berorientasi pada keselamatan bayi.

Buku Ajar Pelayanan Neonatal Esensial: Termoregulasi, ASI, Pencegahan Infeksi, dan Pemantauan disusun sebagai sumber pembelajaran yang memberikan pemahaman komprehensif mengenai pelayanan dasar pada bayi baru lahir. Masa neonatal merupakan periode yang sangat penting karena bayi sedang beradaptasi dengan kehidupan di luar rahim. Pada masa ini, berbagai gangguan kesehatan dapat terjadi secara cepat sehingga diperlukan pemantauan yang teratur, edukasi yang tepat kepada orang tua, serta kemampuan tenaga kesehatan dalam mendeteksi dini tanda bahaya.

Buku ini membahas pentingnya kunjungan neonatus terjadwal sebagai upaya pemantauan kesehatan bayi secara berkesinambungan. Melalui kunjungan tersebut, tenaga kesehatan dapat menilai kondisi umum bayi, suhu tubuh, kemampuan menyusu, tanda infeksi, serta berbagai parameter lain yang berkaitan dengan keselamatan neonatus. Pemantauan yang dilakukan secara tepat dapat membantu menemukan masalah sejak dini sehingga bayi dapat segera memperoleh penanganan sesuai kebutuhan.

Selain itu, buku ini juga menguraikan pemantauan pertumbuhan neonatus melalui penilaian berat badan, pola eliminasi, dan status hidrasi. Ketiga aspek tersebut menjadi indikator penting dalam menilai kecukupan asupan, keberhasilan pemberian ASI, serta kondisi kesehatan bayi secara umum. Pemahaman terhadap perubahan berat badan, frekuensi buang air kecil dan buang air besar, serta tanda-tanda dehidrasi sangat diperlukan agar tenaga kesehatan dan orang tua mampu mengenali kondisi normal maupun kondisi yang memerlukan perhatian khusus.

Pembahasan dalam buku ini juga menekankan pentingnya edukasi kepada orang tua mengenai perawatan bayi di rumah. Orang tua perlu dibekali pengetahuan tentang cara menjaga kehangatan bayi, mendukung pemberian ASI, menjaga kebersihan, mencegah infeksi, serta mengenali tanda bahaya pada neonatus. Edukasi yang baik akan membantu keluarga lebih percaya diri dalam merawat bayi baru lahir dan memahami kapan harus segera kembali ke fasilitas pelayanan kesehatan.

Secara keseluruhan, buku ajar ini diharapkan dapat menjadi referensi pembelajaran yang sistematis, aplikatif, dan mudah dipahami oleh mahasiswa, dosen, serta tenaga kesehatan. Melalui materi yang disajikan, pembaca diharapkan mampu memahami prinsip pelayanan neonatal esensial dan menerapkannya dalam praktik pelayanan kesehatan secara aman, tepat, dan berorientasi pada keselamatan bayi.

Penerbit:
PT OPTIMAL UNTUK NEGERI
Kencana Tower Lt. Mezzanine
Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005
Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

ISBN 978-634-7927-02-6 (PDF)
9 786347 927026